

丛书主编 王绍诚 陆云平

本书主编 顾悦善 郝学君

副主编 (以姓氏笔画为序)

王 松 郭晓原 赵宏伟 崔玉琴

编写人员 (以姓氏笔画为序)

王 松 郝学君 郭晓原 赵宏伟

崔玉琴 顾悦善

出版者的话

生命诚可贵，养生不能少。随着社会的发展，养生保健已成为一种时尚，为了适应这种全新的社会趋势，我们组织编写了这套“全新家庭养生丛书”。

目前，养生保健类图书林林总总，其中，自然不乏上乘之作，精品也非罕见，但大多数不尽人意，存在的通病是读来不解渴，缺乏实用性，甚至无所适从。有鉴于此，这套丛书在策划与编写过程中，突出强调了可操作性和有效性，由富有实践经验的医务人员编写，选取读者最关注的内容，力求作到：告诉您所不知道的，解释您少许知道的，介绍您想知道的。换言之，读到本书，将使您有一种“不一样的感觉”，获取“不一样的收获”，努力作到一书在手，无师自通，学而用之，终生受益。

鉴于祖国医学中养生是一门涉及范畴广、内容繁杂的系统科学，因此，这套系列书暂分为六个分册，包括《推拿养生》、《食疗养生》、《灸法养生》、《中医运动养生》、《中药药酒养生》和《中药外用养生》。

尽管我们的初衷是努力奉献给读者一份精品，然而，毕竟由于多作者执笔，风格难于一致，加之时间仓促，文字疏漏恐难避免，对此，敬望读者批评、雅正。

辽宁科学技术出版社

1996年2月

QUANXIN JIATING YANGSHENG CONGSHU

目录

灸法基本知识	1
灸法的概念	1
灸法的源流	1
灸法的材料	5
灸法的作用与适应症	6
灸法的禁忌症	7
灸法的现代研究概况	8
日本灸法保健养生概况	14
灸法分类与操作	17
灸法的分类	17
艾炷的制作方法	39
施灸的体位选择	39
艾炷灸的操作	41
艾柱灸的壮数	42
灸法的注意事项及灸疮的处理	43
经络与腧穴	45
经络的概念	45
腧穴	45
腧穴的分类	45
腧穴的治疗作用	46
腧穴的取法	47
灸法常用的特定穴	49
灸法常用腧穴	53
督脉常用腧穴	53

1. 长强 (53) 2. 腰俞 (53) 3. 腰阳关 (53)
4. 命门 (54) 5. 悬枢 (55) 6. 脊中 (55)
7. 中樞 (56) 8. 筋缩 (56) 9. 至阳 (56)
10. 灵台 (56) 11. 神道 (57) 12. 身柱 (57)
13. 陶道 (57) 14. 大椎 (57) 15. 哑门 (58)
16. 风府 (58) 17. 脑户 (59) 18. 强间 (60)
19. 后顶 (60) 20. 百会 (60) 21. 前顶 (60)
22. 囟会 (60) 23. 上星 (61) 24. 神庭 (61)
25. 素髻 (62)

任脉常用腧穴 62

1. 曲骨 (62) 2. 中极 (62) 3. 关元 (62)
4. 石门 (64) 5. 气海 (64) 6. 阴交 (64)
7. 神阙 (64) 8. 水分 (65) 9. 下脘 (65)
10. 建里 (65) 11. 中脘 (65) 12. 上脘 (65)
13. 巨阙 (66) 14. 鸠尾 (66) 15. 中庭 (66)
16. 膻中 (66) 17. 玉堂 (67) 18. 紫宫 (67)
19. 华盖 (67) 20. 璇玑 (67) 21. 天突 (67)
22. 廉泉 (68) 23. 承浆 (68)

手太阴肺经穴 68

1. 中府 (68) 2. 云门 (69) 3. 尺泽 (69)
4. 孔最 (69) 5. 列缺 (70) 6. 经渠 (71)
7. 太渊 (71) 8. 鱼际 (71) 9. 少商 (71)

手阳明大肠经穴 72

1. 商阳 (72) 2. 二间 (72) 3. 三间 (73)
4. 合谷 (73) 5. 阳溪 (73) 6. 偏历 (73)
7. 温溜 (74) 8. 下廉 (74) 9. 上廉 (75)
10. 手三里 (75) 11. 曲池 (75) 12. 肘髎 (75)
13. 臂臑 (76) 14. 肩髃 (76) 15. 扶突 (76)

16. 口禾髎 (77) 17. 迎香 (77)

足阳明胃经穴 78

1. 四白 (78) 2. 巨髎 (78) 3. 地仓 (78)
4. 颊车 (79) 5. 下关 (79) 6. 头维 (80)
7. 缺盆 (80) 8. 气户 (81) 9. 膺窗 (81)
10. 乳根 (82) 11. 不容 (82) 12. 承满 (82)
13. 梁门 (82) 14. 关门 (83) 15. 太乙 (83)
16. 天枢 (83) 17. 大巨 (83) 18. 水道 (83)
19. 归来 (84) 20. 髀关 (84) 21. 伏兔 (84)
22. 梁丘 (84) 23. 犊鼻 (85) 24. 足三里 (85)
25. 上巨虚 (86) 26. 条口 (86) 27. 下巨虚 (86)
28. 丰隆 (86) 29. 解溪 (87) 30. 冲阳 (87)
31. 内庭 (87) 32. 厉兑 (87)

足太阴脾经穴 88

1. 隐白 (88) 2. 大都 (88) 3. 太白 (88)
4. 公孙 (89) 5. 三阴交 (89) 6. 地机 (89)
7. 阴陵泉 (90) 8. 血海 (90) 9. 府舍 (90)
10. 腹结 (91) 11. 大横 (92) 12. 天溪 (92)
13. 大包 (92)

手少阴心经穴 92

1. 极泉 (92) 2. 少海 (93) 3. 通里 (93)
4. 神门 (93) 5. 少府 (94) 6. 少冲 (95)

手太阳小肠经穴 95

1. 少泽 (95) 2. 前谷 (95) 3. 后溪 (96)
4. 腕骨 (96) 5. 阳谷 (96) 6. 养老 (97)
7. 支正 (97) 8. 小海 (97) 9. 肩贞 (98)
10. 臑俞 (98) 11. 天宗 (98) 12. 肩外俞 (99)
13. 肩中俞 (99) 14. 天容 (99) 15. 颧髎 (99)

16. 听宫 (100)

足太阳膀胱经穴 100

1. 通天 (101) 2. 玉枕 (101) 3. 天柱 (101)
4. 大杼 (102) 5. 风门 (102) 6. 肺俞 (103)
7. 厥阴俞 (104) 8. 心俞 (104) 9. 督俞 (104)
10. 膈俞 (104) 11. 肝俞 (105) 12. 胆俞 (105)
13. 脾俞 (105) 14. 胃俞 (105) 15. 三焦俞 (106)
16. 肾俞 (106) 17. 气海俞 (106) 18. 大肠俞 (106)
19. 关元俞 (107) 20. 小肠俞 (107) 21. 膀胱俞 (107)
22. 中膂俞 (107) 23. 白环俞 (108) 24. 上髎 (108)
25. 次髎 (108) 26. 中髎 (108) 27. 下髎 (109)
28. 承扶 (109) 29. 殷门 (109) 30. 浮髀 (109)
31. 委阳 (110) 32. 委中 (110) 33. 附分 (110)
34. 魄户 (111) 35. 膏肓 (112) 36. 神堂 (112)
37. 臆譔 (112) 38. 膈关 (113) 39. 魂门 (113)
40. 阳纲 (113) 41. 意舍 (113) 42. 胃仓 (114)
43. 志室 (114) 44. 秩边 (114) 45. 合阳 (114)
46. 承筋 (115) 47. 承山 (115) 48. 飞扬 (115)
49. 跗阳 (115) 50. 昆仑 (116) 51. 申脉 (116)
52. 金门 (116) 53. 京骨 (117) 54. 束骨 (117)
55. 足通谷 (117) 56. 至阴 (117)

足少阴肾经穴 118

1. 涌泉 (118) 2. 然谷 (118) 3. 太溪 (119)
4. 大钟 (119) 5. 照海 (119) 6. 复溜 (120)
7. 交信 (120) 8. 筑宾 (121) 9. 阴谷 (121)
10. 大赫 (121) 11. 气穴 (121) 12. 四满 (122)
13. 中注 (123) 14. 盲俞 (123) 15. 商曲 (123)
16. 石关 (123) 17. 阴都 (123) 18. 腹通谷 (124)

19. 幽门 (124)	20. 神封 (124)	21. 神藏 (124)
22. 或中 (125)	23. 俞府 (125)	
手厥阴心包经穴		125
1. 天池 (125)	2. 曲泽 (125)	3. 郄门 (126)
4. 间使 (126)	5. 内关 (127)	6. 大陵 (127)
7. 劳宫 (128)		
手少阳三焦经穴		128
1. 关冲 (128)	2. 液门 (128)	3. 中渚 (129)
4. 阳池 (129)	5. 外关 (129)	6. 支沟 (130)
7. 天井 (130)	8. 臑会 (131)	9. 肩髃 (131)
10. 翳风 (131)	11. 角孙 (132)	
足少阳胆经穴		133
1. 瞳子髎 (133)	2. 听会 (133)	3. 上关 (133)
4. 率谷 (134)	5. 完骨 (135)	6. 阳白 (135)
7. 脑空 (135)	8. 风池 (135)	9. 肩井 (136)
10. 日月 (136)	11. 京门 (137)	12. 带脉 (137)
13. 居髎 (138)	14. 环跳 (138)	15. 风市 (138)
16. 膝阳关 (138)	17. 阳陵泉 (138)	18. 阳交 (140)
19. 光明 (140)	20. 阳辅 (140)	21. 悬钟 (140)
22. 丘墟 (141)	23. 足临泣 (141)	24. 侠溪 (141)
25. 足窍阴 (141)		
足厥阴肝经穴		142
1. 大敦 (142)	2. 行间 (142)	3. 太冲 (142)
4. 蠡沟 (143)	5. 中都 (143)	6. 膝关 (143)
7. 曲泉 (144)	8. 章门 (144)	9. 期门 (144)
奇穴		145
1. 四神聪 (145)	2. 印堂 (145)	3. 太阳 (146)
4. 翳明 (146)	5. 安眠 (147)	6. 颈百劳 (147)

7. 崇骨 (147)	8. 血点 (148)	9. 定喘 (148)
10. 夹脊 (149)	11. 巨阙俞 (149)	12. 胰俞 (149)
13. 下极俞 (149)	14. 腰眼 (150)	15. 提胃穴 (151)
16. 胃上 (151)	17. 脐中四边 (152)	18. 三角灸 (152)
19. 利尿穴 (152)	20. 气门 (152)	21. 子宫 (152)
22. 肩前 (153)	23. 肘尖 (153)	24. 落枕穴 (153)
25. 戒烟穴 (153)	26. 中魁 (154)	27. 八邪 (154)
28. 鹤顶 (154)	29. 内膝眼 (155)	30. 阑尾穴 (155)
31. 胆囊穴 (156)	32. 八风 (156)	
预防保健灸法		157
预防感冒灸法		157
补肾健身灸法		158
健脾和胃灸法		158
健脑灸法		159
养心灸法		160
眼睛保健灸法		160
青壮年保健灸法		161
中老年的保健灸法		162
戒烟灸法		163
戒酒灸法		164
减肥灸法		165
常见病治疗灸法		168
支气管炎		168
支气管喘息		169
冠心病		171
高血压病		172
低血压病		173

心脏神经官能症	175
高血脂症	176
雷诺氏病	177
胃肠神经官能症	179
胃及十二指肠溃疡	180
慢性胃炎	182
胃下垂	183
慢性结肠炎	184
习惯性便秘	185
肾盂肾炎	187
单纯性甲状腺肿	188
甲状腺机能减退症	190
甲状腺机能亢进	191
糖尿病	192
面神经炎	194
肋间神经痛	195
多发性神经炎	196
血管神经性头痛	197
神经衰弱	199
脑血管病后遗症	200
阳痿	202
遗精	203
早泄	204
前列腺炎	205
前列腺肥大	206

腓肠肌痉挛	207
腰扭伤	208
风湿性关节炎	209
落枕	211
颈椎病	212
肩关节周围炎	214
肱骨外上髁炎	215
慢性阑尾炎	216
血栓闭塞性脉管炎	217
痛经	219
月经不调	221
白带增多症	222
盆腔炎	223
乳腺增生病	225
更年期综合征	226
小儿腹泻	228
小儿厌食症	229
青光眼	230
视神经萎缩	232
过敏性鼻炎	234
慢性咽炎	235
慢性喉炎	237
荨麻疹	238
湿疹	240
皮肤瘙痒症	241

银屑病	241
神经性皮炎	243
带状疱疹	244
痤疮	246

灸法的概念

灸法，是针灸学的重要组成部分。我们一般所说的针灸，是针法与灸法配合使用以治疗疾病的方法。灸，灼、烧之意。所谓的灸法，是利用艾绒、某种易燃材料或利用某种药物放置在体表的穴位或患处进行烧灼、熏熨、贴敷，借灸火的温和热力以及药物的作用，以刺激身体的一定穴位、患病部位，通过经络的传导，起到温和气血、扶正祛邪、调整人体生理功能平衡，达到防病治病、养生保健作用的一种外治方法。

灸法的特点是“针所不为，灸之所宜”（《灵枢·官能》），对于使用针刺、药物等方法治疗无效果或效果不理想的病证，采用灸法，往往可收到较满意的疗效。在防病保健方面，灸法的使用，也具有较悠久的历史，如《扁鹊心书·须识扶阳》中说：“人于无病时，常灸关元、气海、命门、中脘，虽未得长生，亦可保百余年寿矣。”

灸法的源流

传说“隧人氏”教人类钻木取火，火作用于人体则具有消除寒冷、温通血脉、

舒展筋骨、解除疲劳等作用，所以人类是在无意识地接受医疗，这无疑是间接的保健灸。原始人使用火日益频繁，接触火时，火星溅到身体某处而灼伤，但却减轻或消除了某种疾病的痛苦，人们记住了这个灼伤的部位，当这种疾病再发时，试探性点燃枝条烧灼该部位，症状同样消除或缓解。这些疗疾的零星经验，日积月累，便逐渐发展为灸法。

现存文献中最早的古医籍当属 1973 年长沙马王堆三号汉墓出土的帛书，其中《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》主要论述十一脉循行、主病及灸法。另外，尚有《脉法》、《五十二病方》等，其成书年代可以上溯至春秋时期，是迄今为止发现的唯一的先秦时期的医著。以上出土的四种古医帛书，详载了古人对于灸法的研究及应用，书中除艾灸外，还记述了其他灸法；除直接灸外，并有隔物灸、加药灸等。灸法在当时已能治疗足小趾废、产聋、目痛、腰痛、肝痛、心痛、乳内廉痛、痛、疥等近百种不同疾病。

战国至秦汉之际成书的《黄帝内经》，其中也有大量有关灸法的记载，如《灵枢·官能》说：“灸之则可，刺之则不可，气盛泻之，虚则补之。”《素问·骨空论》也云：“灸寒热之法，先灸项大椎”、“大风汗出，灸谿谿”。《素问·血气形志论》则云：“形乐志苦，病生于脉，治之以灸刺。”以上足见该书问世之前，灸法治病已相当盛行。

在唐代，药王孙思邈大力倡导灸疗治病，并采用灸法治疗某些热证，发展了灸法的临床适应范围。他注重灸量，施灸壮数可多达几百壮。孙思邈还将艾灸与药物相结合用于临床，在其所著的《千金要方》中载有隔蒜灸、豆豉灸、黄蜡灸、隔盐灸、黄土灸等等。在当时已有专职的“灸师”之称，如韩愈诗云：“灸师施艾炷，酷若猎火围。”此时灸法已发展为一门独立的学科。

宋朝时，宋太祖曾亲自为太宗皇帝施灸，《宋史》：“太宗尝病亟，帝往观之，亲为灼艾，太宗觉痛，帝也取艾自灸。”此事后人传为佳话。宋·王执中则著有《小儿明堂灸经》、《膏肓腧穴灸法》、《西方子明堂灸经》等灸疗专著，在理论和实际操作上，形成了独特流派，丰富了灸疗学的内容。此外宋代的针灸医籍中还有许多关于“天灸”、“自灸”的记载，就是利用某些刺激性药物，如毛茛叶、白芥子、旱莲草等贴敷于有关穴位上，使之发泡的方法，它是不同于温热刺激的另一类灸法。宋朝的医家，对于灸法有很多创新和发明，著述也颇多，可谓灸法的全盛时期。

在明初成书的《寿域神方》中记述了艾卷灸法，这种方法后来发展为药末与艾绒混合制成的艾卷熏熨的“雷火神针”及“太乙神针”等灸法。以后又产生了“桑枝灸”，以及用桃木为灸料的所谓“神针火灸”，这些均可认为是古代灸法和熨法的结合运用。此外，当时还发明了灯火灸，即用灯草蘸

油点火在病人皮肤上直接烧灼的一种灸法；还有用铜镜聚集日光作为施灸热源的所谓“阳隧灸”。

到了清代，在施灸方法上也有所创新，出现了针烧艾灸、隔面碗灸、磁缸灸等。

建国以来，随着我国医疗卫生事业的不断发展，灸法也有很多创新和发展，诸如“燎灸”、“硫磺灸”等等。另外，还产生了一些与现代科学技术相结合的灸疗器械，如“电热灸疗仪”、“强效温灸治疗仪”、“电子温针灸仪”、“激光针灸仪”、“热流喷灸仪”等，大大丰富了祖国医学灸法的内容，而且对灸法治病防病作用原理的研究也在不断地进行，并取得了很多可喜的成果。

灸法是我国古代劳动人民长期与疾病作斗争的一大经验总结，是祖国医学的重要组成部分，它为中华民族的繁衍昌盛作出了重大贡献，对世界医学的发展也产生过重大影响。尤其是当前，灸法与针刺越来越受到世界各国人民的重视，世界卫生组织为实现 2000 年全球人人享有医疗保健的目标，已将其作为防病治病的重要民间疗法之一，全世界已有 100 多个国家和地区派医生来我国学习此术，并在世界（早在公元 541 年针灸术即已传入朝鲜半岛，公元 562 年传入日本）各地传播使用，因而针法、灸法已成为世界医学的组成部分。灸法乃国之瑰宝，其广泛使用，必将会对全人类的身体健康、卫生保健事业作出更大的贡献。

灸法的材料

施灸材料，古今均以艾叶为主，所以古时有将艾作为灸法的代名词的记载，如《素问·汤液醪醴论》说：“燔石针艾治其外。”《孟子·离娄篇》亦云：“七年之病，求三年之艾。”这里所说的“艾”，即指灸法而言。

1. 艾：又名艾蒿、蕪草、灸草、医草等。《名医别录》说：“性味苦、辛、温。”艾为菊科多年生草本植物，自然生长于山野之中，我国各地均有生长，以蕪州产者为佳，故又有蕪艾之称。艾在春天抽茎生长，茎高60—120厘米，叶形为羽状深裂，裂片尖端有不规则的粗锯齿，表面灰绿色，背面灰白色，有白色毛绒，质柔软，折断为白色。在农历4—5月间，当叶盛花未开采收（民间有五月节采艾以避邪气之习俗），充分晒干或阴干后，置于石臼或其他器械中，反复捣椿压碎，使之细碎如棉絮状，筛去灰尘、粗梗及杂质，留下柔软的纯艾纤维，即为艾绒。艾叶加工成艾绒以作为施灸材料，有其他材料不可比拟的优点，其内含纤维质较多，水分较少，同时还有许多可燃的有机物，而且便于搓捏成大小不同的艾炷或卷制艾条，易于燃烧，燃烧时火力温和，热力能窜透皮肤，直达深部，有非常好的临床疗效。

2. 其他易燃生热的灸料

(1) 灯芯草：又名灯心草，为多年生草本植

物，秋季采收，灯心草蘸油点燃，在病人身上灼烫，谓之灯火灸。

(2) 硫磺：为天然硫磺矿或含硫磺物的提炼品。将硫磺置于疮面上点燃施灸，谓之硫磺灸。

(3) 桑枝：为蔷薇科植物桑的嫩枝，春末夏初采收。用燃着的桑枝施灸，谓之桑枝灸。

此类灸料还包括黄蜡、竹茹、桃枝、麻叶等等。

3. 具有芳香或刺激性的灸料：此类灸料多数是对皮肤有刺激性的药物，将其敷于穴位上或患处，皮肤可起泡或仅局部充血潮红，通过这种刺激达到治疗目的。常用的灸料有：大蒜、生姜、葱白、白胡椒、蓖麻仁、吴茱萸、乌梅、白芥子、斑蝥、毛茛、旱莲草等等。

灸法的作用与适应症

灸法是通过使用施灸材料刺激穴位激发经络功能而起作用，从而达到调整身体各组织器官功能失调的目的。灸法的应用范围非常广泛，既可用于防病保健，使人延年益寿，又用于治疗体表或内脏的各种疾病。

1. 保健养生：即无病而先施灸，《医心方》称为“逆灸”，其能增强机体的抗病能力和抗衰老能力，从而达到祛病延年的目的。

2. 疏风解表，温中散寒：用于治疗外感风寒表证及中焦虚寒之呕吐、腹痛、泄泻等证。

3. 温经散寒，活血通络止痛：用于治疗寒凝血滞、经络痹阻引起的各种病证，如风寒湿痹、痛经、经闭、寒疝腹痛等证。

4. 温阳补虚，回阳固脱：用于脾肾阳虚，元气暴脱之证，如久泻、久痢、遗尿、遗精、阳痿、早泄、虚脱、休克等证。

5. 补中益气，升阳举陷：用于治疗气虚下陷、脏器下垂之证，如胃下垂、肾下垂、子宫下垂、脱肛等证。

6. 清热解毒，散结止痛生肌：用于治疗外科疮疡初起红肿热痛（灸灼之所以能退热，是由于艾火的温热能使腠理开发，毛窍通畅，使热有路可去，即“以火引火”）及瘰癧等。对于疮疡溃久不愈者，有促进愈合、生肌长肉的作用。

灸法的禁忌症

1. 禁灸部位 古代文献对此记载不甚一致，从现代解剖学角度看，人体的重要脏器、大血管附近、睾丸、乳头、阴部及妊娠妇女的腰骶部和下腹部等均不可灸；颜面部不宜用直接灸，防止形成瘢痕，有碍美容；关节活动部位亦不宜用瘢痕灸，避免化脓、溃烂，不易愈合。

2. 禁灸病证，灸疗主要借温热刺激达到调整机体功能和治疗疾病的目的。因此凡外感温热、阴虚内热之证而见脉搏跳动转快者一般不宜施灸。对于高热、抽风、昏迷等病人也不宜灸治。

3. 对于过劳、过饥、过饱、醉酒、大惊、大怒、大恐、大渴、大汗淋漓者不宜马上施用灸法。

灸法的现代研究概况

大量的临床资料证明，灸法的防病治病作用是通过多方面的综合因素来实现的。为了探讨灸法的作用机理，近几十年来，很多学者从不同角度进行了各种临床和实验研究，以往的研究资料说明，灸法对人体诸多器官和系统均有相应的调节作用。

免疫功能的强弱，是人体抗病能力的标志，调节人体免疫系统的功能，可以减缓某些疾病的发生和发展，为了探讨灸法对免疫系统的影响，研究人员使豚鼠感染结核病，经艾灸治疗后，疾病进展转慢，内脏病变较轻，在病变后期尤为明显。并且观察到，豚鼠网状内皮系统细胞吞噬机能与内脏结核病变一致，当肝脾受到损伤时，其吞噬机能下降，但在感染初期（第 10 日），巨噬细胞的吞噬反应比感染前迅速而旺盛，表示机体已产生了免疫性，在感染中期（第 30 日），巨噬细胞反应才开始衰退。再如国内学者在用家兔经伤寒杆菌死菌液或绵羊红细胞免疫后，观察艾灸对伤寒杆菌凝集素或溶血素的影响时发现，艾灸大椎、百会穴对其具有促进作用，平均效价较未经艾灸的免疫家兔高两倍多。而日本学者以伤寒杆菌免疫家兔，发现施灸后的家兔其凝集效价是对照组的 4 倍。这些都表明艾灸对免疫体的产生有良好的效果。

患慢性哮喘病的患者，一般免疫机能均偏低，所以在临床研究中，对慢性哮喘病人的大椎、肺俞等穴施以瘢痕灸，结果发现，26例患者中，11例灸前淋巴细胞转化率低于正常值者，灸后淋巴细胞转化率均提高；而其余15例灸前数值在正常范围，灸后仅3例比原来提高。这就提示原来淋巴细胞转化率低于正常值者，灸后均明显提高，且绝大部分能转至正常范围，而原来淋巴细胞转化率在正常范围内者，灸后无明显变化，表明艾灸对改善机体免疫机能具有调节作用。对42例支气管哮喘患者采用化脓灸的方法进行治疗，两个月后，做淋巴细胞转化率和E-玫瑰花环测试（均为人体细胞免疫能力的检测指标），其数值较灸前也有明显提高。在对21例硬皮病患者大椎、肾俞、命门等穴施用隔附子灸及丁桂散灸法，灸前淋巴细胞转化率低于正常值，灸后20例有非常显著的提高。这些均表明，灸法对提高机体免疫功能有着积极的促进作用。

研究人员在实验中还发现，灸法对变态反应也有一定影响，例如预先对动物施灸，可以使实验中因变态反应而致死的小鼠死亡率，由不施灸的90%降低到10%，变态反应的症状也减轻，动物肾上腺皮质的肥大细胞数量也减少，而且进一步观察到施灸后出现大量的去颗粒细胞，其他细胞颗粒数量也减少，这些细胞内组织胺的荧光强度因此也减少，从而可以证实，施灸能引起肥大细胞去颗粒，这种现象表明是由于抗原（过敏原）引起的变

态反应减弱，因此，灸法可能在许多疾病中，由于能作为一种抗变态反应机制起效果，而产生有益的作用。

根据艾灸具有调整、增强机体免疫功能的作用，采用艾灸的方法治疗肿瘤取得了一定疗效。为了观察艾灸对肿瘤免疫的反应，日本学者在实验中，先在小鼠背部施灸 20 处，每次各 1 壮（米粒大小），灸后 3 小时再在小鼠的一定部位接种 100 万个癌细胞，然后每周记录肿瘤生长情况，结果 5 周后发现，接种腹水癌小鼠的癌肿的生长抑制率达到 50%，而接种睾丸肿瘤的小鼠其抑制率可达 60%，没有预先施用灸法的小鼠被接种的肿瘤则未见其生长受到抑制，这说明施灸动物皮下产生了对移植癌的抵抗性。为了证实在正常动物的施灸部位皮肤组织提取物中是否含有抗癌因子，实验者将施灸部位的皮肤组织用生理盐水进行提取，然后把该提取物注入接种癌肿后 24 小时的小鼠的腹腔内，观察 60 天后，接种腹水癌的小鼠癌肿抑制率为 60%，接种睾丸癌的小鼠癌肿抑制率高达 70%，而未接受提取物的小鼠癌肿的生长则未受到抑制。该研究证明了施灸部位组织提取物对小鼠移植性肿瘤的生长，具有抑制作用，因此对于预防和治疗癌肿提供了新的途径。

艾灸疗法的抗菌消炎作用在实验中也得到了证实。如将豚鼠腹腔内注入痢疾菌株，造成痢疾性膀胱炎，在感染前或感染后施以艾灸，均能延长动物

的生命，尤以感染前施灸者效果明显，经艾灸治疗后再予感染的动物，其膀胱炎的症状较轻；在感染后第1天大部分动物粪便内不带痢疾杆菌，亦无血尿；施灸的动物在膀胱感染后48—72小时，其肠系膜淋巴结、脾脏、肝脏、肾脏及大肠等内脏组织，未培养出1个细菌，而在未经施灸的豚鼠的不同脏器和组织内皆能培养出痢疾杆菌；并观察到施灸后的动物在不同时间内取尿标本进行培养，其细菌出现的数量，较未施灸的动物尿中的细菌数量为少。再如，在经过艾灸后的豚鼠的体内，注入细菌性致热物质，使之出现痢疾中毒症状，则豚鼠的发热反应明显加快，发热反应增强，而且持续时间较长，但与未施灸的豚鼠比较，死亡率却较低。

艾灸对炎症的渗出也有一定影响，如在实验中采用肉芽囊肿技术使动物产生炎症，之后其中1组动物每天在足三里穴施灸1次，每次3壮，连灸6日，而另一组不用灸法，第8日时测量肉芽囊内的渗出液量，未经施灸动物渗出液的平均值为7.03毫升，而经过灸法治疗的动物渗出液的平均值仅为3.59毫升。由此可见，艾灸能抑制炎症病灶血管通透性的增高，减少炎性渗出，这为临床运用艾灸治疗关节炎等疾患提供了理论依据。

灸法对心脑血管系统也有较明显的影响。国内有人用艾卷温和灸和艾炷隔姜灸左侧足三里穴，治疗高血压病，然后测量病人手指的容积，观察其变化情况，发现因施灸而引起的局部（左下肢足三里

穴)温热感或灼痛,皆能很灵敏地反映在右手食、中两指容积曲线的变化上,艾灸初期手指容积曲线波动明显,经灸8—12次以后,可出现像健康人一样平稳的“零线”曲线。从而证实,艾灸对初期高血压病患者的中枢神经系统的不平衡具有一定的调整作用。大量的临床实践也证实艾灸可以调整血压,如采用艾灸涌泉穴治疗高血压60例,灸后血压有下降趋势者占73.4%,1—2小时下降者占82.6%,连续施灸1周后,则血压下降更为显著。再如采用温针灸石门穴后,血压偏高者可使之下降,偏低者可使其上升,有调节血压使之趋向正常之作用。为了观察灸法对休克患者血压的影响,对58例休克病人的百会、气海等穴,施用艾炷着肤灸,其中有37例血压回升,收缩压回升尤为明显,最多升高110毫米汞柱,平均升高30—50毫米汞柱,但舒张压变化不显著。随着血压的回升,末梢微循环及休克症状也得到改善。在动物实验时,艾灸关元穴对失血性休克家犬的血流动力学紊乱也有一定调整作用,可以增强机体的代偿能力,对防止缺氧的不断加重和延缓休克的发展具有积极的意义。

在预防中风方面艾灸 also 具有重要意义,对47例诊断为三期高血压病合并脑血栓形成恢复期的病人,取双侧足三里穴施以艾卷灸,每次20分钟,每周灸2—3次,10次为1疗程,结果表明,艾灸足三里有降低血液凝聚的作用,可以预防脑血栓形

成的再次发生。实验也证明,施用癰痕灸后除血压显著下降外,对改善血液粘度和扩张血管有一定作用,从而获得在降低血压的基础上,达到减少暴发中风的机会。

灸法对血液系统的影响,国内外学者均做了大量研究,结果表明,施灸后可使白细胞数目显著增加,一般在灸后1—4小时为最多,约为平常时的2—3倍,以中性白细胞增多为主。日本学者在灸法对红细胞及血红蛋白的影响的实验中发现,施灸过程中红细胞和血红蛋白虽不起明显变化,而施灸中止后,从第1周始渐渐增加,平均至第8周可达到顶点,有的可持续到第10周,再恢复原状。灸法对血小板减少症的临床研究也发现,灸治后较灸治前血小板计数明显增加,临床总有效率可达80%。这些都足见灸法对血液系统的作用明显的。

艾灸可以镇痛,早已被大量临床资料所证实。在动物实验中则采用艾灸大白鼠身柱穴的方法,观察其对大白鼠甩尾的影响,结果提示,灸后大白鼠甩尾阈明显延长,说明艾灸可能具有镇痛作用。对切除肾上腺的大白鼠,再施以艾灸身柱穴,则可见到大白鼠的甩尾阈变化受到抑制,可见艾灸的作用与肾上腺功能有关;若于被切除肾上腺的大白鼠腹腔内注射肾上腺素,则又使大白鼠的甩尾阈延长。

古今文献均有艾灸可以纠正孕妇胎位不正的记载,现代动物实验中,对家兔至阴穴施以艾灸,并

记录子宫的活动曲线，结果发现灸后子宫活动变得明显增强，这正是胎位得到矫正的机理所在。

关于灸法作用机理的大量实验研究充分说明，灸法对人体的免疫系统、神经系统、内分泌系统、血液系统、循环系统、生殖系统、呼吸系统、消化系统均有一定的促进与调节作用。相信充分利用现代科学技术，对灸法这一古老医术进行研究，揭示其疗效机制，将会对灸法的发展起到积极推动作用。

日本灸法保健养生概况

保健灸法在日本相当盛行，日本针灸医师代田文志在他所著的《针灸临床治疗学》中说：“灸能广防所有的疾病，又能保持健康，使人长寿，古来将它作为一年中一项大事来行使，直到明治初年为止，一般人之中普遍施行着养生灸。”日本人重视保健养生灸法由来已久，在德川幕府时代，德川将军为求长生之术，曾咨询三河国最长寿者万兵卫，其言“这事不难，我家祖传每月月初连续8天灸三里穴，始终不渝，仅此而已。我虚一百七十四岁，妻一百七十三岁，子一百五十三岁，孙一百零五岁。”（《云锦随笔》），因此三里灸被列入政府健民政策内容，于庆二年发布文告“春秋施灸，以防疾患，人固应勤于所业，然有所患则业废身蔽，不可不知，妇孺亦然。”以昭示国民。此后则有“勿与不灸足三里之人做旅伴”、“旅行灸三里，健步行如

飞”的谚语在日本民间广泛流传。

日本医师泽田健认为：“三里治脾胃肾有效，故名三里，里同理，亦即三理。能治委中强硬及膀胱疾病。三里养先天之气，灸三里可使元气不衰，故称长寿之灸。”1937年元旦，日本掀起了国民三里灸健康运动，在民族医学、工厂医学、学校医学中均大力提倡集体养生灸法。

代田文志医师则主张，婴儿期灸身柱，以促进婴儿的生长发育；17岁左右灸风门，以预防呼吸系统的疾病发生；24岁左右灸三阴交，以避免生殖系统疾患；30岁以后灸足三里，以增强脾胃的功能，预防一切疾病；老年加灸曲池，以使眼睛明亮，降低血压，预防中风的发生。代田医师还在长野县那郡神稻国民学校施行学童集体施灸，在1200名学生中，对70名虚弱儿童进行详细诊察，发现均为发育欠佳，体格低劣，大多患有营养不良、扁桃体肥大、颈腺肿胀，还有的患眼科、耳科疾病。采用以身柱、风门、灵台、孔最等为基础穴，用小艾炷，每穴灸3壮，连续灸治1个月，患儿饮食增加，精神饱满，体重胸围显著增加，半年之后疾病痊愈。仅长野，实行学童施灸的学校就达40所以上，施灸总人数累计达数万名。此后代田又在女校、农校、师范学校等处开展健康灸，对中等学校学生中所患肺门淋巴结核、肺结核、头痛、神经衰弱、慢性肠胃病、脚气、膝关节痛等病，健康灸可以预防也可以对症治疗。在工厂里进行的集

体施灸，亦取得了保健与治疗的良好效果。

日本东京小儿研究所的砂田博士，对营养不良小儿施行身柱灸的研究结果表明，施灸比未施灸的小儿，发育显著良好，夜啼也在数日后痊愈。在山阴、四国等地，人们大多认为小儿出生后百日内灸身柱穴可以无病健康成长，因而所有小儿都行身柱灸。

以上可以看出，日本民族对健康灸法之重视，举国上下齐施灸，其普及程度，即使是在灸法发源地的中国，也是很难见到的。日本是当今世界长寿大国，与其习惯于各种养生长寿之术不无关系，这一点是值得大力提倡的。

灸法的分类

灸法大体上可分为艾灸法和非艾灸法两大类。艾灸法又可分为艾炷灸、艾条灸以及艾饼灸、艾熏灸、温灸器灸、温针灸等；非艾灸法可分为燂灸、灯火灸、硫磺灸、黄蜡灸、火柴灸等多种。临床上以艾条灸、艾炷灸最为常用。施灸的方法虽各有不同，施灸的材料和操作方法亦多种多样，但几千年来临床上最常用的材料仍以艾为最多，因此，艾灸法也是最主要的施灸方法。

艾灸法：艾灸法是用艾叶制成的艾绒作为施灸材料而用于灸治的一种方法。健康人常施灸治，能补正益气，起到防病保健、延年益寿的作用；患病者施以灸治，可使衰弱的机能得以兴奋，亢进的机能得以平抑，瘀血之疾得以消散。艾灸火力温和，其温热能渗透到组织深部，病人痛苦少，临床上适应症也非常广泛。

1. 艾炷灸 艾炷灸法可分为直接灸和隔物灸两类。

(1) 直接灸：又称明灸、着肤灸，古称“着肉灸”。是把艾炷直接放在皮肤上而施灸的一种方法（见图1）。唐代《千金方》记载：“炷令平正着肉，火势乃至

病所也。”施灸时如放置大艾炷，可在皮肤上涂点酒精，以防其倾倒；如用小艾炷，防其安置不稳，可在皮肤上涂一点蒜汁。根据其对皮肤刺激的程度不同，本灸法又分为无瘢痕灸和瘢痕灸两种。



图1 直接灸

无瘢痕灸 又称“非化脓灸”。施灸后皮肤不起泡，以达到轻度烫伤为度，或起泡后不致诱发成灸疮，灸后不遗留疤痕，一般多用中、小艾炷。具体操作时，如用中等艾炷，点火后，病人稍觉烫就去掉，另换一壮；用小艾炷灸时，不等艾火烧到皮肤，病人感到皮肤稍微烧灼痛时，应立即将艾火压灭。一般可连续灸3—7壮，以局部皮肤发生红晕为度。此法适用于虚寒性疾病的轻证，因不留瘢痕，易为病人所接受。

发泡灸 一般用小艾炷。当病人感到发烫后再继续灸3—5秒钟，此时施灸部位皮肤可出现黄斑，且有汗出，隔1—2小时后就会发泡，若灸而不发，可用热物熨之，或重复施灸。发泡后切勿挑破，任其自然吸收。一般短期内留有色素沉着，不遗留瘢痕。此法适用于一切虚寒性疾病，如哮喘、眩晕、慢性腹泻、皮肤疣等。

瘢痕灸 又称“化脓灸”。是将艾炷置于穴位

皮肤上施灸，灸时须艾炷燃尽，除去艾灰，再更换新炷，一般可有剧痛，以灸至皮肤烧破，并致局部化脓、结痂，脱落后留有永久性瘢痕。此法在唐宋时期最为盛行。施灸时一般用小艾炷，每穴每次1—6壮，小儿或体弱者灸1—3壮。

体位选择和点穴：因本灸法要求安放艾炷时间较长，所以要特别注意体位的平正和舒适，一般四肢及胸腹部取仰卧位，背部取坐位或俯卧位，再在上面正确点穴，“灸时孔穴不正，无益于事，徒破皮肉耳”（《千金方》）。



图2 瘢痕灸缓痛拍打法

施灸的具体操作及注意事项：在选好的穴位上涂敷蒜汁（增加粘附和刺激作用），立即将艾炷粘上，用线香点燃施灸，须待艾炷全部燃尽，除去艾灰。每灸完1壮，即涂蒜汁1次，按所需壮数，重新点燃艾炷。在施灸过程中，为减轻病人灼痛，施术者可在穴位四周用手轻轻拍打（见图2），借以缓解疼痛。此外，近人为了解决施灸时的灼痛，可在施灸前将0.2%盐酸普鲁卡因1—2毫升注入施灸穴位皮内或皮下，然后再施灸。灸毕，在施灸穴

位上贴敷淡膏药，并应让病人多吃羊肉、豆腐等营养丰富的食品，促使灸疮的正常透发，有利于提高疗效。施灸部位一般约一周左右化脓（正常的无菌性化脓，脓色较淡，多为白色），化脓时每天换药一次，避免污染。灸疮4—5天左右愈合，遗留永久性瘢痕。施灸时应避免晕灸，若施灸时发现病人恶心、头晕、面色苍白等，是晕灸的表现，应立即把艾火熄灭，停止施灸，嘱病人仰卧，头放低，若症状不减，可用手指按压人中穴，饮温茶水，病人可渐缓解。所以施灸时，一次不要取穴太多，一般2—5穴为宜。

此灸法对高血压病人，有预防中风的作用。常人施此灸法，有较好的防病健身作用。此法还适用于哮喘、癰疽、肺癆、痞证、癲癇、潰瘍病和发育障碍等。

（2）间接灸：又称“隔物灸”、“间隔灸”。是在艾炷与皮肤之间垫上某种物品（包括动物、植物和矿物，但多数属于中药）而施灸的一种方法（见图3）。这样既可避免灸伤皮肤，还可发挥艾灸与药物的双重或协同作用，因而具有特殊的疗效，适应症也较广泛，本法火力温和，病人易于接受。古代的间接灸法种类繁多，可广泛用于内科、外科、妇科、儿科、五官科等各种疾病。据古今文献记载，根据衬隔的物品不同，可分为40余种方法。现择其常用者分述如下。

隔姜灸 是用生姜片作间隔物而施灸的一种方



图3 间接灸

法，此法古时应用颇广。操作时将鲜姜切成厚3—4毫米的片，用针在中间扎数个小孔，置于施灸穴位上，上以适量大小的艾炷点燃施灸。如初灸1—2壮病人即感觉灼痛，可将姜片稍提起，然后重新放上。此种灼痛非真热，系姜性刺激所致，故仍须以小艾炷灸之，以灸至肌肤内感觉温热，局部皮肤潮红湿润为度。一般每次施灸5—10壮。亦可根据病情反复施灸。生姜味辛，性微温，无毒，入肺、心、脾胃诸经，能开宣肺气，调和营卫，散寒发表，通经活络，祛痰下气，消水化食，调中畅胃，温胃止痛。取姜艾结合以灸之，发挥二者的协同作用。此法适用于一切虚寒病证。可治疗风邪寒热、

伤风头痛、伤风鼻塞、上气痰喘、喉痹咳逆、反胃吐逆等证，尤对寒性呕吐、泄泻、胃痛、腹痛、阳痿、遗精、早泄、痛经、面瘫、风寒湿痹等疗效较佳。

隔蒜灸 是用蒜作间隔物而施灸的一种方法，此法流传民间已久。临床常用的隔蒜灸有两种，即隔蒜片灸和隔蒜泥灸。隔蒜片灸，是将独头大蒜切成1—3毫米厚的薄片，用针在蒜片中间穿数个小孔，放在患处或穴位上，上置中、小艾炷点燃施灸，每灸3—4壮更换蒜片，继续灸治；隔蒜泥灸，取新鲜大蒜适量，捣成泥状，放在穴位或患处，上置艾炷点燃施灸。以上两种，每穴每次宜灸足7次，以灸处泛红为度。蒜味辛，性温，入脾、肺、肠、胃经。能祛寒湿、辟邪恶、健脾开胃、消谷化食，又有消肿化结止痛之功。临床常用治阴疽流注、疮色发白、不红不痛、不化脓者，不论新久，宜多灸之；对疔疮肿毒、乳痈、一切急性炎症，未溃者，均可灸之；亦治虫、蛇、蜂、蝎咬蛰伤；局部灸之可解毒止痛，治瘰癧、疮毒、痈疽、无名肿毒等外科病证有奇效；还可用于腹中积块、癌肿、肺癆等证。

另外，民间还习惯使用“长蛇灸”，因施灸时将药物沿脊椎铺敷成形似长蛇而得名。方法是，用大蒜400—500克，除净蒜皮，捣如泥膏，平铺于脊椎上（自背部的大椎穴至腰俞穴），宽2厘米，厚约0.5厘米，周围用棉皮纸封固，不使蒜泥漫

流。病人取俯卧位，胸腹部用枕头垫高，以病人感到舒适为度，然后自大椎穴至腰俞穴部位，每一凹陷处，上置黄豆大的艾炷施灸数十壮，灸至患者口鼻内有蒜味为度。灸毕，再以温水渗湿棉皮纸周围，除去蒜泥，脊柱往往出现水泡，宜清心静养。此法多用于治疗虚癆之证。

隔盐灸 是用食盐作间隔物而施灸的一种灸法。因仅用于脐窝，它处禁用，故又称“神阙灸”，此法古代应用也很广。具体方法是，取纯净的食盐研细或炒热，纳入脐窝中，填平脐孔，上置艾炷点燃施灸，如患者稍感灼痛，即更换艾炷。也有于盐上再放置姜片再施灸者，以避免食盐受火爆而引致烫伤。如病人脐部凸出，可用湿面搓成条，围于脐周如井口，再填盐于其中施灸。临床上一般施灸3—9壮，对于急性病证可根据病情多灸，不拘壮数。此法有回阳、救逆、固脱的作用，适用于急性腹痛、吐泻、痢疾、淋病、中风脱证等。急证重证宜多灸。

隔葱灸 是用葱作隔垫物而施灸的一种灸法。即把葱白切成厚3—5毫米数片，或把葱白捣烂如泥，平敷于脐中及其四周，或敷于患处，上置大艾炷点燃施灸，一般灸5—10壮，以内部感到温热舒适，无灼痛为度。本法具有散寒通阳、理气消胀之功效，适用于虚脱、腹痛、疝气及乳房炎等。

川椒灸 是用川椒（即花椒）作隔垫物而施灸的一种灸法。即将适量川椒研细末，用陈醋调和成

糊膏状，制成厚约3毫米，钱币大小的药饼，放于患处，上置中、小艾炷点燃施灸。若患者感觉灸处灼痛，应除去艾火，更换新艾炷再灸。一般可灸5—7壮。此灸法适用于一切肿毒疼痛、跌仆扭伤所致的伤筋积血、腹胀痞闷等证。

隔附子灸 是用附子作间隔物而施灸的一种灸法。临床常用的有隔附子片和隔附子饼灸两种。隔附子片灸，是取熟附子用水浸透后，切成3—5毫米厚薄片，中间用针穿刺数孔，放于穴位或患处，上置艾炷点燃灸之；隔附子灸，是将附子切细研末，以黄酒调和做饼如5分钱硬币大，厚约4毫米，中间用针穿刺数孔，放于穴位上，置艾炷灸之。也有用生附子3份，肉桂2份，丁香1份，共研细末，以炼蜜调和制成5毫米厚的药饼，中间再用针穿刺数孔，上置艾炷施灸。附子味辛，性热，具有温肾壮阳、逐寒祛湿、消坚破积等功效。临床适宜治疗各种阳虚病证，如阳痿、早泄、遗精以及痈疽初起、疮疡久溃不愈等证，也可用于某些阴虚性病证。

隔黄土灸 是用黄土作间隔物而施灸的一种灸法。取净黄土和水制成泥饼，厚约5—6毫米，直径约5厘米圆饼，中间用针穿刺数孔，放于患处，上置大、中艾炷施灸，灸1壮换1个泥饼，可连续灸5—7壮。此法很多古医书均有记载，是取土能胜水燥湿之意，主要适用于背痈诸证，对局限性湿疹、白癣及因湿毒而致的其他皮肤病均有一定疗

效。施灸时温热感直透皮肤，否则无效。

隔陈皮灸 是用陈皮作间隔物而施灸的一种方法。取陈皮适量，研为细末，用生姜汁调成糊状，敷于中脘、神阙等穴，上置艾炷灸之。此法适用于治疗胃腹胀闷、饮食不振、呕吐、呃逆等证。

隔黄豆灸 是用黄豆作隔垫物而施灸的一种灸法。取黄豆捣成细末，用温开水调成膏状，做饼如5分硬币大，厚约2毫米，放于穴位或患处，上置中艾炷及小艾炷交替施灸，每穴及患处可灸3—5壮。此法可用于治疗口腔炎、牙龈炎、脓疱疮及下肢溃疡等疾病。

隔牛奶灸 是用牛奶湿润纸作隔垫物而施灸的一种方法。取鲜牛奶30毫升，取黄棉纸一张，浸泡于牛奶中，5分钟后将纸取出，折成数层，剪去四角，如5分硬币大，厚2毫米，上置中艾炷施灸，每穴每次可灸3—5壮。本法适用于面部痤疮、头面部疖肿、脱发、肛裂、大便秘结及全身瘙痒等证。

隔蓖麻仁灸 是用蓖麻仁作隔垫物而施灸的一种方法。将去壳的蓖麻仁适量捣烂，呈泥膏状，然后制饼如2分硬币大，厚约3毫米，敷于施灸穴位处，上置小艾炷施灸。一般可灸5—7壮，10日为1疗程，休息2—3日，再行第2疗程。使用本法治疗胃下垂、子宫脱垂、脱肛等可灸百会穴；治疗面瘫等可灸印堂、下关、阳白、颊车等穴。

2. 艾条灸：又称“艾卷灸”。是用薄棉纸将艾

绒（或加药物）卷成圆筒形的艾卷（见图4），点燃一端（如燃着的香烟），在穴位或患处进行熏灸的一种治疗方法。市售艾条一般分为两种，即普通艾条（单纯艾条）和药物艾条。该灸法简便易行（在家庭内病人完全可以自行操作），对某些疾病疗效颇佳，且无痛苦和副作用，病人非常乐于接受。根据施灸时操作方法的不同，分为悬起灸、触按灸和隔药灸等。

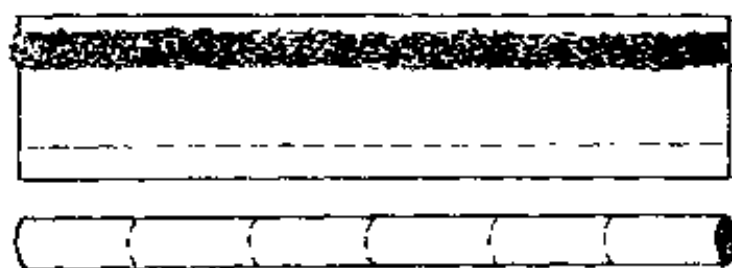


图4 艾卷式样图

（1）悬起灸：是使用不含药物的普通艾条，一端点燃后悬于施灸的部位之上的一种方法。一般艾火距皮肤约3厘米，灸5—30分钟，可使皮肤有温热感，而又不致烧伤皮肤。根据具体操作方式的不同，一般又分为温和灸、回旋灸、雀啄灸三种。

温和灸 将艾条燃着的一端对准施灸的部位进行熏烤，艾火距皮肤约2—3厘米左右，若病人有温热舒适的感觉，就可固定不移，灸至皮肤稍有红晕即可，一般10—15分钟左右即可。为掌握距离和避免施灸者疲劳，施灸者可用右手拇、食、中指持艾条，小指置于患者皮肤穴位附近施灸。此法能温通经脉、散寒祛邪，多用于灸治慢性病，临床应

用最为广泛（见图5）。对昏厥、局部知觉迟钝的患者，施灸者可将自己的左手中、食二指分张，置于施灸部位两侧，这样可以通过施灸者手指的感觉来测知患者施灸局部的受热程度，以便随时调节施灸的距离和防止灼伤。



图5 温和灸

回旋灸 又称“熨热灸”。将点燃的艾条，悬于施灸部位，距皮肤3厘米左右，平行往复回旋熏灸（见图6），使皮肤有温热感而不致于灼痛。一般可灸20—30分钟。本法适用于风湿痹证、神经麻痹及广泛性皮肤病等。

雀啄灸 是将点燃的艾条悬于施灸部位上约3厘米高处，艾火对准穴位，上下移动艾条，像鸟雀啄米一样，一起一落，不固定距离地施灸（见图7），一般可灸5分钟左右。本法多用于治疗急性病、昏厥急救及儿童疾患。此法因热力较强，应注意避免烫伤皮肤。

(2) 触按灸：是用加药灸条施灸。由于临床用

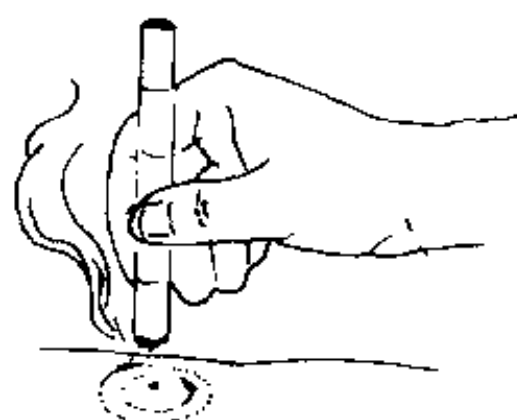


图6 回旋灸

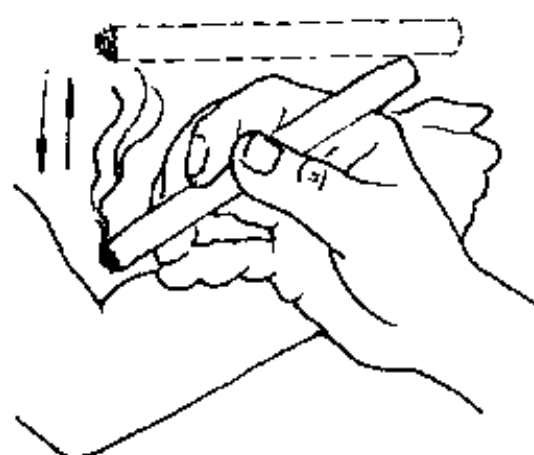


图7 雀啄灸

途不尽相同，艾卷中的艾绒所掺进的药物也各异。常用的有“雷火神针”、“太乙神针”、“百发神针”等。它们之所以被称为“针”，是因为操作时，将点燃的含药艾条实按在穴位上，很像针，故名。

雷火神针 本艾条的用药处方有多种，临床上使用明代《针灸大成》中的处方为多，其所用药物

有艾绒 60 克，沉香、木香、乳香、茵陈、羌活、干姜、穿山甲各 9 克，麝香少许。上药共研细末，和匀。以桑白纸 1 张，宽约 30 厘米见方，摊平，先取艾绒 24 克，均匀铺在纸上，再取药 6 克，均匀掺在艾绒里，卷紧，如香烟状，外以鸡蛋清涂抹，再糊上一层桑白纸，两头留出空纸 3 厘米左右，捻紧即成药艾条。施灸时，先选定穴位，将药条一端点燃，在施灸部位铺上 6—7 层绵纸或布，将燃着的艾火直接其上，留按 1—2 秒即可，若艾火熄灭，可重新点燃后再按，每穴按 10 次左右。或者以布 6—7 层包裹艾火，紧按于穴位上，如病人觉得太烫，可将艾条稍提起，待热减再灸，若火熄灭，再点再灸，如此 5—7 次（见图 8），本法适应于风寒湿痹、痿证、腹痛、泄泻、闪挫肿痛等。

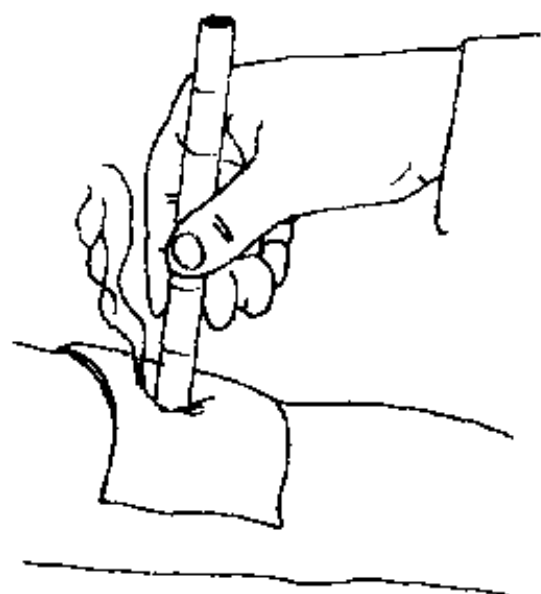


图 8 触按灸

太乙神针 是雷火神针的进一步发展，是在雷火神针的基础上改变药物处方而成，适应症更加广泛，尤其治疗风寒湿痹、顽麻、痿弱无力、半身不遂等均有效。在古代太乙神针药条处方也很多，现临床上以用古代《太乙神针》一书中所载处方加减变化而成的“通用方”为多。方药组成是：艾绒90克，硫磺6克，麝香、乳香、没药、松香、桂枝、杜仲、枳壳、皂角刺、细辛、川芎、独活、穿山甲、雄黄、白芷、全蝎各3克。艾条制法、施灸操作等与雷火神针相同。

艾火针衬垫灸 简称“衬垫灸”。此法是现代仿雷火神针、太乙神针与隔姜灸改进而成。操作时先将干姜片15克煎汁300毫升，加面粉调成稀糊状，涂敷在5—6层干净白棉布上，制成硬衬，晒干，剪成10厘米左右的方块备用。施灸时将衬垫置穴位上或患处，然后将药物艾条（药店有售）点燃的一端实按在衬垫上，一般以5秒钟为宜，以局部感到灼热时即提起艾条，谓之一壮，如此反复施灸5壮后再更换穴位，以局部皮肤呈现红晕者为佳。本法适于治疗关节痛、骨科痛证、哮喘、慢性胃肠病、阳痿、遗尿等。

(3) **隔药灸**：又称“间接灸”。是在穴位或患处覆盖某些药物后再以艾条施以悬起灸的一种方法。临床上最常用的有隔核桃壳灸、隔蟾蜍皮灸等。

隔核桃壳灸 将核桃劈为两半，去仁，于壳上

钻3—5个小孔，然后将核桃壳扣在患处，再以燃着的艾条在核桃壳的小孔上熏灸，每次灸5—10分钟。此法有解毒消肿止痛的作用，临床上适用于各种肿毒。

隔蟾蜍皮灸 取略大于病灶的蟾蜍皮一块，将其内侧面平贴于疔肿上，然后手持点燃的艾条，在蟾蜍皮上方2厘米左右进行熏灸，以患处感觉温热为度，每日施灸1次，每次约灸30—60分钟。此法对疔肿有较好的疗效。灸后需注意的是：①对疔肿未化脓者，灸后无需处理，若已化脓破溃者，灸后患处应放油纱条，敷以消毒纱布固定；②对疔肿无论已溃或未溃，灸前应拭去脓液，并防止挤压患部；施灸过程中，当蟾蜍皮呈现干燥现象时，可用生理盐水润之，以避免烫伤。

此外，近年来，有人已将传统艾条改进成无烟（或微烟）艾条，现在药店即有售，不仅疗效较好，因经过特殊加工，且无烟雾，使用起来既方便又卫生。尤其对那些因烟雾刺激而诱发或加重的某些疾患，该艾条更为适宜。操作方法等与艾条灸基本相同。

3. 艾饼灸：又称“铺灸”。是将艾绒铺于穴位上或患处而施灸的一种方法。临床常用的有熨灸、日光灸等。

熨灸 将艾绒平铺于腹部，或铺于穴位上及患处，上面覆盖几层布，然后用熨斗或热水杯在上面往返熨之，这样可以发挥热熨和艾的双重作用。此

法适用于风寒湿痹、痿证、寒性腹痛、腹泻等证。

日光灸 是将艾绒铺在患处或穴位上，在日光下曝晒，每次治疗 10—20 分钟，此法既有日光浴又有艾的作用。施灸时应注意，施灸部位周围用衣物遮盖好，夏日要谨防中暑。此法适用于风寒湿痹、小儿五迟证、皮肤色素变性及慢性虚弱性疾病等。

4. **艾熏灸**：是用艾绒燃熏或加水蒸熏穴位或患处的一种灸治方法。常用的有烟熏灸、蒸汽灸等。

烟熏灸 又称“温杯灸”。是将艾绒放在杯子内点燃，使热艾烟直接熏灸患处或穴位，以达到治疗的目的。此法适用于风寒湿痹、痿证等。

蒸汽灸 取艾绒或艾叶适量，放入容器内加水煎煮，边煮边用蒸汽熏患处（见图 9），或事先煎煮好后盛于盆中，用蒸汽熏穴位或患处。此法适用于风寒湿痹、肢体麻木或肿胀等。

5. **温灸盒灸**：是用专门的温灸器施灸的一种方法，其可以较长时间地连续给病人以舒适的温热刺激，且使用方便。温灸盒是

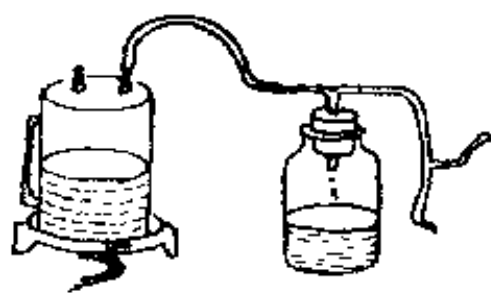


图 9 药液发生器

一种特制的盒形木制灸具，内放燃着的艾条，固定在某个部位而施灸。按其规格可分为大、中、小 3

种（大号：长 20 厘米、宽 14 厘米、高 8 厘米；中号：长 15 厘米、宽 10 厘米、高 8 厘米；小号：长 11 厘米、宽 9 厘米、高 8 厘米），制作时，取上述不同规格的木板，厚约 0.5 厘米，制成长方形木盒，下面不安底，上面制作一个可随时取下的盖，与盒的外径大小相同，在盒内中下部安置铁窗纱一块，距盒底边约 3—4 厘米（见图 10）。施灸时，把温灸盒安放于应灸部位的中央，根据病情截取一小段艾条，将其点燃后放在铁纱网的中心部位，盖上盒盖。盒盖的开合程度，可以调整施灸时温度的高低。每次灸 15—30 分钟，一次可灸数穴。此法适用范围最为广泛，艾灸所能治疗的各种常见病证，均可采用本灸法。

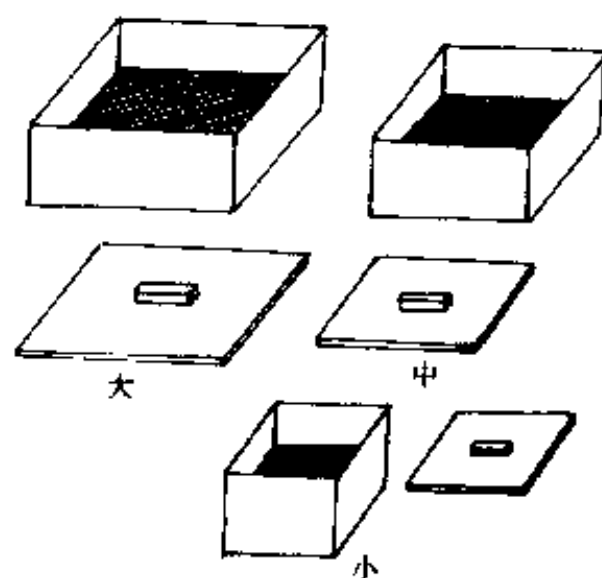


图 10 温盒灸器

6. 温针灸：即针上加灸，又名“烧针尾”、“传热灸”、“针柄灸”等。是目前医院里针灸科最常用的灸法之一，此灸法是在毫针刺入穴位后留针过程中，在针柄顶端插上燃着的艾条进行施灸，是针刺与艾条灸相结合的一种灸法，其适应症广，疗效也非常好。具体操作方法是：在选定的穴位上行针刺得气后，将毫针留在穴位适当深度，留针时，取约2厘米长艾条1节，套在针柄上，然后在艾条下端点燃以灸之（见图11），热力通过针体传入穴位，以发挥治疗作用，直至艾条燃尽为止。为防止皮肤灼痛和艾灰落下来烧伤皮肤，可于穴位上置一纸片。当艾条燃烧完时，除去残灰，待针柄冷却后将针取出。临床上也有用艾绒团代替艾条套在针柄上施温针灸。此法适用于既要针刺，又需要施灸的各种疾病，也可用于保健养生。

非艾灸法：凡是用艾以外的物品作为施灸材料的灸治方法，均属此类。

1. 天灸：又称“自灸”。是采用对皮肤有刺激性的药物涂敷于局部而施灸的一种灸法。其所以称为

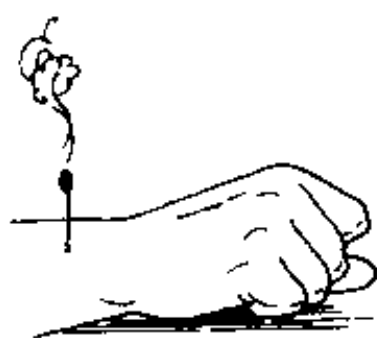


图11 温针灸

灸法，是因敷药的局部皮肤呈现潮红、充血，甚或起泡而如灸疮一样。所用药物绝大部分为中药，一

般多用单味药，也可用复方。近世又称其为“发泡疗法”。家庭常用者如下。

蒜泥灸 将紫皮大蒜去皮后捣烂如泥，取 3—5 克贴敷在穴位上，保留（敷灸）1—3 小时，以局部皮肤发痒、发赤或起泡为度。如敷涌泉穴可治疗咯血、衄血等；敷鱼际穴可治疗喉炎等。

生姜灸 将适量生姜，捣如泥状，敷于穴位或患处，用油纸覆盖，以胶布固定。敷于患处，主要治疗冻疮。

葱白灸 将适量葱白捣成泥状，敷于患处，主要用于治疗乳房炎。

食盐灸 将适量洁净食盐，研细炒热，待温时置于脐中，以与脐平为度。再取适量小麦麸皮，加醋炒热，装入布袋内，放脐部盐上敷灸。此法适用于治疗休克。

白胡椒灸 取白胡椒适量，研为细末，敷于穴位上，胶布固定。如敷大椎穴，可治疗疟疾。

白芥子灸 将白芥子研末，醋调或生姜汁调为糊膏状，每次用 5—10 克敷于穴位上，以油纸覆盖，胶布固定；或将白芥子细末 1 克，置于 3 厘米直径的圆形胶布中央，直接贴敷在穴位上。敷灸时间为 2—4 小时，以局部充血潮红、或皮肤起泡为度。此法用于治疗风寒湿痹、肺癆、哮喘、口眼喎斜等。另外，古代还有白芥子涂法，方用白芥子 30 克，元胡 30 克，甘遂、细辛各 15 克，麝香 1.5 克，共为细末，姜汁调糊，每穴用药 3 克左右，摊

于4×4厘米的胶布上，分别敷于肺俞、膏肓、天突等穴，每次敷灸3—5小时，敷后，皮肤局部可有麻痛感或起泡。于每年的夏季初、中、末伏各敷灸一次，最好连续敷灸3个夏季，此法以专治咳喘著称，即所谓的“冬病夏治”之法。

吴茱萸灸 将吴茱萸研为细末，用陈醋调为糊状，敷于穴位上，油纸覆盖，胶布固定，每日敷灸1次。如敷灸涌泉穴适用于高血压、口腔溃疡及小儿水肿；如与黄连共研细末，加醋调成糊状，敷于涌泉穴上，适用于治疗急性扁桃体炎。

乌梅灸 取乌梅肉2克，加陈醋捣成膏，敷于患处。如治疗鸡眼、脚垫，敷灸前先用温水浸泡患处，以刀刮去表面角质层，取药膏贴于患处，胶布固定，每次敷灸12小时。取下药后，以刀刮去表层，再取上药膏贴之，以愈为度。

除上述介绍的敷灸方法以外，尚有毛茛灸、川芎灸、山楂灸、桃仁灸、透骨草灸、益智仁灸、蓖麻仁灸、薄荷叶灸等40余种敷灸方法。

2. **硫磺灸**：是用硫磺作为施灸材料的一种灸法。根据疮口大小取硫磺一块，置于疮口之上。另取硫磺少许点燃，再以此焰点燃疮口上的硫磺（也有用艾火施灸的），灸至疮口脓水干为度。此法适用于顽固性疮疡及形成瘰管者。

3. **黄蜡灸**：是将黄蜡烤热熔化，用以施灸的方法。先将面粉调成湿面团，沿溃疡肿根围一圈，高出皮肤3厘米左右，圈外围布数层（避免烘烤正

常皮肤)，圈内置优质黄蜡片约1厘米厚，用铜勺（或铁勺）盛炭火在蜡上烘烤，使之熔化，皮肤有热痛感即可。如疮疡肿毒较深，可随灸随添蜡，以添到面围圈满为度。如灸至蜡液沸动，病人施灸处先有痒感，继则痛不可忍，应立即停止施灸，然后洒少许冷水于蜡上，冷却后揭去围布，去除面团及黄蜡。此法与现代蜡疗有相似之处，有拔毒消肿作用，适用于风寒湿痹、无名肿毒、痈疖、脓疮等。

4. 灯火灸：又名“灯草灸”、“油捻灸”、或称“打灯火”、“十三元霄火”。是用中药灯芯草蘸麻油点燃后快速按在穴位上进行淬烫的方法。本法具有疏风散表、行气祛痰、解郁开胸、醒脑止疼的作用，灯火灸在我国民间广为流传，尤以小儿科最为常用。具体方法是：根据病情选定穴位，并做好标记，取灯芯草一根（约5—10厘米），一端浸入植物油中约1厘米，燃火前用软棉纸吸去灯芯草上的浮油，以防点火后油滴烫伤皮肤，施术者以手拇、食二指捏住灯芯草上1/3处，即可点火，火焰不要过大，将点火一端向穴位移动，然后立即垂直接触所选穴位，要做到动作快捷，一触即离，此时从穴位点引出一股气流，将灯芯草头部爆出，并发出清脆的“啪”响，火亦随之熄灭，此为1壮，如无“啪”声，应重复施灸1次（见图12），一般灼灸2—4壮。灸后局部皮肤稍微灼伤，偶可有小水泡，3、4天后会自然吸收消失。灸后局部应保持清洁，防止感染。此法适用于小儿急性病证，如惊风、吐

泻、腮腺炎、扁桃体炎、麻疹、脐风等，也可用于胃痛、腹痛等。

5. 火柴灸：近年来有人用火柴点燃淬灸穴位以代替灯火灸法，其效果相近，且操作更为简便易行。将选定的穴位做好标记，划燃火柴，让其自燃2—3秒后，迅速触灸穴位，这时可听到“噼叭”声，以局部皮肤稍有红晕

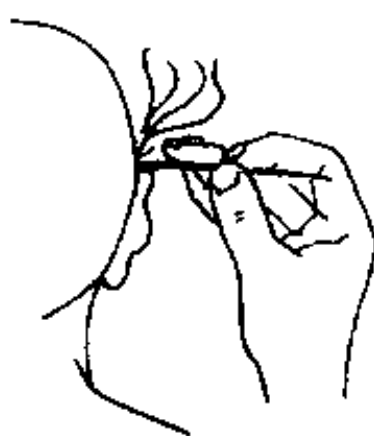


图 12 灯火灸

为度。此法适用于腮腺炎、扁桃体炎、麻疹、吐泻等。

6. 烟草灸：是用香烟代替艾卷施灸的一种方法。在没有艾卷的情况下，用香烟的烟条代替艾条，可施以悬起灸法，灸至局部皮肤潮红，皮内温热为度。此法有温经散寒活血作用，适用于风寒湿痹、寒湿痛经、冻疮及保健灸等。

7. 电热灸：是利用电热作为热源而施灸的一种灸法。使用特制的电子温灸器时，先接通电源，达到一定温度后，即可在一定的穴位上进行灸熨，每次灸10—15分钟。适用于风寒湿痹、寒性腹痛、腹泻等。本方法是现代科学技术的产物，使用方便，易于控制，疗效显著。近年不断推出的各种家庭治疗仪，部分仪器即具有电磁温热功能，均可作为灸疗器具，且可收到很好的疗效。

艾炷的制作方法

古代的艾灸，以艾炷灸法为最盛行。施灸时所燃烧的用艾绒制成的圆锥形小体称为艾炷。艾炷的制作，一般是取纯净陈久耐燃的艾绒置于桌面上，用拇、食、中三指一边捏一边旋，把艾绒捏紧，制成上尖下平如圆锥形的小体，其规格大小可因人、因病、因穴的不同而灵活掌握，临床上将其分为大、中、小三种，大艾炷高约1厘米，炷底直径约1厘米，可燃烧3—5分钟；中艾炷为大艾炷的一半；小艾炷如麦粒样。艾炷无论大小，其高度同它底面的直径大体相等。艾炷在捏制时，捏的越结实越好，如果松散，则燃烧不均匀。

施灸的体位选择

施灸时，应选择正确的体位，病人的体位是否合适，对于正确取穴和进行灸疗操作有一定影响。不舒服的体位，操作期间，往往可因病人移动体位而引起意外。选择体位应注意下列几点：

1. 选择体位应以方便、准确取穴为佳，病人肢体舒适，并能持久为原则。
2. 在可能的情况下，尽可能采取一种能将施灸部位暴露于外的体位。
3. 灸疗操作时，一般可采用卧位，尤其对于体质虚弱者。
4. 病人尽量肢体放得舒服自然，施灸时不可

随便移动，以免艾炷倾倒，出现意外。

5. 在天气寒冷、室温较低时，灸疗操作宜注意减少皮肤的暴露面，或适当减少灸疗时间，以防受凉。

常用的体位姿势有以下五种（见图 13）。



图 13 常用体位姿势

1. 仰靠坐位：适用于头面、颈前和上胸部的穴位。
2. 俯伏坐位：适用于头顶、项部和背部的穴位。
3. 侧卧位：适用于身体侧面以少阳经为主的穴位。
4. 仰卧位：适用于胸腹部以任脉、足三阴经为主的穴位。
5. 俯卧位：适用于腰背部以督脉、太阳经为主的穴位。

在坐位和卧位的基础上，根据取穴的要求，四肢可放置在适当的屈伸姿势。常用姿势有：

1. 仰掌式：适用于上肢屈（掌）侧手三阴经的穴位。

2. 曲肘式：适用于上肢伸（背）侧手三阳经的穴位。

3. 屈膝式：适用于下肢内、外侧和膝关节处的穴位。

艾炷灸的操作

灸疗前，应根据病人的病情、体质及所选穴位而采取适当体位，然后按以下顺序操作。

1. 点穴：灸疗效果的好坏，与取穴的准确与否关系很大，故首先应取准穴位。为防止施灸时的差错，在施灸前可先用钢笔于取准的腧穴部位做一记号，然后再下炷施灸。施灸时还必须注意不可移动体位，因变换体位，可以使腧穴因骨骼、肌肉的牵动而改变位置，这样则会影响疗效。此外，还须注意体位平直，以便明显暴露腧穴，防止艾炷放的不平，燃烧时火力不能集中，热力不易深透肌肤而降低疗效，同时也为了防止施灸时艾炷滚下，烫伤皮肤。

2. 置炷：点穴后，可先用甘油或酒精湿润穴处，然后将艾炷粘贴其上，这样既可以防止艾炷滚下，又可以防止施灸后起泡（瘢痕灸除外）。

3. 燃烧：点火可用线香或纸拈等暗火，燃点时必须先自艾尖端开始，待燃烧至病人有痛觉时，施术者可用手在施灸穴位的周围轻轻拍打，或用手轻搔腧穴周围，以分散注意力，减轻病人施灸时的疼痛。待艾炷燃毕，不必去掉艾灰，即可以将另一艾

炷粘上，继续燃烧，直至灸足应灸的壮数为止。

施灸结束后，应注意不可将灸疮擦伤，必要时可用石炭酸水涂敷周围，并用纱布遮盖，以防化脓溃烂。

施灸后，局部皮肤出现微红灼热的属正常现象，无需处理，很快即可自行消失。如因施灸过量而局部出现小水泡时，只要注意不使其擦破，即可自然吸收。若水泡较大时，可用消毒过的针具将水泡刺破，放出水液，或用注射器抽出水液，再涂以龙胆紫，并以纱布包敷。如属化脓灸者，灸疮化脓期间，要注意适当休息，保持局部清洁，可用敷料保护灸疮，待其自然愈合。

在整个灸疗过程中，施术者都要精神集中，随时观察患者的反应。并要特别注意谨防艾火脱落，误伤其他部位和衣物。

艾炷灸的壮数

每灸一个艾炷称为1壮，一般少则1—3壮，多则数十壮乃至百壮。《针灸大成》在论述中风的预防时认为：“宜急灸三里、绝骨四处，各三壮”。《扁鹊心书》在“住世之法”中则认为：“保命之法，灼艾第一，丹药第二……人至三十，可三年一灸脐下三百壮；五十，可二年一灸脐下三百壮。”施灸的壮数多少，一般可根据身体的强弱，病情的轻重，年龄大小以及施灸部位的不同而定。较大的艾炷壮数宜少，较小的艾炷壮数宜多。凡少壮男

了，新病体实的宜大炷多壮；妇孺老人，久病体弱的宜小炷少壮；头面、四肢、胸背等部位皮薄肌少，艾炷均不宜大尔多；腰腹部皮厚肉深，不妨大炷多壮。若治风寒湿痹，上实下虚之疾，欲温通经络，祛散外邪，或导引气血下行时，不过三、五、七壮足已，炷亦不宜过大；但对沉寒结冷，元气将脱等证，需振扶阳气，温散寒结时，则须大炷多壮，尤其在救急之时，甚至不计壮数，须至阳回脉起为止。

灸法的注意事项及灸疮的处理

1. 施灸前应根据所选部位或病情，采取固定、舒适，且能坚持较长时间的体位。

2. 施灸时无论采用哪种灸法，都必须注意防止艾炷滚翻，艾火脱落，以免引起烧伤。对于昏迷、肢体麻木不仁、感觉迟钝者，应防止灸过量，避免烧烫伤后起泡化脓。

3. 施灸治疗结束后，必须将燃着的艾条、艾炷熄灭，以防复燃发生火灾。

4. 施灸后穴位局部皮肤多出现红晕灸痕，并伴灼热感，一般不必处理，经数小时后即可消退而成黄色瘢痕。如灸后皮肤起泡，轻者也不必处理，数日可自行吸收，结痂而愈。若发泡灸，灸后皮肤水泡较大者，可用消毒针具刺破水泡，放出液体，外敷消毒纱布固定，再灸时将其揭开，灸后再盖上。

5. 瘢痕灸时，灸火一般较重，水泡也较大，发生灸疮，除了用消毒针具刺破水泡，放出液体，避免污染外，可用赤皮葱、薄荷适量煎汤，乘热淋洗，外敷消炎药膏，待其结痂而愈。若要防止灸疮化脓，在施灸时，热度应恰当，艾炷宜捏的紧小些，这样灸后疮面不致过大，水泡也较小，吸收的也较快。如需连续施灸，可先用消毒针刺破水泡，去除痂皮，上涂京墨汁，即可很快结痂。

经络是中医学理论体系的重要组成部分。它不仅是针法、灸法的理论基础，而且对中医临床各科都有重要指导意义。

经络的概念

解剖学概念：经络是经脉和络脉的总称。经，路径的意思，是经络系统纵行的干线；络，有网络的意思，是经脉的分支，纵横交错，网络全身，无处不至。

生理学概念：经络是运行气血的，把人体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋脉等组织器官联成一个统一的有机整体。

腧穴

腧穴是脏腑、经络之气通达于体表的特殊部位。也是针灸施术的部位。又称“穴位”。灸的刺激是通过腧穴、经络的作用，调动人体内在的抗病能力，达到防、治疾病的目的。

腧穴的分类

经过历代医家的多次整理，腧穴大体上分三类：

1. 十四经穴，简称“经穴”。是分布有在十二经脉和任、督二脉的腧穴。

2. 经外奇穴，简称“奇穴”。该类腧穴有一定的穴名，又有明显的位置，但尚未列入十四经系统的腧穴。

3. 阿是穴，即“压痛点”，无具体的名称和位置，而是以压痛点作为腧穴。

腧穴的治疗作用

1. 近治作用：这是一切腧穴的主治作用所具有的共同特点。就是这些腧穴均能治疗该穴所在部位及邻近的组织、器官、脏腑等局部病症。例如：听宫、听会等穴治耳病；中脘、梁门等能治疗胃病。

2. 远治作用：这是十四经穴主治作用的基本规律，尤其是十二经脉肘膝以下的腧穴，不仅能治疗局部病症，还可以治疗经脉循行所及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病症，甚至影响全身。例如：合谷穴不仅能治疗上肢病症，而且能治疗头面部病症，还能治疗外感病的发热；足三里穴不仅能治疗下肢病症，而且能治疗胃肠病症，还有强壮全身的作用。

3. 特殊作用：经实践证明，某些腧穴对机体的不同状态，起着双向的良性调节作用。例如：腹泻时，灸天枢能止泻；便秘时，灸天枢又能通便。心动过速或过缓时，灸内关能使心率恢复正常。还

有些腧穴的治疗作用具有相对的特异性，例如大椎能退热，至阴能矫正胎位等。

腧穴的取法

腧穴取的是否准确，可以直接影响疗效。目前常用的取穴方法分述如下

1. 自然标志取穴法：利用人体的自然标志，是取穴的基本方法。

(1) 固定标志：不受人体活动的影响。如：五官、毛发、指（趾）甲、乳头、脐及骨骼的突起和凹陷等。例如：两眉之间取印堂，两乳之间取膻中等。另外，两肩胛下角联线取至阳，两髂嵴联线平腰阳关等，是取腰背穴常用的标志。

(2) 动作标志：必须采取相应的动作才能出现标志，例如握拳于横纹头取后溪穴；张口时耳屏前凹陷处取听宫穴等。

2. 骨度分寸取穴法：是将人体自然标志的距离，规定一定的长度，折成若干等分，每等分作为1寸，这是非常重要的方法，已成为腧穴取法的准则（见表1）。

表 1 常用骨度分寸表

部位	起止点	寸数	说 明
头部	前发际至后发际	12	眉心至前发际 3 寸 大椎至后发际 3 寸
胸腹部	两乳头间	8	横寸
	胸剑联合至脐中	8	
	脐中至横骨上缘	5	
腰背部	两肩胛骨内缘之间	6	横寸
上肢	腋前纹头至肘横纹	9	
	肘横纹至腕横纹	12	
下肢	髌枢至膝中	19	“膝中”的水平线
	臀横纹至膝中	14	前面相当于犊鼻
	膝中至外踝尖	16	后面相当于委中
	膝中至内踝尖	15	

3. 手指同身寸法：是以患者的手指为标准，进行测量取穴的方法。分述如下。

(1) 中指同身寸法：以患者的中指屈曲，中节两端纹头间的距离算作 1 寸（见图 14）。



图 14 中指同身寸

(2) 拇指同身寸法：以患者拇指的指关节横度作为 1 寸（见图 15）。

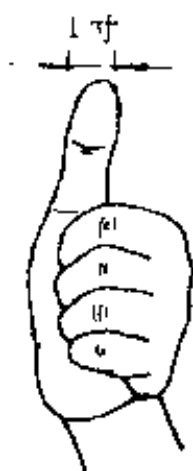


图 15 拇指同身寸

(3) 横指同身寸法：又名“一夫法”，让患者 2、3、4、5 指并拢，以中指第 1 指指关节横纹处为准，四指横量算作 3 寸（见图 16）。

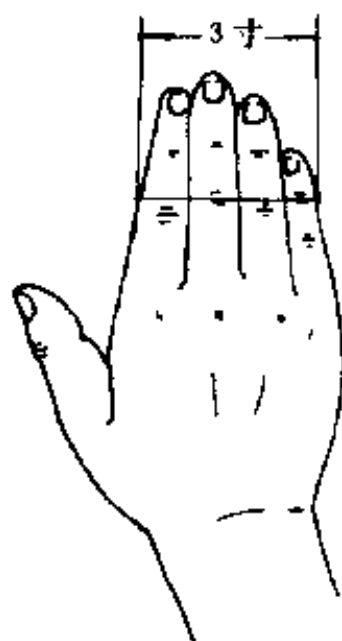


图 16 一夫寸

灸法常用的特定穴

特定穴是指十四经中具有对某些病症有特殊治疗作用的一些腧穴。现将它们的名称与应用分述如下。

1. 原穴，络穴：原穴分布在腕踝关节附近。“原”即元气的意思（见表 2）。

络穴是表里两经的联络之处所。能主治表里两经有关病症。

原穴和络穴可单独使用，也可配合使用。

2. 俞穴，募穴：“俞”穴是脏腑经气输注于腰背部的穴位，“募”穴是脏腑经气汇集在胸腹部的

表 2 十二经原穴络表

阴经	原	络
肺	太渊	列缺
心包	大陵	内关
心	神门	通里
脾	太白	公孙
肝	太冲	蠡沟
肾	太溪	大钟
阳经	原	络
大肠	合谷	偏历
三焦	阳池	外关
小肠	腕骨	支正
胃	冲阳	丰隆
胆	丘墟	光明
膀胱	京骨	飞扬

附注：脾之大络大包，任脉络穴鸠尾，督脉络穴长强。

穴位。俞募穴可以单用，也可以配合应用。某一脏腑有病可以取相应的背俞穴和募穴（见表 3）。例如：胃痛可取胃俞与中脘；咳嗽、气喘、胸闷可取肺俞与中府等。

3. 八会穴：是指人体的脏腑、气、血、筋、髓、脉等精气所会聚的俞穴；脏会章门，腑会中脘，气会膻中，血会膈俞，筋会阳陵，骨会大杼，髓会绝骨，脉会太渊。用这些俞穴可以治疗有关的

表 3 十二经俞募穴表

脏	俞穴	募穴
肺	肺俞	中府
心包	厥阴俞	膻中
心	心俞	巨阙
肝	肝俞	期门
脾	脾俞	章门
肾	肾俞	京门
腑	俞穴	募穴
大肠	大肠俞	天枢
胃	胃俞	中脘
小肠	小肠俞	关元
膀胱	膀胱俞	中极
三焦	三焦俞	石门
胆	胆俞	日月

疾病。例如：胃肠疾病，可取腑会中脘；血分有病，可取血会膈俞等。

4. 下合穴：六腑与足三阳经有较密切的联系，各有下合穴。

胃经——足三里，胆经——阳陵泉

小肠——下巨虚，膀胱经——委中

大肠——上巨虚，三焦经——委阳

治疗六腑病症时，主要应取下合穴。例如：胃痛呕吐取足三里，痢疾腹痛取上巨虚等。

5. 合穴：“合穴”是五输（井、荥、输、经、

合)穴之一(见表4)。经气在此处最盛,并由此深入汇合于脏腑,所以合穴在灸法中常用。

表4 十二经合穴表

阴经	合穴	阳经	合穴
肺	尺泽	大肠	曲池
心包	曲池	三焦	天井
心	少海	小肠	小海
脾	阴陵泉	胃	足三里
肝	曲泉	胆	阳陵泉
肾	阴谷	膀胱	委中

督脉常用腧穴

督脉有长强、腰俞、腰阳关、命门、悬枢、脊中、中枢、筋缩、至阳、灵台、神道、身柱、陶道、大椎、哑门、风府、脑户、强间、后顶、百会、前顶、囟会、上星、神庭、素髎、水沟、兑端、龈交共28穴。取常用穴如下。

1. 长强 Chángqiáng 督脉络穴

〔定位〕在尾骨端与肛门连线的中点处（见图17、图18）。

〔主治〕慢性肠炎、痢疾、遗精、阳痿、腰痛、脱肛。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

2. 腰俞 Yāoshù

〔定位〕在骶中嵴下方的凹陷处，适当骶骨裂孔（见图17、图18）。

〔主治〕腰骶神经痛、闭经、习惯性便秘、慢性肠炎、痢疾、月经不调。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—5壮）。

3. 腰阳关 Yāoyángguān

〔定位〕在腰部，后正中线上，当第4与第5腰椎棘突之间的凹陷处（见图17、图18）。

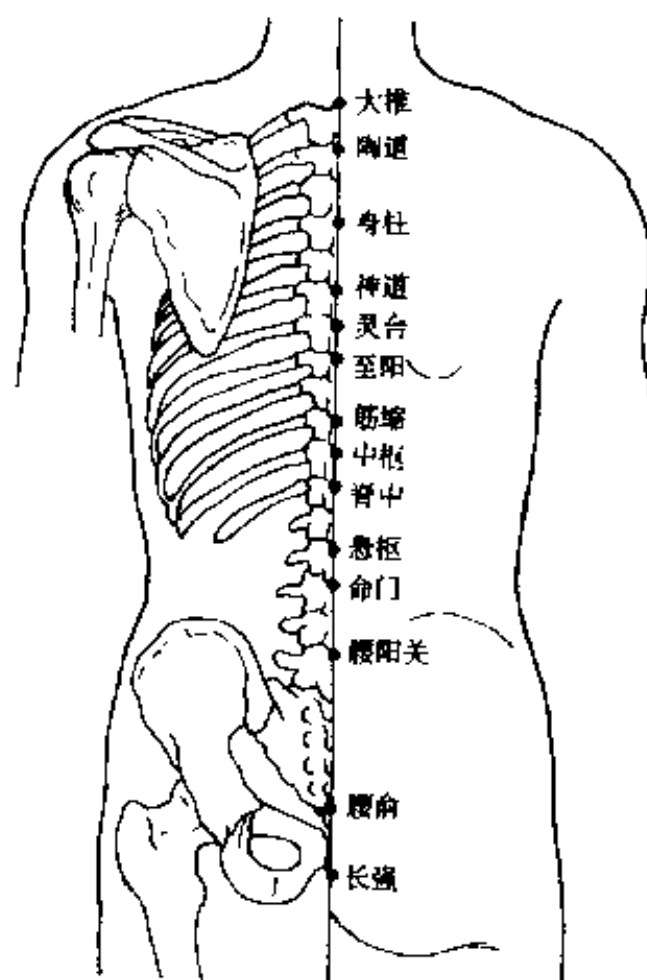


图 17 督脉骶腰背部穴

〔主治〕腰骶神经痛、膝关节炎、消化不良、痢疾、慢性肠炎、遗精等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—7 壮）。

4. 命门 Mìngmén

〔定位〕在腰部后正中线上，当第 2 与第 3 腰椎棘突之间的凹陷处（见图 17、图 18）。

〔主治〕耳鸣、月经不调、阳痿、遗精、早泄、神经衰弱等。

〔灸法〕灸
10—30 分钟（或灸
3—7 壮）。

5. 悬 枢

Xuánshū（见图 17、
图 18）

〔定位〕在腰部
后正中线上，当第 1
与第 2 腰椎棘突之间的凹陷处。

〔主治〕腰背神
经痛、慢性肠炎、胃
肠神经官能症、食欲
不振、消化不良等。

〔灸法〕灸 10—
30 分钟（或灸 3—7
壮）。

6. 脊 中

Jǐzhōng

〔定位〕在背部
后正中线上，当第
11 与第 12 胸椎棘突
之间的凹陷处（见图
17、图 18）。

〔主治〕病毒性肝炎、消化不良、食欲不振、
感冒、痢疾、慢性肠炎等。

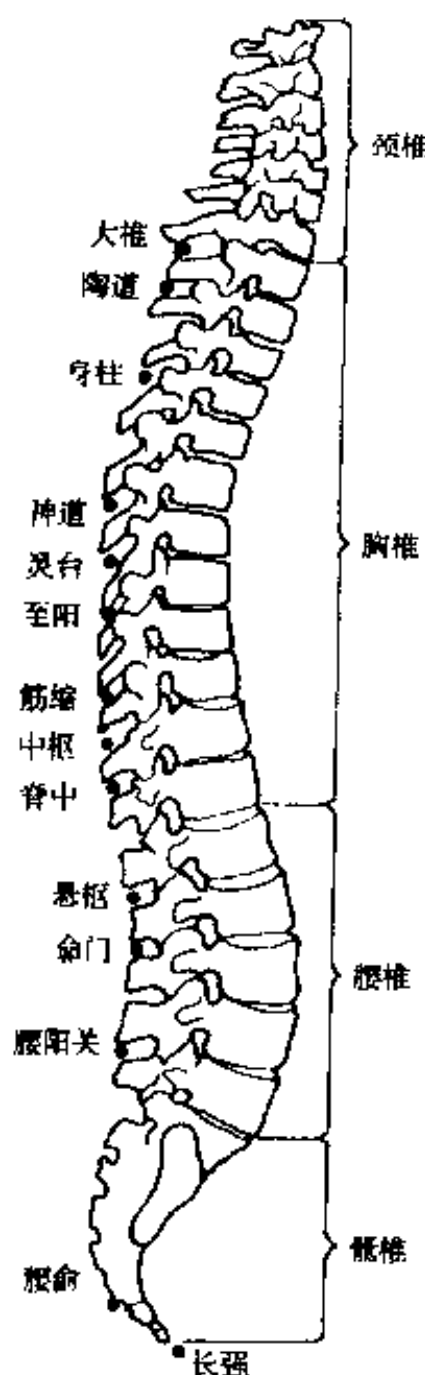


图 18 督脉骶腰背部穴
与椎骨棘突之关系

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 中枢 Zhōngshū

〔定位〕在背部后正中线上，当第 10 与第 11 胸椎棘突之间的凹陷处（见图 17、图 18）。

〔主治〕腰背神经痛、食欲减退、视神经衰弱等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—5 壮）。

8. 筋缩 Jīnsuō

〔定位〕在背部后正中线上，当第 9 与第 10 胸椎棘突之间的凹陷处（见图 17、图 18）。

〔主治〕腰背神经痛、病毒性肝炎、胃神经官能症、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—7 壮）。

9. 至阳 Zhìyáng

〔定位〕在背部后正中线上，当第 7 与第 8 胸椎棘突之间的凹陷处，平肩胛下角（见图 17、图 18）。

〔主治〕腰背神经痛、胃神经官能症、病毒性肝炎、食欲减退、慢性胃炎、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—5 壮）。

10. 灵台 Língtái

〔定位〕在背部后正中线上，当第 6 与第 7 胸椎棘突之间的凹陷处（见图 17、图 18）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、肋间神经痛、腰背神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—5 壮）。

11. 神道 Shéndào

〔定位〕在背部后正中线上，当第5与第6胸椎棘突之间的凹陷处（见图17、图18）。

〔主治〕心绞痛、冠心病、心脏神经官能症、神经衰弱、口腔炎、肋间神经痛、慢性肠炎、支气管炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—5壮）。

12. 身柱 Shēnzhù

〔定位〕在背部后正中线上，当第3与第4胸椎棘突之间的凹陷处（见图17、图18）。

〔主治〕胸背神经痛、支气管炎、支气管喘息、神经衰弱等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—7壮）。

13. 陶道 Táodào

〔定位〕在背上部后正中线上，当第1与第2胸椎棘突之间的凹陷处（见图17、图18）。

〔主治〕神经性头痛、神经衰弱、支气管炎、支气管喘息、经闭、荨麻疹等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—7壮）。

14. 大椎 Dàzhuī

〔定位〕在背上部后正中线上，当第7颈椎与第1胸椎棘突之间的凹陷处（见图17、图18）。

〔主治〕疟疾、感冒、支气管炎、支气管喘息、病毒性肝炎、颈椎病、齿龈炎、荨麻疹、视网膜出血、湿疹、小儿消化不良等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—7壮）。

15. 哑门 Yǎmén

〔定位〕在项部后正中线上，当后发际正中直上0.5寸，第1与第2颈椎棘突之间（见图19、图20）。

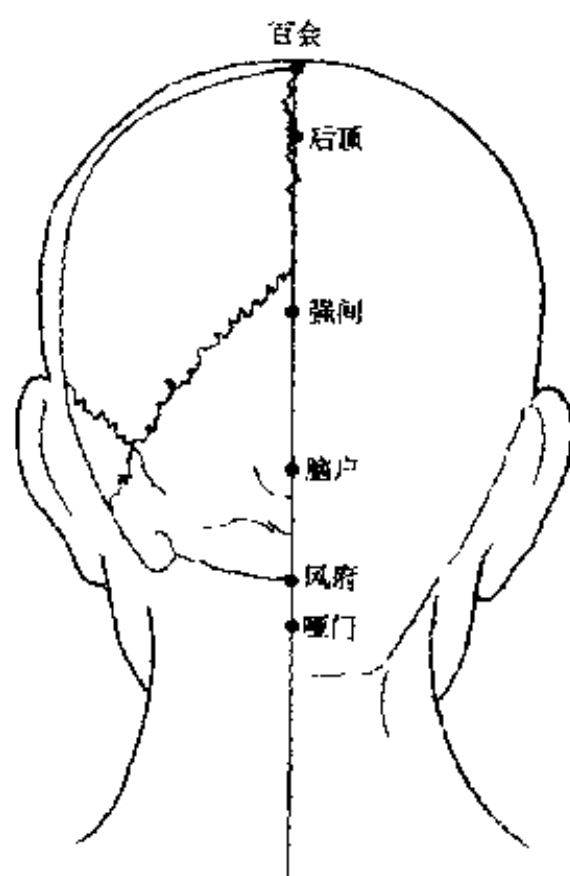


图19 督脉头颈部穴背面观

〔主治〕神经性头痛、落枕、慢性咽炎、鼻炎、神经衰弱、脑血管意外后遗症之语言障碍等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸3—5分钟。

16. 风府 Fēngfǔ

〔定位〕在项部当后发际正中直上1寸，枕骨隆凸直下，两侧斜方肌之间凹陷中（见图19、图

20)。

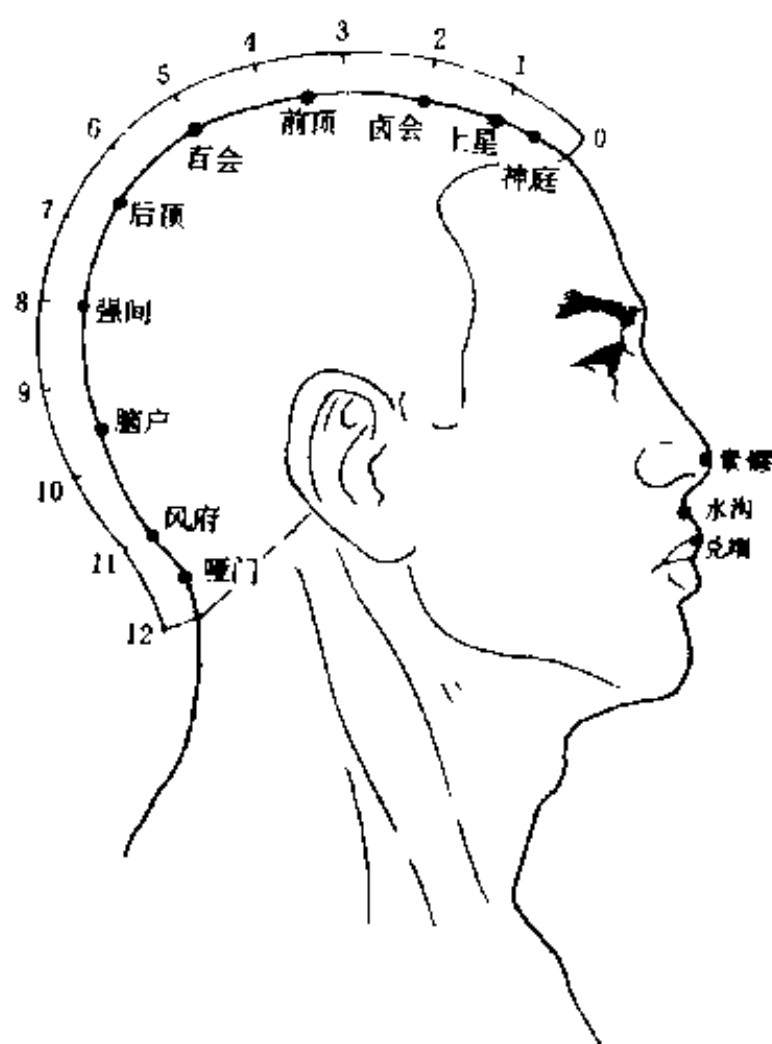


图 20 督脉头颈部穴侧面观

〔主治〕神经性头痛、颈项部神经痛、神经衰弱、脑血管意外后遗症等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 10—15 分钟。

17. 脑户 Nǎohù

〔定位〕在头部后发际正中直上 2.5 寸，风府上 1.5 寸（见图 19、图 20）。

〔主治〕近视眼、颈项强痛、神经性头痛等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

18. 强间 Qiángjiān

〔定位〕在头部当后发际正中直上 4 寸，脑户上 1.5 寸（见图 19、图 20）。

〔主治〕低血压、胃神经官能症、失眠、神经衰弱等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

19. 后顶 Hòudǐng

〔定位〕在头部当后发际正中上 5.5 寸，百会穴后 1.5 寸（见图 19、图 20）。

〔主滞〕偏头痛、低血压、神经官能症等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

20. 百会 Bǎihuì

〔定位〕在头顶部正中线上，当前发际正中直上 5 寸。简易取穴法：两耳尖连线与头部正中线的交点处（见图 19、图 20）。

〔主治〕脑血管意外之失语、晕厥、低血压、脑供血不足、神经衰弱、功能性子宫出血等。

21. 前顶 Qiándǐng

〔定位〕在头顶部正中上，当前发际正中直上 3.5 寸，百会前 1.5 寸（见图 20）。

〔主治〕低血压、脑供血不足、脑出血后遗症，感冒、过敏性鼻炎等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

22. 囟会 Xìnghuì

〔定位〕在头顶正中线上，当发际正中直上 2

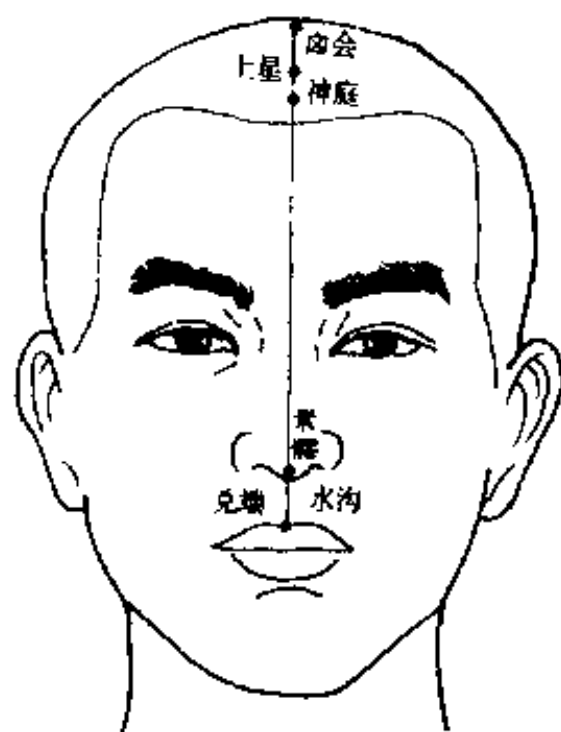


图 21 督脉头面部穴正面观

寸，百会前 3 寸（见图 20、图 21）。

〔主治〕低血压、嗜眠症、小儿消化不良等。

〔灸法〕雀啄法灸 5—10 分钟。

23. 上星 Shàngxīng

〔定位〕在头前部、当头部正中线上，前发际正中直上 1 寸（图 20、图 21）。

〔主治〕低血压、感冒、过敏性鼻炎等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

24. 神庭 Shéntíng

〔定位〕在头前部当前发际正中直上 0.5 寸（见图 20、图 21）。

〔主治〕额神经痛、急性鼻炎、心动过速、神经官能症等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 5—10 分钟。

25. 素髻 Sùjié

〔定位〕在面部，当鼻尖的正中央（见图 20、图 21）。

〔主治〕鼻炎、过敏性鼻炎、酒糟鼻、低血压等。

〔灸法〕雀啄灸或温和灸 3—5 分钟。

任脉常用腧穴

任脉有会阴、曲骨、中极、关元、石门、气海、阴交、神阙、水分、下脘、建里、中脘、上脘、巨阙、鸠尾、中庭、膻中、玉堂、紫宫、华盖、璇玑、天突、廉泉、承浆等 24 个穴。取常用穴如下。

1. 曲骨 Qūgǔ

〔定位〕耻骨联合上缘，脐下 5 寸（见图 22）。

〔主治〕遗精、肾盂肾炎、子宫内膜炎、子宫颈糜烂、产后宫缩无力、产后宫缩痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

2. 中极 Zhōngjí 膀胱募穴

〔定位〕脐中下 4 寸，曲骨上 1 寸（见图 22）。

〔主治〕遗精、阳痿、遗尿、肾盂肾炎、膀胱括约肌麻痹、产后恶露不止、月经不调、痛经、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—7 壮）。

3. 关元 Guānyuán 小肠募穴

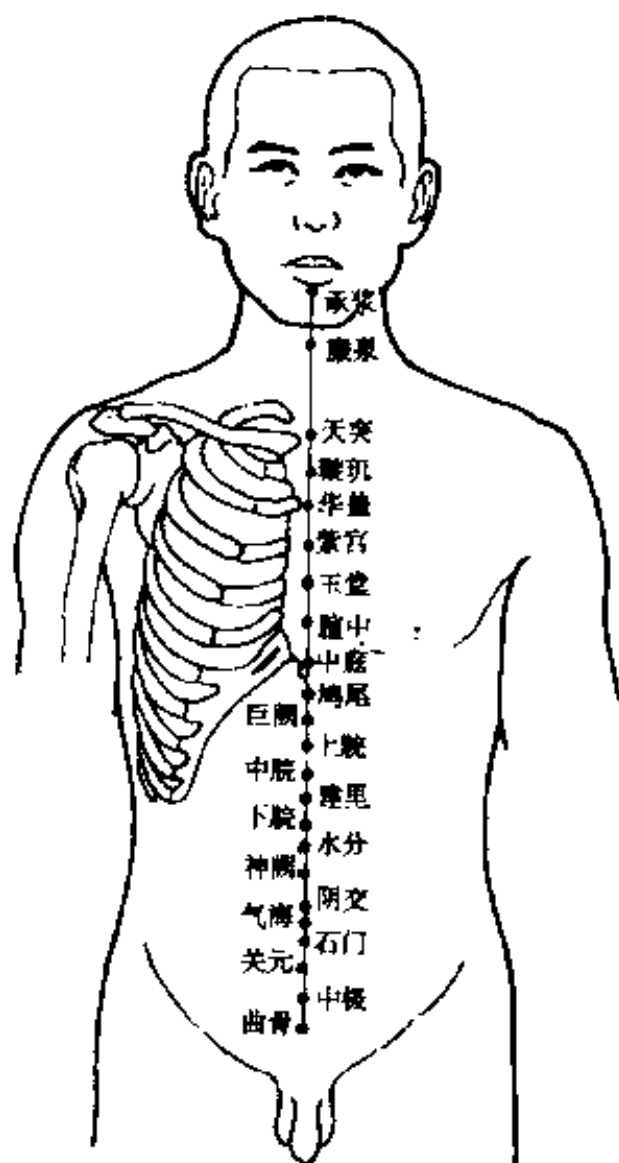


图 22 任脉腹胸颈颏部穴

〔定位〕当脐中下 3 寸，曲骨穴上 2 寸（见图 22）。

〔主治〕消化不良、慢性肠炎、肠神经官能症、身体虚弱、肾盂肾炎、睾丸炎、遗精、阳痿、早泄、遗尿、痛经、产后恶露不止、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—10 壮）。

4. 石门 Shímén 三焦募穴

〔定位〕当脐中下 2 寸，关元穴上 1 寸（见图 22）。

〔主治〕遗精、阳痿、早泄、产后恶露不止、慢性肠炎、消化不良、慢性阑尾炎、经闭、功能性子宫出血，产后恶露不止等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 气海 Qìhǎi

〔定位〕当脐中下 1.5 寸（见图 22）。

〔主治〕慢性阑尾炎、慢性肠炎、习惯性便秘、消化不良、神经衰弱、身体虚弱、功能性子宫出血、月经不调、产后恶露不止、痛经、阳痿、遗精、遗尿等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—10 壮）。

6. 阴交 Yīnjiāo

〔定位〕当脐中下 1 寸（见图 22）。

〔主治〕肾盂肾炎、子宫内膜炎、月经不调、功能性子宫出血、睾丸炎、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—10 壮）。

7. 神阙 Shénquē

〔定位〕脐中央（见图 22）。

〔主治〕慢性肠炎、痢疾、消化不良、肾盂肾炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—10 壮）。最好是脐部放食盐施隔盐灸。

8. 水分 Shuǐfēn

〔定位〕当脐中上1寸（见图22）。

〔主治〕消化不良、腹直肌痉挛、慢性肠炎、食欲减退、腰肌劳损等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸5—10壮）。

9. 下脘 Xiàwǎn

〔定位〕当脐中上2寸（见图22）。

〔主治〕胃神经官能症、消化不良、胃与十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性肠炎、呕吐等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸5—10壮）。

10. 建里 Jiànlǐ

〔定位〕当脐中上3寸（见图22）。

〔主治〕胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、慢性胃炎、食欲不振、消化不良、腹肌痉挛等。

〔灸法〕灸20—30分钟（或灸5—8壮）。

11. 中脘 Zhōngwǎn 胃之募穴、腑会穴

〔定位〕当脐中上4寸（见图22）。

〔主治〕慢性胃炎、胃神经官能症、食欲不振、胃与十二指肠溃疡、胃下垂、慢性肠炎、消化不良、膈肌痉挛、支气管喘息、高血压病、神经衰弱、荨麻疹等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸5—10壮）。

12. 上脘 Shàngwǎn

〔定位〕当脐中上5寸（见图22）。

〔主治〕慢性胃炎、胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、食欲不振、消化不良、慢性肠炎、支气

管炎、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸 20—30 分钟（或灸 5—10 壮）。

13. 巨阙 Jùquè 心之募穴

〔定位〕当脐中上 6 寸（见图 22）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心脏神经官能症、膈肌痉挛、胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、慢性胃炎、腹直肌痉挛、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸 20—30 分钟（或灸 5—10 壮）。

14. 鸠尾 Jiūwěi 任脉络穴

〔定位〕当胸剑联合下 1 寸（见图 22）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、支气管炎、支气管喘息、慢性胃炎、神经衰弱、肋间神经痛、胃神经官能症、偏头痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—10 壮）。

15. 中庭 Zhōngtíng

〔定位〕膻中穴下 1.6 寸（见图 22）。

〔主治〕心绞痛、支气管喘息、支气管炎、食欲不振等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—5 壮）。

16. 膻中 Shànzhōng 心包之募穴、气会穴。

〔定位〕当胸正中线上，两乳头连线的中点，平第 4 肋间（见图 22）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心脏神经官能症、肋间神经痛、食道痉挛、支气管喘息、支气管炎、妇人乳汁少等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 5—7 壮）。

17. 玉堂 Yùtáng

〔定位〕当前正中线上平第3肋间膻中穴上1.6寸（见图22）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、支气管喘息、支气管炎等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

18. 紫宫 Zǐgōng

〔定位〕当前正中线上，平第2肋间（见图22）。

〔主治〕胸膜炎、食道痉挛、食欲不振、支气管炎、支气管哮喘等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

19. 华盖 Huágài

〔定位〕当前正中线在胸骨角上（见图22）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、肋间神经痛、慢性喉炎、声门肌痉挛。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

20. 璇玑 Xuánjī

〔定位〕当前正中线上，天突下1寸（见图22）。

〔主治〕肋间神经痛、支气管炎、支气管哮喘、慢性喉炎、食道痉挛等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

21. 天突 Tiāntū

〔定位〕在颈部前正中线上，胸骨上窝中央（见图22、图23）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、慢性喉炎、慢性咽炎、神经官能症、膈肌痉挛、食道痉挛。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。



图 23 天突穴、廉泉穴、承浆穴

22. 廉泉

Liánquán

〔定位〕颈部喉结上方，舌骨上缘凹陷中（见图 22、图 23）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、慢性喉炎、舌炎、脑血管意外后遗症之语言障碍等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 2—7 壮）。

23. 承浆 Chéngjiāng

〔定位〕下唇之下，当颏唇沟凹陷处（见图 22、图 23）。

〔主治〕面瘫、齿神经痛、舌炎、口腔炎等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

手太阴肺经穴

肺经有中府、云门、天府、侠白、尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际、少商共 11 穴。取常用穴如下。

1. 中府 Zhōngfǔ 肺之募穴

〔定位〕在胸廓的上外方，去任脉6寸，平第1肋间隙（见图24）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、扁桃体炎、胸大肌疼痛等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

2. 云门 Yúnmén

〔定位〕在胸廓上外方，锁骨端下窝凹陷处，距前正中线6寸（见图24）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、扁桃体炎、臂丛神经痛、肋间神经痛、心脏神经官能症、颈淋巴结结核等。

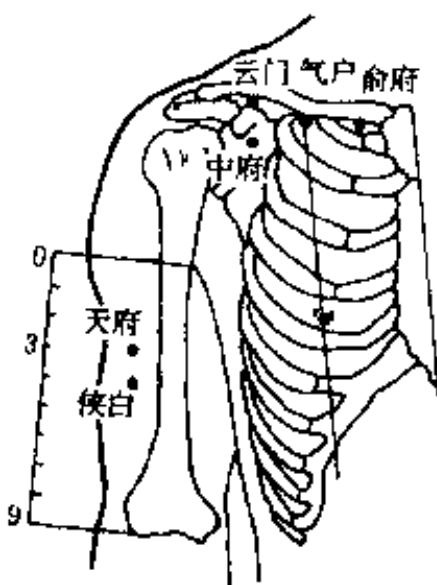


图24 肺经胸臂部穴

〔灸法〕灸10—20分钟（或3—9壮）。

3. 尺泽 Chǐzé 合穴

〔定位〕在肘部掌侧面，当时掌侧横纹桡侧端处，肱二头肌腱桡侧凹陷处（见图25）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、膀胱括约肌麻痹、神经衰弱、前臂部痉挛、肩胛神经痛、遗尿、经闭、无脉症等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

4. 孔最 Kǒngzuì

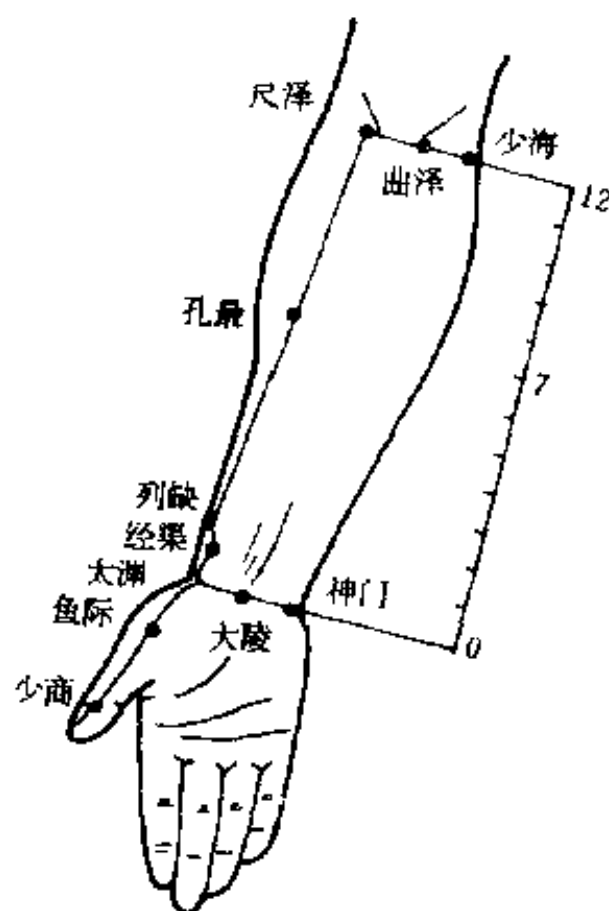


图 25 脉经前臂、手部穴

〔定位〕在前臂掌侧面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上 7 寸（见图 25）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、咽喉炎、感冒、前臂神经痛、指关节炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

5. 列缺 Lièquē 络穴

〔定位〕在前臂桡侧缘、桡骨茎突上方，太渊穴斜上 1.5 寸，当肱桡肌与拇长展肌腱之间，两虎口交叉，食指尽头是穴（见图 25、图 26）。

〔主治〕面瘫、头项痛、支气管喘息、偏瘫等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。



图 26 列缺穴

6. 经渠 Jīngú

〔定位〕在前臂掌面桡侧下段，腕横纹上 1 寸，可摸到桡动脉的搏动处，桡骨茎突与桡动脉之间凹陷处（见图 25）。

〔主治〕扁桃体炎、支气管喘息、食道痉挛、膈肌痉挛、桡神经痛或麻痹等。

〔灸法〕雀啄灸 5—10 分钟。

7. 太渊 Tàiyuān 原穴

〔定位〕在掌侧腕横纹上、于桡动脉桡侧缘凹陷中（见图 25）。

〔主治〕支气管炎、无脉症、肋间神经痛、前臂神经痛、经闭等。

〔灸法〕雀啄灸 5—10 分钟。

8. 鱼际 Yújì

〔定位〕在手掌侧面鱼际部的桡侧缘，当第 1 掌骨中点桡侧（见图 25）。

〔主治〕高血压、心脏神经官能症、失眠、扁桃体炎、支气管炎、咽喉炎、胸背痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

9. 少商 Shàoshāng

〔定位〕在手拇指末节桡侧，距甲角 0.1 寸

(见图 25)。

〔主治〕高血压病、喉炎、腮腺炎、扁桃体炎、食道狭窄、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 3 分钟（或灸 1 壮）。

手阳明大肠经穴

大肠经有商阳、二间、三间、合谷、阳溪、偏历、温溜、下廉、上廉、手三里、曲池、肘髎、手五里、臂臑、肩髃、巨骨、天鼎、扶突、口禾髎、迎香 20 穴。取常用穴如下。

1. 商阳 Shāngyáng

〔定位〕在食指桡侧，距指甲角 0.1 寸(见图 27)。



图 27 大肠经手部穴

〔主治〕腮腺炎、扁桃体炎、咽炎、齿痛等。

〔灸法〕灸 3 分钟（或灸 1 壮）。

2. 二间 Èrjiān

〔定位〕在手食指根部桡侧，握拳时在第2掌指关节前下方之凹陷处（见图27）。

〔主治〕喉炎、扁桃体炎、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸2—3壮）。

3. 三间 Sānjiān

〔定位〕在手背部，当第2掌指关节后，桡侧凹陷处（见图27）。

〔主治〕扁桃体炎、肩关节炎、臂丛神经痛、慢性肠炎等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸2—3壮）。

4. 合谷 Hégu 原穴

〔定位〕在第1、2掌骨之间，当第2掌骨桡侧中点取之（见图27）。

〔主治〕无脉症、高血压、心绞痛、喉炎、面瘫、偏瘫、臂丛神经痛、腮腺炎、耳鸣、牙痛、扁桃体炎、失眠、神经衰弱、荨麻疹等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

5. 阳溪 Yángxī

〔定位〕在腕背侧横纹桡侧，手拇指向上翘起时，当拇长展肌腱、拇短伸肌腱与拇长伸肌腱和桡骨下端所构成的凹陷处（见图27、28）。

〔主治〕神经性头痛、耳鸣、扁桃体炎、牙痛、偏瘫、腕关节炎等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸5—7壮）。

6. 偏历 Piánlì 络穴

〔定位〕在前臂背面桡侧的下段，在阳溪上3

寸。即当阳溪与曲池间连线之下 $1/2$ 段的中点处 (见图 28)。

〔主治〕 耳鸣、牙痛、肩关节以下至腕部的神经痛及麻痹或痉挛、喉炎、扁桃体炎、面瘫、偏瘫等。

〔灸法〕 灸 5—20 分钟 (或灸 3—7 壮)。

7. 温溜 Wēnlǚ

〔定位〕 在前臂背面桡侧的中部，当阳溪穴与曲池穴间连线上，即阳溪穴上 5 寸 (见图 28)。

〔主治〕 肠炎、舌炎、口腔炎、腮腺炎、扁桃体炎、前臂痛等。

〔灸法〕 灸 10—30 分钟 (或灸 3—9 壮)。

8. 下廉 Xiàlián

〔定位〕 在前臂背侧面桡侧上段，当阳溪与曲池穴连线上，在阳溪上 8 寸，曲池下 4 寸处 (见图 28)。

〔主治〕 前臂神经痛、肘关节炎、神经性头痛、膀胱括约肌麻痹、肠炎、心绞痛、支气管喘息、支气管炎、乳房炎。

〔灸法〕 灸 5—20 分钟 (或灸 3—7 壮)。

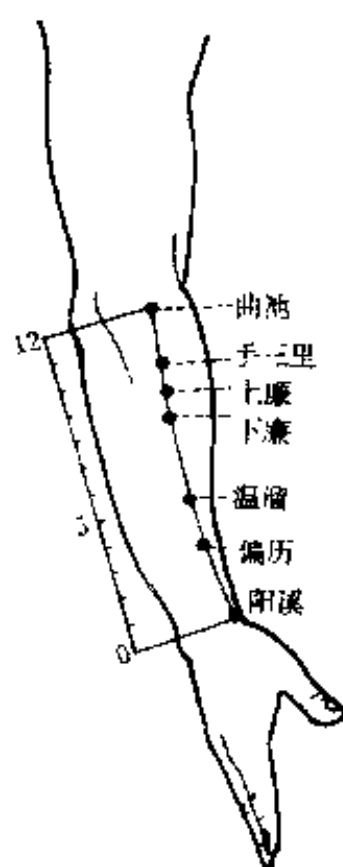


图 28 大肠经臂穴

9. 上廉 Shànglián

〔定位〕在前臂背面桡侧的上段，当阳溪与曲池连线上，在曲池穴下3寸（见图28）。

〔主治〕膀胱括约肌麻痹、肾盂肾炎、偏瘫、面瘫、支气管喘息、头痛、肠炎等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

10. 手三里 Shǒusānlǐ

〔定位〕在前臂背面桡侧的上段，在曲池穴下2寸处（见图28）。

〔主治〕牙痛、口颊炎、颈淋巴结炎、臂丛神经痛、偏瘫、面瘫、乳房炎、腮腺炎、感冒、肠炎、高血压病等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

11. 曲池 Qūchí 合穴

〔定位〕屈肘在肘部的桡侧，当尺泽穴与肱骨外髁之间的中点处（见图28、图29）。

〔主治〕扁桃体炎、臂丛神经痛、肩关节炎、肘关节炎、偏瘫、高血压、无脉症、肋间神经痛、神经衰弱、荨麻疹、支气管炎、支气管喘息、雷诺氏病等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

12. 肘髎 Zhǒuliáo

〔定位〕在上臂外侧面的下段，屈肘，曲池上1寸，当肱骨边缘处（见图29）。

〔主治〕臂丛神经痛、肘关节炎、肩关节炎、上肢麻痹等。

〔灸法〕灸
10—20 分钟（或
灸 3—7 壮）。

13. 臂臑

Bìnào

〔定位〕在臂部后外侧面的上段，曲池与肩髃连线上，曲池穴上 7 寸，三角肌抵止部后缘处（见图 29、图 30）。

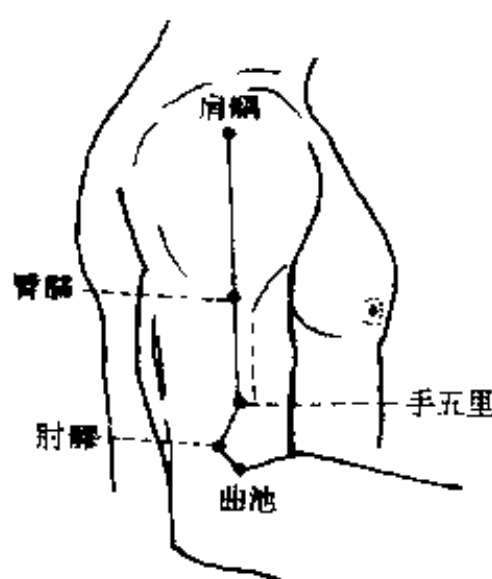


图 29 大肠经臂部穴

〔主治〕臂丛神经痛、肩关节炎、肩关节周围炎、颈淋巴结结核等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

14. 肩髃 Jiānyú

〔定位〕在肩部，肩峰与肱骨大结节之间的凹陷处，臂外展至水平位时，肩峰下可出现一明显的凹陷即是（见图 29）。

〔主治〕偏瘫、高血压病、肩关节周围炎、肩关节炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

15. 扶突 Fútú

〔定位〕在颈外侧部，当下颌角直下，结喉旁，当胸锁乳突肌的前、后缘之间（见图 29）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、低血压等。

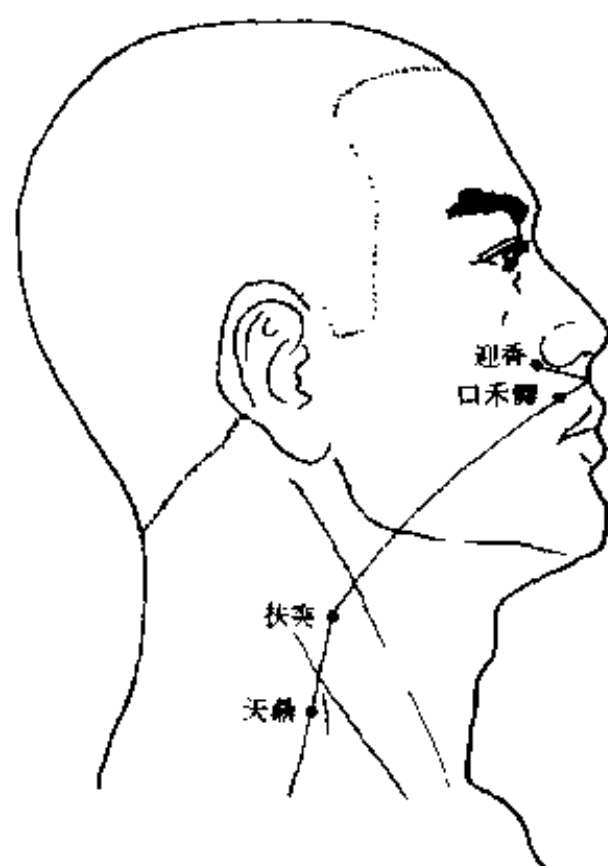


图 30 大肠经颈面部穴侧面观

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

16. 口禾髎 Kǒuhéliáo

〔定位〕在上唇部，当鼻孔外缘直下与横平水沟穴延线之交点处（见图 30）。

〔主治〕急慢性鼻炎、过敏性胃炎、面瘫、腮腺炎。

〔灸法〕灸 2 分钟，禁艾炷灸。

17. 迎香 Yíngxiāng

〔定位〕在面部，鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中（见图 30）。

〔主治〕急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、面瘫、颜

面组织炎、支气管喘息等。

〔灸法〕温和灸 3—5 分钟。

足阳明胃经穴

胃经有承泣、四白、巨髎、地仓、大迎、颊车、下关、头维、人迎、水突、气舍、缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、归来、气冲、髀关、伏兔、阴市、梁丘、犊鼻、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑 45 穴。取常用穴如下。

1. 四白 Sībái

〔定位〕在下眼睑之下方，直视时当瞳孔下 1 寸，适对眶下孔凹陷处（见图 31、图 32）。

〔主治〕视神经萎缩、低血压、上颌窦炎、面瘫、鼻炎等。

〔灸法〕灸 5 分钟（或灸 3 壮）。

2. 巨髎 Jùliáo

〔定位〕在面部，直视时当瞳孔的直下方，横平鼻翼下缘处，鼻唇沟外侧（见图 31、图 32）。

〔主治〕青光眼、白内障、三叉神经痛、视神经萎缩、面瘫、牙痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—7 壮）。

3. 地仓 Dìcāng

〔定位〕在面部，口角外 0.4 寸（见图 31、图

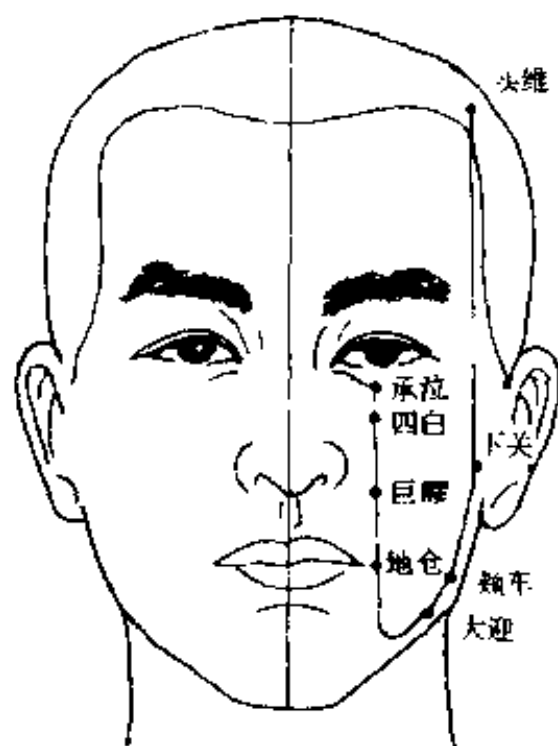


图 31 胃经头面部穴正面观

32)。

〔主治〕面瘫、牙痛、口腔炎、语言障碍等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

4. 颊车 Jiache

〔定位〕在面部，下颌角之前上方 0.8 寸，当咀嚼时咬肌隆起，按之凹陷处（见图 31、图 32）。

〔主治〕面瘫、喉炎、口颊炎、牙痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 下关 Xiaguan 会穴

〔定位〕在面部，耳前方，当颧弓与下颌切迹所围成之凹陷处（见图 31、图 32）。

〔主治〕牙痛、面瘫、低血压、耳鸣等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—7 壮）。

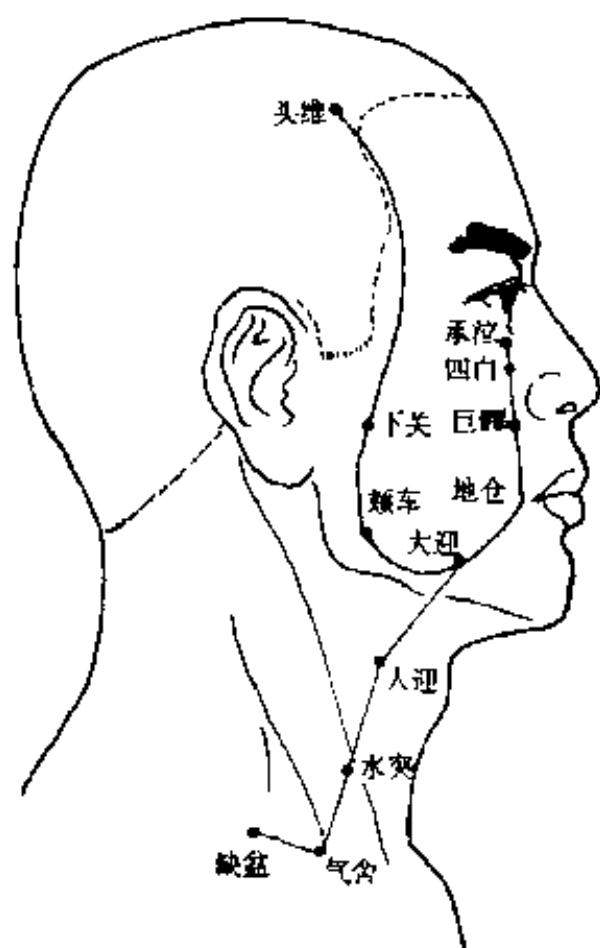


图 32 胃经头颈部穴侧面观

6. 头维 Tóuwéi

〔定位〕在头侧部，前发际额角的上外方，入发际 0.5 寸，去督脉神庭穴 4.5 寸（见图 31、图 32）。

〔主治〕额神经痛、偏头痛、视力减退、面瘫等。

〔灸法〕温和灸 5—10 分钟。

7. 缺盆 Quēpén

〔定位〕在颈外侧部，当锁骨上窝中央，距前正中线 4 寸（见图 32、图 33）。

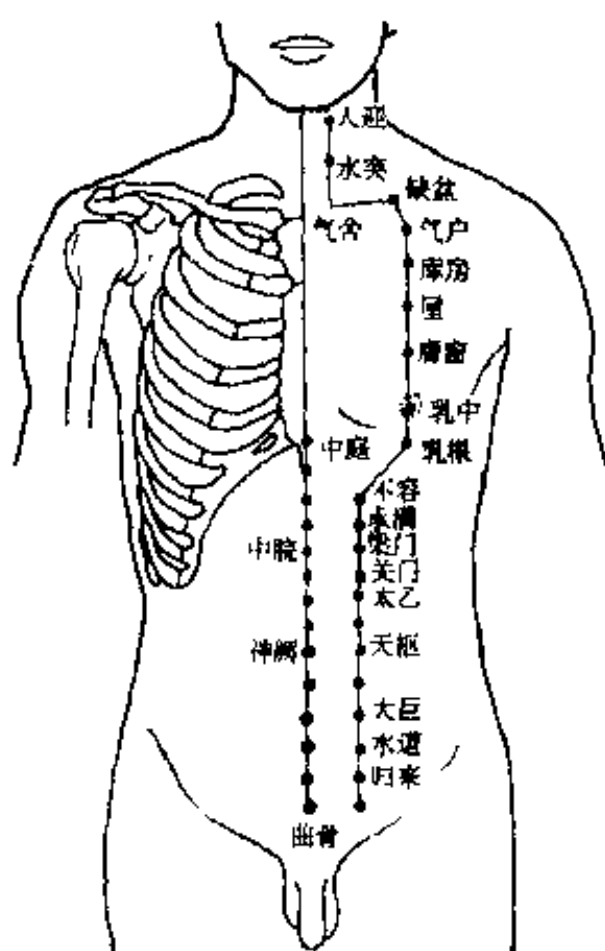


图 33 胃经胸腹部穴

〔主治〕支气管喘息、肋间神经痛、扁桃体炎、颈淋巴结结核等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

8. 气户 Qihu

〔定位〕在胸上部，当锁骨中点下缘，距前正中线 4 寸（见图 33）。

〔主治〕支气管喘息、慢性支气管炎、膈肌痉挛、百日咳等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

9. 膺窗 Yingchuang

〔定位〕在胸部，当第3肋间隙、距前正中线4寸（见图33）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、产后缺乳、乳房炎、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

10. 乳根 Rǔgēn

〔定位〕在胸部，当乳头直下，乳房根部第5肋间隙、距前正中线4寸（见图33）。

〔主治〕乳房炎、产后缺乳、支气管炎、肋间神经痛、臂丛神经疼痛等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

11. 不容 Bùróng

〔定位〕在腹上部，当脐中上6寸，距前正中线2寸，即任脉巨阙穴的外侧2寸处（见图33）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、胃痛、肋间神经痛、腹直肌痉挛等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸5—9壮）。

12. 承满 Chéngmǎn

〔定位〕在腹上部，即任脉上脘穴旁2寸处（见图33）。

〔主治〕支气管炎、食道痉挛、食欲不振、消化不良、肠炎、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸5—9壮）。

13. 梁门 Liángmén

〔定位〕在上腹部，即任脉中脘穴外2寸处（见图33）。

〔主治〕慢性胃炎、食欲减退、消化不良、胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、胃下垂等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

14. 关门 Guānmén

〔定位〕在任脉建里穴旁 2 寸处（见图 33）。

〔主治〕慢性胃炎、胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、食欲不振、消化不良、肠炎、习惯性便秘等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

15. 太乙 Tàiyì

〔定位〕在任脉下脘穴旁 2 寸处（见图 33）。

〔主治〕慢性胃炎、胃神经官能症、食欲不振、消化不良等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

16. 天枢 Tiānshū 大肠募穴

〔定位〕在神阙穴旁 2 寸处（见图 33）。

〔主治〕慢性胃炎、胃下垂、肠炎、痢疾、习惯性便秘、子宫内膜炎、月经不调等。

〔灸法〕灸 10—50 分钟（或灸 5—15 壮）。

17. 大巨 Dàjù

〔定位〕在任脉石门穴旁 2 寸处（见图 33）。

〔主治〕失眠、四肢倦怠、消化不良、习惯性便秘、遗精、阳痿等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

18. 水道 Shuǐdào

〔定位〕在下腹部，任脉关元穴旁 2 寸处（见

图 33)。

〔主治〕肾盂肾炎、睾丸炎、脱肛、子宫内膜炎、卵巢炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

19. 归来 Guīlái

〔定位〕在任脉中极穴旁 2 寸处（见图 33）。

〔主治〕睾丸炎、阴茎痛、白带过多、卵巢炎、痛经、经闭等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

20. 髀关 Bìguān

〔定位〕在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，屈股时，平会阴，与膀胱经承扶穴相对（见图 34）。

〔主治〕腰痛、股神经痛、偏瘫、髌关节炎、腹股沟淋巴结炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

21. 伏兔 Fútù

〔定位〕在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上 6 寸（见图 34）。

〔主治〕偏瘫、膝关节炎、髌关节炎、股神经痛、子宫内膜炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

22. 梁丘 Liángqiū

〔定位〕在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底外侧端上 2 寸处（见图 34）。

〔主治〕胃神经官能症、膝关节炎、股神经痛、

乳房炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

23. 犊鼻 Dúbí

〔定位〕屈膝、在膝部，髌骨与髌韧带外侧凹陷中（见图 34）。

〔主治〕膝关节炎。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

24. 足三里

Zúsānlǐ 合穴

〔定位〕在小腿前外侧面的上部，犊鼻穴直下 3 寸，距胫骨前缘 1 横指（见图 34）。

〔主治〕急性慢性胃炎、消化不良、胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、胃下垂、食欲不振、身体羸瘦、四肢倦怠、口腔炎、肠炎、痢疾、便秘、病毒性肝炎、支气管喘息、动脉硬化、高血压病、神经衰弱、膈肌痉挛、偏瘫、膝关节炎、耳鸣、遗

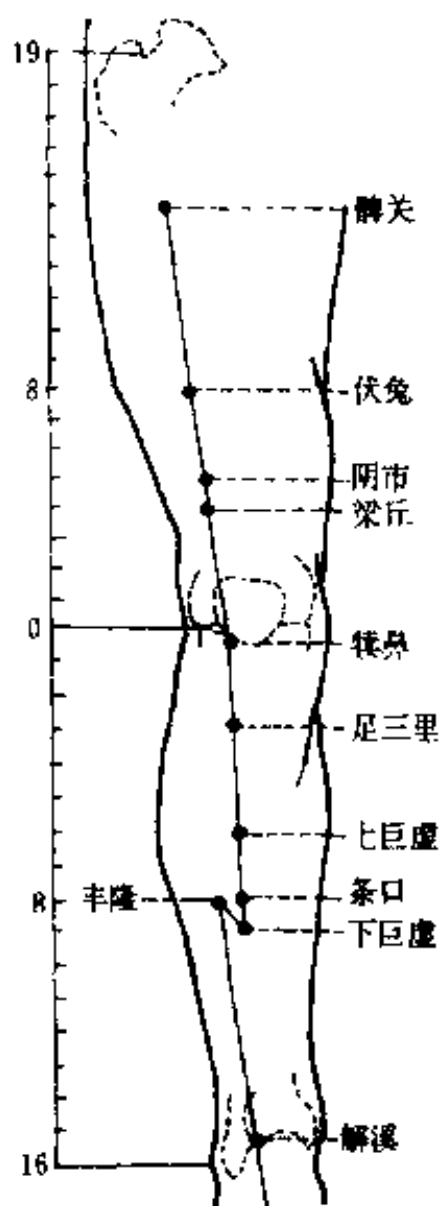


图 34 肾经下肢部穴

尿、坐骨神经痛。本穴也是全身强壮要穴之一。

〔灸法〕灸 10—50 分钟（或灸 5—10 壮）。

25. 上巨虚 Shàngjùxū 大肠下合穴

〔定位〕在小腿前外侧，当犊鼻直下 6 寸，距胫骨前缘 1 横指（见图 34）。

〔主治〕胃肠炎、阑尾炎、便秘、食欲不振、消化不良、偏瘫、膝关节炎、脑供血不足等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

26. 条口 Tiáokǒu

〔定位〕在小腿前外侧，当犊鼻下 8 寸，距胫骨前缘 1 横指（见图 34）。

〔主治〕偏瘫、膝关节炎、扁桃体炎、足心发热等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—9 壮）。

27. 下巨虚 Xiàjùxū 小肠下合穴

〔定位〕在小腿前外侧，当犊鼻下 9 寸，距胫骨前缘 1 横指（见图 34）。

〔主治〕偏瘫、脑供血不足、肋间神经痛、胃痛、扁桃体炎、食欲不振等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 5—9 壮）。

28. 丰隆 Fēnglóng 络穴

〔定位〕在小腿前外侧，当踝尖上 8 寸，条口外 1 寸处（见图 34）。

〔主治〕支气管炎咯痰多、肋间神经痛、阑尾炎、病毒性肝炎、神经官能症、高血压病、痢疾、便秘、肠炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

29. 解溪 Jiěxī

〔定位〕在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间（见图 34）。

〔主治〕风湿病、高血压病、消化不良、便秘、肠炎、踝关节炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

30. 冲阳 Chōngyāng 原穴

〔定位〕在足背部，当足背最高点处，拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间，足背动脉搏动处（见图 35）。

〔主治〕偏瘫、面瘫、足关节炎、牙痛、齿龈炎、胃肠炎、食道炎、食欲不振等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3 壮）。

31. 内庭 Nèitíng

〔定位〕在足背，当第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处（见图 35）。

〔主治〕牙痛、肠炎、便秘、胃痛、痢疾、阑尾炎、齿龈炎、喉炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

32. 厉兑 Lìduì

〔定位〕在第 2 趾末节的外侧，距趾甲角 0.1 寸（见图 35）。

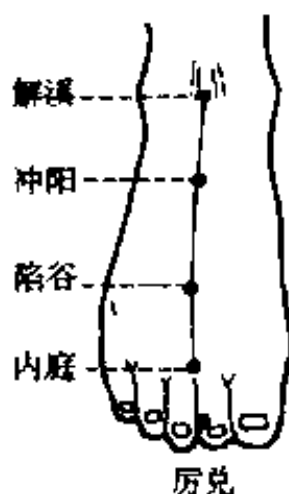


图 35 胃经足部穴

〔主治〕病毒性肝炎、消化不良、脑供血不足、扁扁桃体炎、齿龈炎、股神经痛、慢性鼻炎等。

〔灸法〕灸3分钟（或灸1壮）。

足太阴脾经穴

脾经有隐白、大都、太白、公孙、商丘、三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣、大包共21穴。取常用如下。

1. 隐白 Yǐnbái

〔定位〕在足大拇趾末节内侧，距趾甲角0.1寸（见图36）。

〔主治〕食欲不振、消化不良、肠炎、功能性子宫出血、子宫内膜炎等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸2—3壮）。

2. 大都 Dàdū

〔定位〕在足大拇趾内侧缘，当第1跖趾关节前下方赤白肉际凹陷处（见图36）。

〔主治〕全身倦怠、胃神经官能症、趾关节炎、消化不良等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸2—3壮）。

3. 太白 Tàibái 原穴

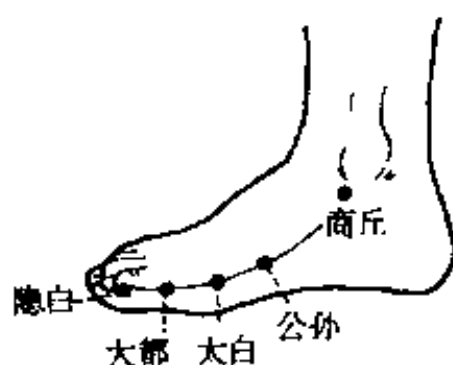


图36 脾经足部穴

〔定位〕在足内侧缘、当第1趾关节后下方赤白肉际凹陷处（见图36）。

〔主治〕胃神经官能症、消化不良、便秘、肠炎、痢疾、下肢疼痛或麻木等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

4. 公孙 Gōngsūn 络穴

〔定位〕在足内侧缘，当第1跖骨基底前下方的凹陷处（见图36）。

〔主治〕心肌炎、心绞痛、胃痛、食欲不振、肠炎、失眠、病毒性肝炎、足心热等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

5. 三阴交 Sāngyīnjiāo

〔定位〕在小腿内侧，当足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方凹陷处（见图37）。

〔主治〕胃炎、胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、胃下垂、消化不良、肠炎、食欲不振、痛经、月经不调、功能性子宫出血、经闭、阴茎痛、阳痿、遗精、早泄、糖尿病、低血压、支气管炎、便秘、踝关节炎、荨麻疹、病毒性肝炎、神经衰弱、小儿舞蹈病等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

6. 地机 Dìjī

〔定位〕在小腿内踝尖与阴陵泉的连线上，阴陵泉下3寸（见图37）。

〔主治〕腰痛、食欲不振、胃痛、水肿、小便不利、肠炎、月经不调、功能性子宫出血、男性精

子不足、遗精等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 阴陵泉

yīnlíngquán 合穴

〔定位〕在小腿内侧的上部，当胫骨内侧髁下缘，膝下 2 寸处（见图 37）。

〔主治〕食欲不振、消化不良、肠炎、肾盂肾炎、膀胱括约肌麻痹、遗精、阳痿、遗尿、阴道炎、膝关节炎、神经衰弱、心脏神经官能症等。

〔灸法〕灸 10—30 分（或灸 3—9 壮）。

8. 血海 Xuēhǎi

〔定位〕在大腿内侧，髌底内侧端上 2 寸（见图 38）。

〔主治〕功能性子宫出血、月经不调、痛经、经闭、阴部瘙痒、消化不良、湿疹、荨麻疹、贫血、膝关节炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

9. 府舍 Fǔshè

〔定位〕在任脉中极穴旁 4 寸处（见图 39）。

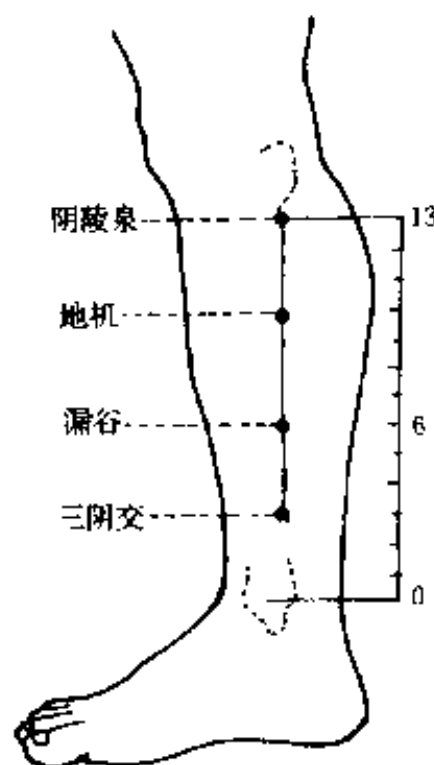


图 37 脾经小腿部穴

〔主治〕肠炎、消化不良、子宫肌瘤等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

10. 腹结 Fùjié

〔定位〕在下腹部、大横穴 1.3 寸，距前正中线 4 寸（见图 39）。

〔主治〕支气管炎、

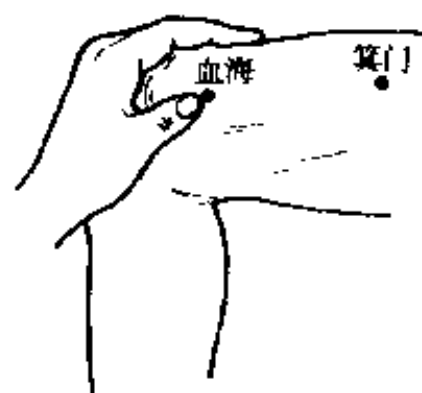


图 38 血海穴坐位观

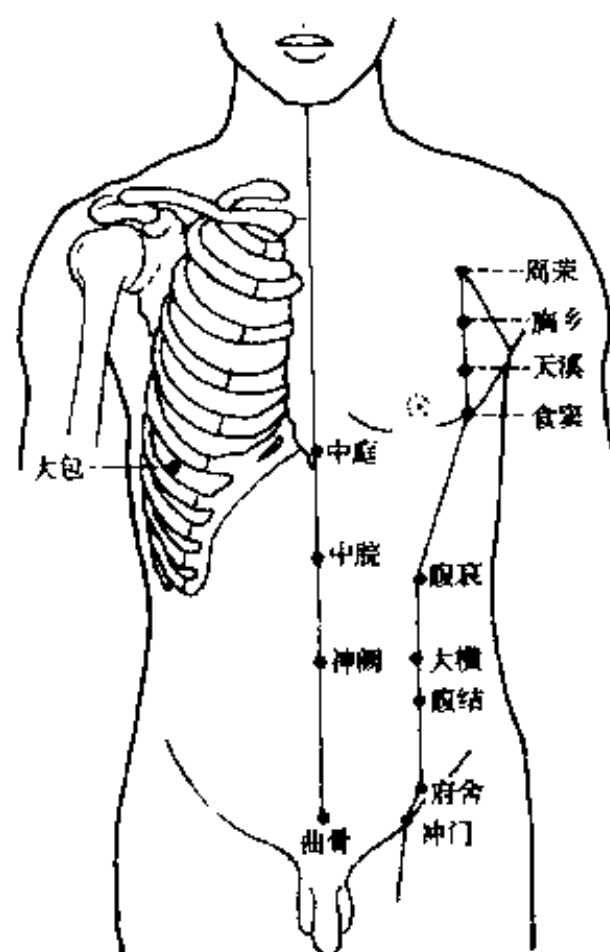


图 39 脾经腹胸部穴

肠炎、痢疾等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

11. 大横 Dàhéng

〔定位〕在中腹部，神阙穴旁开 4 寸处（见图 39）。

〔主治〕胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、胃酸过多或过少、消化不良、慢性肠炎、便秘等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

12. 天溪 Tiānxī

〔定位〕第 4 肋间，膻中穴旁 6 寸（见图 39）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、肋间神经痛、产后乳少症等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

13. 大包 Dàbāo 脾之大络

〔定位〕在侧胸部，腋中线上，第 6 肋间隙处（见图 39）。

〔主治〕支气管喘息、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

手少阴心经穴

心经有极泉、青灵、少海、灵道、通里、阴郄、神门、少府、少冲共 9 穴。取常用穴如下。

1. 极泉 Jíquán

〔定位〕在腋窝顶点，腋动脉搏动处。当肱骨头下方，喙肱肌与肱三头肌之间的凹陷处（见图 40）。



图 40 极泉、少海穴

〔主治〕心包炎、肋间神经痛、瘰病、产后缺乳、颈淋巴结核等。

〔灸法〕灸 3—10 分钟（或灸 1—3 壮）。

2. 少海 Shǎohǎi 合穴

〔定位〕在肘部前面，屈肘 90 度时肘横纹的尺侧端（见图 40）。

〔主治〕高血压病、无脉症、肘关节炎、颈淋巴结核、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

3. 通里 Tōnglǐ 络穴

〔定位〕神门穴上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘（见图 41）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心悸、失眠、腕关节痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

4. 神门 Shénmén 原穴

〔定位〕在掌侧腕横纹上，尺侧腕屈肌腱桡侧之凹陷处（见图 41）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心脏神经官能症、

高血压病、无脉症、神经衰弱、失眠、健忘、掌中热、肋间神经痛、病毒性肝炎、食欲不振、喉炎、支气管喘息、感冒等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

5. 少府 Shàofǔ

〔定位〕在手掌面，当第4、5掌骨间，握拳时，当小指尖处（见图41）。

〔主治〕肋间神经痛、心绞痛、心脏神经官能

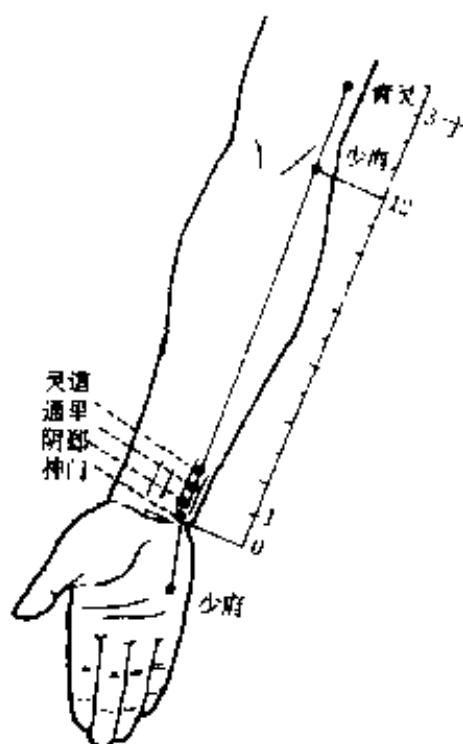


图41 心经上部穴

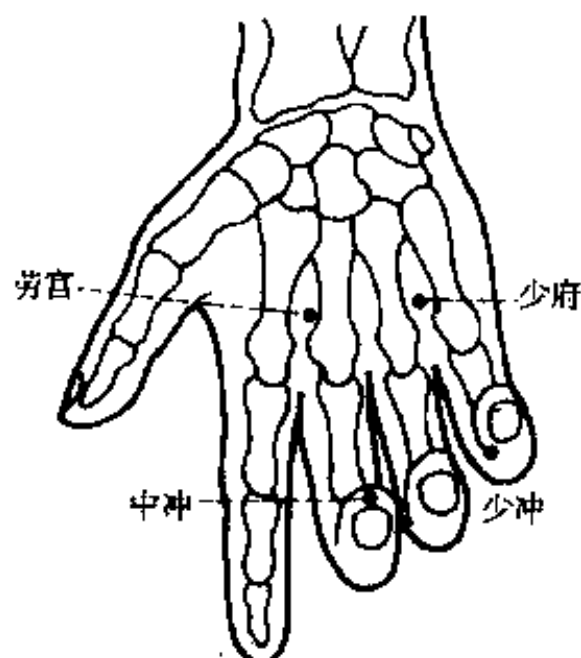


图42 心经手部穴

症、神经衰弱、遗尿症、阴痒、功能性子宫出血。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

6. 少冲 Shàochōng

〔定位〕在手小指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸（见图 42）。

〔主治〕肋间神经痛、神经衰弱、心脏神经官能症、喉炎等。

〔灸法〕灸 3—5 分钟（或灸 2—3 壮）。

手太阳小肠经穴

小肠经有少泽、前谷、后溪、腕骨、阳谷、养老、支正、小海、肩贞、臑俞、天宗、秉风、曲垣、肩外俞、肩中俞、天窗、天容、颧髎、听宫共 19 穴。取常用穴如下。

1. 少泽 Shàozé

〔定位〕在手小指末节尺侧，距指甲角 0.1 寸（见图 43）。

〔主治〕支气管炎、头痛、扁桃体炎、心绞痛、臂丛神经痛、产后缺乳、乳房炎、落枕等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

2. 前谷 Qiángǔ

〔定位〕在手小指尺侧，当第 5 掌指关节前下方之凹陷处，掌指横纹头赤白肉际（见图 43）。

〔主治〕膈肌痉挛、扁桃体炎、耳鸣、鼻炎、臂丛神经痛、产后缺乳、乳房炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

3. 后溪 Hòuxī

〔定位〕在手尺侧，第 5 掌骨小头的后方，握拳时，当远侧掌横纹头上方的凹陷处，赤白肉际（见图 43）。

〔主治〕肘臂疼痛、落枕、颈椎病、指掌关节炎、肋间神经痛、神经衰弱、病毒性肝炎、流感、扁桃体炎、后头痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—5 壮）。

4. 腕骨 Wàngǔ 原穴

〔定位〕在腕部尺侧缘，当第 5 掌骨后端与钩骨后构成关节部上方的凹陷处（见图 43）。

〔主治〕肘、腕部及指关节炎、口腔炎、肋间神经痛、病毒性肝炎、耳鸣、后头痛、神经衰弱、呕吐等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 阳谷 Yángǔ

〔定位〕在手腕部的尺侧，当尺骨茎突与三角骨之间的凹陷处（见图 43）。



图 43 小肠经手部穴

〔主治〕神经衰弱、耳鸣、腕关节炎、口腔炎、齿龈炎、腮腺炎、肋间神经痛、尺神经痛、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

6. 养老 yǎnglǎo

〔定位〕在前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹陷中（见图 43）。

〔主治〕腕关节炎、肘关节炎、落枕、颈椎病、假性近视、膈肌痉挛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 支正 Zhīzhèng 络穴

〔定位〕在前臂背面尺侧的中部，当阳谷与小海的连线上，阳谷穴上 5 寸处（见图 44）。

〔主治〕高血压病、神经衰弱、指关节炎、臂丛神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

8. 小海 Xiǎohǎi

合穴

〔定位〕在肘部的内侧，当肱骨内上髁与尺骨鹰嘴之间凹陷处（见图 44）。

〔主治〕颈椎病、肩关节周围炎、尺神经痛、齿龈炎、舞蹈病、颈淋巴

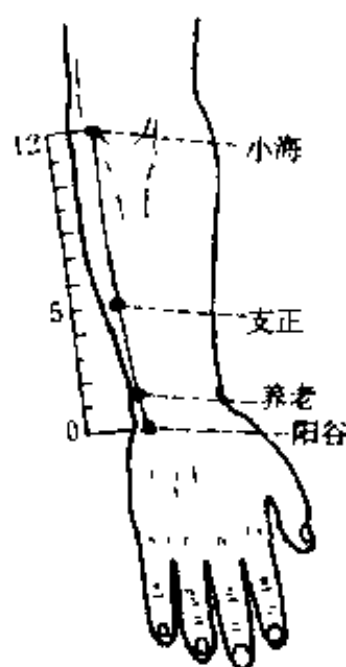


图 44 小肠经前臂穴

结核等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

9. 肩贞 Jiānzhēn

〔定位〕在肩关节后下方，臂内收时，腋后纹头上 1 寸（见图 45）。

〔主治〕耳鸣、头痛、肩胛部疼痛、肩关节炎、肩关节周围炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

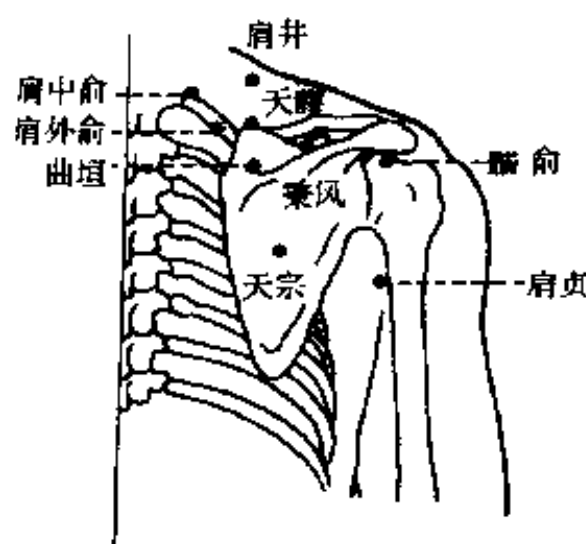


图 45 小肠经肩背部穴

10. 臑俞 Nàoshù

〔定位〕在肩部的后面，当腋后纹头直上，肩胛冈下缘凹陷中（见图 45）。

〔主治〕肩关节周围炎、肩关节炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

11. 天宗 Tiānzōng

〔定位〕在肩胛部，当冈下窝中央凹陷处，平第 4 胸椎棘突（见图 45）。

〔主治〕落枕、颈椎病、肩关节周围炎、乳房炎、支气管喘息等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

12. 肩外俞 Jiānwàishù

〔定位〕在背部，当第 1 胸椎棘突下，陶道穴旁开 3 寸（见图 45）。

〔主治〕落枕、颈椎病、肩关节周围炎、支气管炎、神经衰弱、低血压等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

13. 肩中俞 Jiānzhōngshù

〔定位〕在背部，当第 7 颈椎棘突下，大椎穴旁开 2 寸（见图 45）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、落枕、颈椎病、肩关节周围炎、视力减退等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

14. 天容 Tiānróng

〔定位〕在颈外侧部的上部，当下颌角的后方，胸锁乳突肌的前缘凹陷中（见图 46）。

〔主治〕耳鸣、咽喉炎、齿龈炎、落枕、颈淋巴结结核、肋间神经痛、支气管哮喘等。

〔灸法〕灸 5—15 分钟（或灸 2—5 壮）。

15. 颧髎 Quánliáo

〔定位〕在面部，当目外眦直下方，颧骨后下缘之凹陷处（见图 43）。

〔主治〕面瘫、眼睑颤动、上牙痛。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

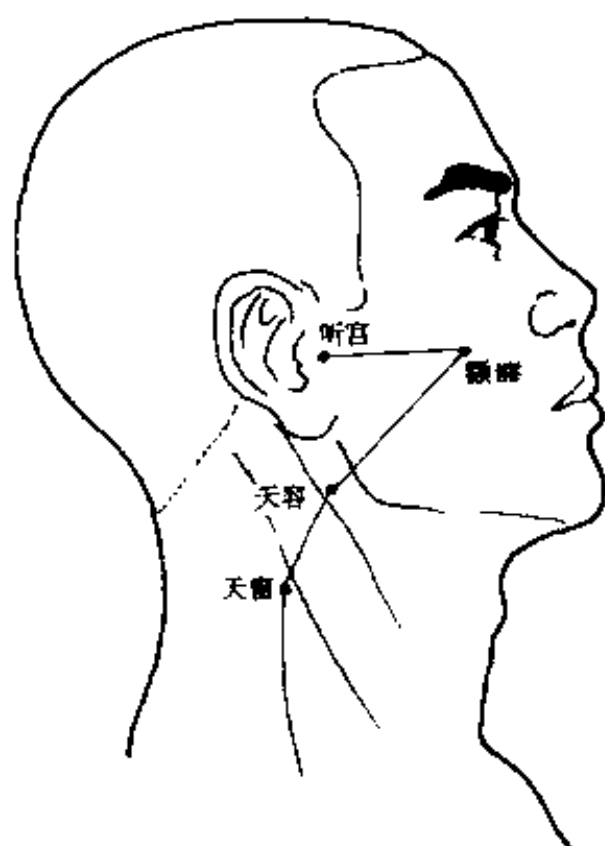


图 46 小肠经头颈部穴

16. 听宫 Tinggong

〔定位〕在面部，耳屏前，下颌骨髁状突的后方，张口时呈凹陷处（见图 43）。

〔主治〕耳鸣、外耳道炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

足太阳膀胱经穴

膀胱经有睛明、攒竹、眉冲、曲差、五处、承光、通天、络却、玉枕、天柱、大杼、风门、肺俞、厥阴俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元

俞、小肠俞、膀胱俞、中膂俞、白环俞、上髎、次髎、中髎、下髎、会阳、承扶、殷门、浮郤、委阳、委中、附分、魄户、膏肓、神堂、谿谿、膈关、魂门、阳纲、意舍、胃仓、育门、志室、胞育、秩边、合阳、承筋、承山、飞杨、跗阳、昆仑、仆参、申脉、金门、京骨、束骨、足通谷、至阴等 67 穴。取常用穴如下。

1. 通天 Tōngtiān

〔定位〕在头顶部，当前发际正中直上 4 寸，旁开 1.5 寸（见图 47）。

〔主治〕鼻炎、慢性支气管炎、头痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

2. 玉枕 Yùzhěn

〔定位〕在后头部，当后发际正中直上 2.5 寸，旁开 1.3 寸，平枕外隆凸上缘的凹陷处（见图 47）。

〔主治〕眩晕、头痛、假性近视、多汗症、高血压病等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

3. 天柱 Tiānzhù

〔定位〕在项部，斜方肌外缘之后发际凹中，正中入后发际 0.5 寸（哑门穴）旁开 1.3 寸（见图 47）。

〔主治〕头痛、落枕、颈椎病、喉炎、鼻炎、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 5—7 壮）。

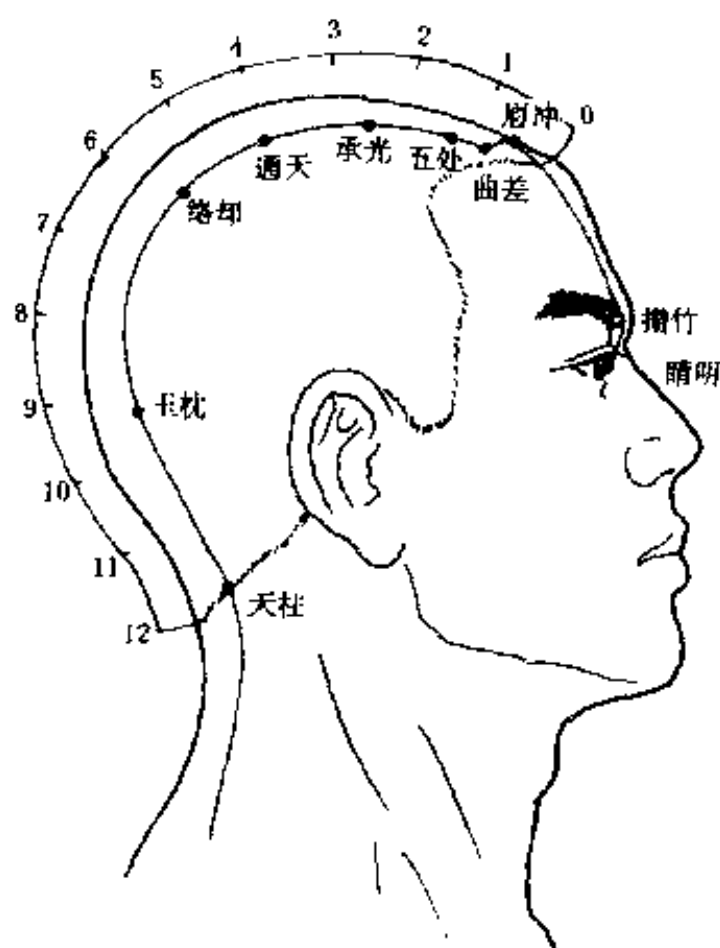


图 47 膀胱经头面部穴侧面观

4. 大杼 Dàzhù 骨会

〔定位〕在背上部，陶道穴（第1与第2胸椎棘突之间）旁开1.5寸处（见图48）。

〔主治〕支气管炎、头痛、眩晕、落枕、颈椎病、腰背肌痉挛、肩背疼痛、膝关节炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

5. 风门 Fēngmén

〔定位〕在背上部，当第2与第3胸椎棘突之间旁开1.5寸处（见图48）。

〔主治〕落枕、支气管炎、百日咳、嗜眠、呕

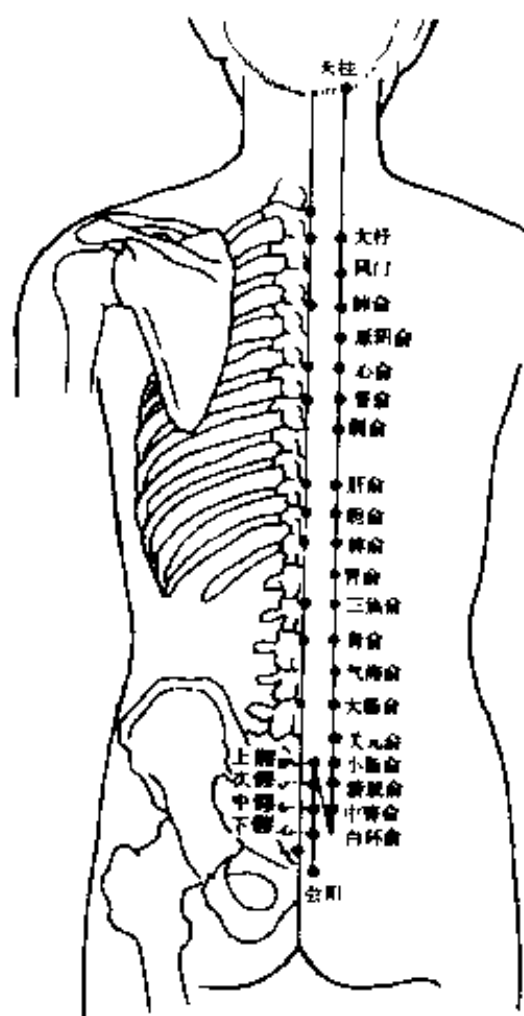


图 48 膀胱经背腰部第一侧线穴

吐、胸背部诸肌痉挛、淋巴结结核、荨麻疹等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

6. 肺俞 Fèishū

〔定位〕在背部，当身柱穴（第 3 与第 4 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕肺结核、支气管炎、皮肤瘙痒、口腔炎、糖尿病、吞酸、呕吐、腰背神经痛、痤疮、黄褐斑、小儿营养不良等症。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

7. 厥阴俞 Tuéyīnshù 俞穴

〔定位〕在背上部，当第 4 与第 5 胸椎棘突之间旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心脏神经官能症、膈肌痉挛、呕吐、齿神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

8. 心俞 Xīnshù 俞穴

〔定位〕在背上部、当神道穴（第 5 与第 6 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、心脏神经官能症、呕吐、食道痉挛、神经衰弱、肩背痛、食欲不振等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

9. 督俞 Dūshù

〔定位〕在背部，当灵台穴（第 6 与第 7 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕冠心病、心绞痛、胃痛、肠炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

10. 膈俞 Gēshù 血会

〔定位〕在背部，当至阳穴（第 7 与第 8 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕心绞痛、冠心病、心脏神经官能症、支气管喘息、支气管炎、胃炎、呕吐、食道痉挛、糖尿病、食欲减退、肠炎、膈肌痉挛、四肢倦怠、盗汗、痤疮、黄褐斑等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

11. 肝俞 Gānshù 俞穴

〔定位〕在背下部，当筋缩穴（第 9 与第 10 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕病毒性肝炎、慢性胃炎、胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、肋间神经痛、支气管炎、高血压病、夜盲症等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

12. 胆俞 Dǎnshù 俞穴

〔定位〕在背下部，当中枢穴（第 10 与第 11 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕胆囊炎、病毒性肝炎、呕吐、胃痛、食欲不振、食道痉挛、喉炎、腋窝淋巴结炎、高血压病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

13. 脾俞 Píshù 俞穴

〔定位〕在背下部，当脊中穴（第 11 与第 12 胸椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕胃神经官能症、胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、胃下垂、肠炎、呕吐、痢疾、病毒性肝炎、支气管喘息、糖尿病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

14. 胃俞 Wèishù 俞穴

〔定位〕在背下部，当第 12 胸椎棘突与第 1 腰椎棘突之间凹陷处旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、

胃下垂、消化不良、肠炎、呕吐、痢疾、经闭、糖尿病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

15. 三焦俞 Sānjiāoshù 俞穴

〔定位〕在腰部，当悬枢穴（第 1 与第 2 腰椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕胃痛、食欲减退、消化不良、呕吐、肠炎、腰椎神经痛、神经衰弱、遗尿、遗精等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

16. 肾俞 Shènyù 俞穴

〔定位〕在腰部，当命门（第 2 与第 3 腰椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕神经性头痛、神经衰弱、耳鸣、头晕、食欲不振、消化不良、病毒性肝炎、糖尿病、腰背骶部疼痛、肾盂肾炎、痛经、月经不调、产后缺乳、遗精、精子缺乏、阳痿、早泄、遗尿等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

17. 气海俞 Qìhǎishù

〔定位〕在腰部，当第 3 与第 4 腰椎棘突之间旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕腰背痛、高血压病、痛经、功能性子宫出血、坐骨神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

18. 大肠俞 Dàchángshù 俞穴

〔定位〕在腰部，当腰阳关穴（第 4 与第 5 腰椎棘突之间）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕腰痛、消化不良、肠炎、脱肛、阑尾炎、痢疾、便秘、神经衰弱、坐骨神经痛、遗尿等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

19. 关元俞 Guānyuánshù

〔定位〕在腰下部，当第 5 腰椎与第 1 骶椎棘突之间旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕腰肌劳损、经闭、慢性盆腔炎、慢性肠炎、痢疾、糖尿病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

20. 小肠俞 Xiǎochángshù 俞穴

〔定位〕在骶部，当骶正中嵴旁开 1.5 寸处，平第 1 骶后孔（见图 48）。

〔主治〕肠炎痢疾、便秘、膀胱炎、坐骨神经痛、腰骶神经痛、盆腔炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

21. 膀胱俞 Pángguāngshù 俞穴

〔定位〕在骶部，当骶正中嵴旁开 1.5 寸处，平第 2 骶后孔（见图 48）。

〔主治〕膀胱炎、遗尿、便秘、肠炎、糖尿病、腰神经痛、骶骨神经痛、子宫内膜炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

22. 中膂俞 Zhōnglǚshù

〔定位〕在骶部，当骶正中嵴旁开 1.5 寸，平第 3 骶后孔（见图 48）。

〔主治〕糖尿病、痢疾、肠炎、腰骶痛、坐骨

神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

23. 白环俞 Báihuánshù

〔定位〕在骶部，当骶正中嵴旁开 1.5 寸处，平第 4 骶后孔，即腰俞穴（第 4 骶椎棘突之下）旁开 1.5 寸处（见图 48）。

〔主治〕腰骶痛、腰骶痛、坐骨神经痛、便秘、遗精、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

24. 上髎 Shàngliáo

〔定位〕在骶部，当骶中嵴的外侧，适对第 1 骶后孔处（见图 48）。

〔主治〕便秘、呕吐、腰痛、坐骨神经痛、子宫内膜炎、月经不调、睾丸炎、卵巢炎、阴门瘙痒等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

25. 次髎 Cìliáo

〔定位〕在骶部，当骶中嵴的外侧，适对第 2 骶后孔（见图 48）。

〔主治〕便秘、肠炎、呕吐、偏瘫、腰痛、坐骨神经痛、膝盖厥冷、子宫内膜炎、月经不调、阳痿、睾丸炎、卵巢炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

26. 中髎 Zhōngliáo

〔定位〕在骶部，当骶中嵴的外侧，适对第 3 骶后孔处（见图 48）。

〔主治〕便秘、肠炎、痢疾、呕吐、腰痛、坐骨神经痛、子宫内膜炎、月经不调、睾丸炎、卵巢炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

27. 下髎 Xiàliáo

〔定位〕在骶部，当骶中嵴的外侧，适对第 4 骶后孔处（见图 48）。

〔主治〕便秘、肠炎、腰痛、子宫内膜炎、月经不调、痛经、睾丸炎、卵巢炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

28. 承扶 Chéngfú

〔定位〕在大腿后面的上部，臀横纹的中点（见图 49）。

〔主治〕腰背痛、便秘、坐骨神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

29. 殷门 Yīnmén

〔定位〕在大腿后面的中部、当承扶与委中连线上，承扶穴下 6 寸（见图 49、图 71、图 72）。

〔主治〕腰背部痛、坐骨神经痛、偏瘫等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

30. 浮郄 Fúxì

〔定位〕在大腿后面下部的外侧，腓横纹外侧端，委阳穴直上 1 寸处股二头肌腱的内侧（见图 49）。

〔主治〕呕吐、肠炎、便秘、膀胱炎、下肢外侧麻痹等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

31. 委 阳

Wěiyáng 三焦经下合穴

〔定位〕在膝关节后面，当腓横纹外侧端，股二头肌腱的内侧缘处，约在委中穴外侧 1 寸处（见图 49）。

〔主治〕腰背痛、膀胱炎、腓肠肌痉挛、胸闷等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

32. 委 中

Wěizhōng 合穴

〔定位〕在膝关节部后面，当腓横纹之中点处，股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间（见图 49）。

〔主治〕感冒、消化不良、膝关节炎、腰背痛、坐骨神经痛、汗出不止和热病汗不出、湿疹、乳房炎、阴门瘙痒、呕吐、腹泻等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

33. 附分 Fùfēn

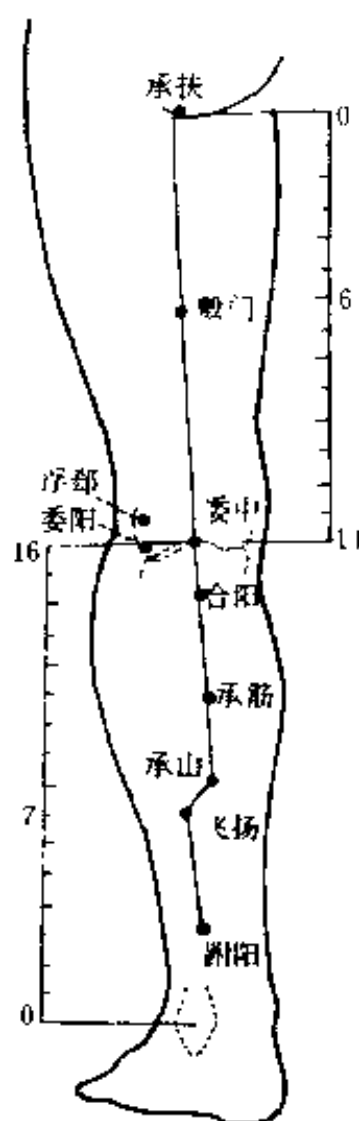


图 49 膀胱经下肢穴

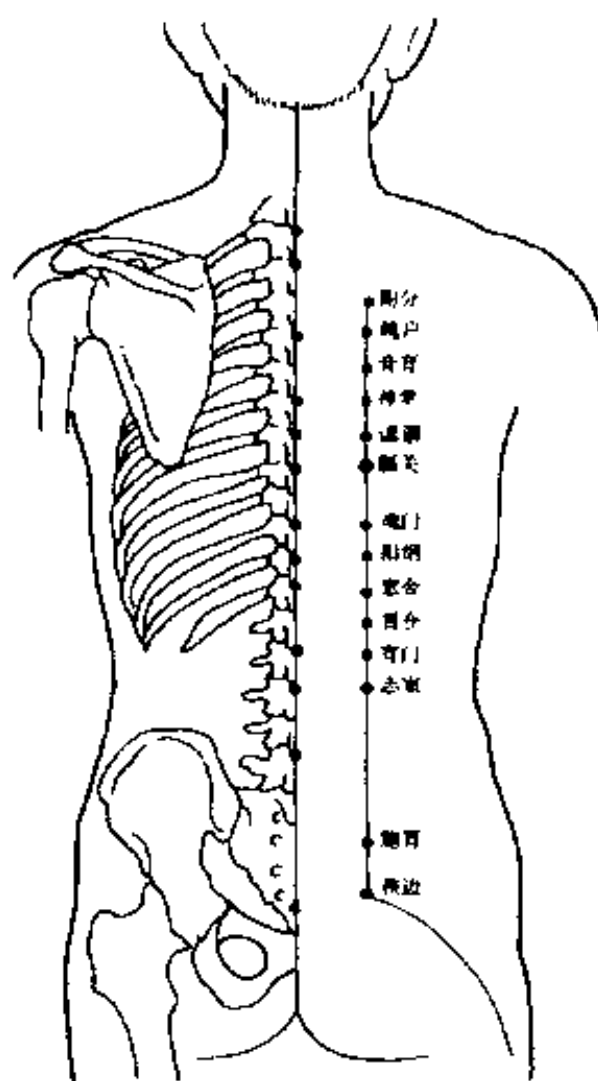


图 50 膀胱经背腰部第 2 侧线穴

〔定位〕在背上部，当第 2 与第 3 胸椎棘突之间旁 3 寸，即当风门穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕肩背神经痛、落枕、支气管炎、肋间神经痛、副神经麻痹等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

34. 魄户 Pòhù

〔定位〕在背上部，当第 3 与第 4 胸椎棘突之间，身柱穴旁开 3 寸，即肺俞穴的外侧 1.5 寸处

(见图 50)。

〔主治〕 支气管炎、支气管喘息、呕吐、肩背痛、烦闷、膈肌痉挛、肋间神经痛等。

〔灸法〕 灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

35. 膏肓 Gāohuāng

〔定位〕 在背上部，当第 4 与第 5 胸椎棘突之间旁 3 寸，即当厥阴俞穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕 各种慢性病、肺结核、支气管炎、支气管喘息、神经衰弱、遗精、健忘、呕吐、胸膜炎等。常灸此穴有强壮身体的作用。

〔灸法〕 灸 10—50 分钟（或灸 5—15 壮）。

36. 神堂 Shéntáng

〔定位〕 在背中部，当第 5 与第 6 胸椎棘突之间（神道穴）的旁 3 寸，亦即当心俞穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕 心脏神经官能症、冠心病、心绞痛、支气管炎、支气管喘息、背痛、肩臂疼痛等。

〔灸法〕 灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

37. 譙譙 Yìxī

〔定位〕 在背中部，当第 6 与第 7 胸椎棘突之间（灵台穴）旁 3 寸，亦即当督俞穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕 心肌膜炎、胸痛、腰背痛、膈肌痉挛、呕吐、眩晕、盗汗、疟疾等。

〔灸法〕 灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

38. 膈关 Géguān

〔定位〕在背部，当第7与第8胸椎棘突之间（至阳穴）旁3寸，即膈俞穴外侧1.5寸处（见图50）。

〔主治〕肋间神经痛、食道痉挛、呕吐、膈肌痉挛、流涎、肠炎、食欲不振等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

39. 魂门 Hūnmén

〔定位〕在背下部，当第9与第10胸椎棘突之间（筋缩穴）旁3寸，即肝俞穴的外侧1.5寸处（见图50）。

〔主治〕病毒性肝炎、头痛、头晕、心脏神经官能症、神经衰弱、肠炎、食道痉挛、食欲不振、消化不良、风湿病等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

40. 阳纲 Yánggāng

〔定位〕在背下部，当第10与第11胸椎棘突之间（中脘穴）旁3寸，即胆俞穴的外侧1.5寸处（见图50）。

〔主治〕消化不良、胃神经官能症、食欲不振、病毒性、胸膜炎、心脏神经官能症、风湿病等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

41. 意舍 Yìshè

〔定位〕在背下部，为第11与第12胸椎棘突之间（脊中穴）旁3寸，即脾俞穴的外侧1.5寸处（见图50）。

〔主治〕消化不良、呕吐、胃痛、腹直肌痉挛、腹泻、食欲不振、病毒性肝炎、胸膜炎、食道痉挛、风湿病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—7 壮）。

42. 胃仓 Wèicāng

〔定位〕在背下部，当第 12 胸椎棘突与第 1 腰椎棘突之间旁 3 寸，即胃俞穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕呕吐、肠炎、便秘、腰背痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

43. 志室 Zhìshì

〔定位〕在腰部，当第 2 与第 3 腰椎棘突之间（命门穴）旁 3 寸，即肾俞穴的外侧 1.5 寸处（见图 50）。

〔主治〕腰痛、消化不良、呕吐、腹泻、遗精、阳痿、肾绞痛、肾盂肾炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

44. 秩边 Zhìbiān

〔定位〕在臀部，平第 4 骶后孔，骶正中嵴旁开 3 寸，即腰俞穴的外侧 3 寸处（见图 50）。

〔主治〕膀胱炎、腰痛、坐骨神经痛、下肢瘫痪、生殖器疾患等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

45. 合阳 Héyáng

〔定位〕在小腿后面的上部，当委中与承山的连线上，委中穴直下 2 寸处（见图 49）。

〔主治〕腰背疼痛、腓肠肌痉挛、肠炎、阳痿、睾丸炎、功能性子宫出血、子宫内膜炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

46. 承筋 Chéngjīn

〔定位〕在小腿后面的上部，当委中与承山的连线上，腓肠肌肌腹中央，委中穴直下 5 寸（见图 49）。

〔主治〕腓肠肌痉挛、呕吐、腹泻、便秘、痔疮、腰背痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

47. 承山 Chéngshān

〔定位〕在小腿后面正中，委中穴下 8 寸处，或外踝尖上 8 寸处，当伸直小腿或足跟上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处（见图 49）。

〔主治〕腓肠肌痉挛、呕吐、腹泻、便秘、膀胱炎、坐骨神经痛、下肢瘫痪等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

48. 飞扬 Fēiyáng

〔定位〕在小腿的后外侧，当昆仑穴（外踝尖与跟腱后缘连线之中点处）直上 7 寸处，或承山外下方 1 寸处（见图 49）。

〔主治〕风湿性关节炎、眩晕、肾盂肾炎、膀胱炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

49. 跗阳 Fūyáng

〔定位〕在小腿下部的后外侧面，当昆仑穴直

上3寸处(见图49)。

〔主治〕腓肠肌痉挛、腰痛、面瘫、头痛、坐骨神经痛、下肢麻痹等。

〔灸法〕灸5—10分钟(可灸3—5壮)。

50. 昆仑 Kūnlún

〔定位〕在足部外踝后方，当外踝尖与跟腱之间的凹陷处(见图51)。



图51 膀胱经足部穴

〔主治〕头痛、下肢瘫痪、腰骶部疼痛、坐骨神经痛、心绞痛、足跟痛等。

〔灸法〕灸10—20分钟(或灸3—7壮)。

51. 申脉 Shēnmài

〔定位〕在足外侧部，外踝直下方凹陷中(见图51)。

〔主治〕头痛、眩晕、腰部和下肢疼痛、动脉硬化等。

〔灸法〕灸5—10分钟(或灸3—5壮)。

52. 金门 Jīnmén

〔定位〕在足外侧，当外踝前缘直下，骰骨下

缘处，或第5跖骨粗隆后上方的凹陷处（见图51）。

〔主治〕头痛、眩晕、晕厥、牙痛、呕吐、局限性痉挛等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

53. 京骨 Jīngǔ 原穴

〔定位〕在足外侧，当第5跖骨粗隆前下方，赤白肉际处（见图51）。

〔主治〕头痛、颈椎病、高血压病、腰痛等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

54. 束骨 Shùgǔ

〔定位〕在足外侧，当第5跖趾关节后方，赤白肉际处（见图51）。

〔主治〕头痛、眩晕、颈椎病、落枕、病毒性肝炎、痢疾、腰背痛、腓肠肌痉挛等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—7壮）。

55. 足通谷 Zútōnggǔ

〔定位〕在足外侧缘，当第5跖趾关节前下方赤白肉际处（见图51）。

〔主治〕头痛、眩晕、落枕、颈椎病、慢性胃炎、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

56. 至阴 Zhīyīn

〔定位〕在足小趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（见图51）。

〔主治〕头痛、眩晕、虹膜睫状体炎、遗尿、

遗精、鼻炎、偏瘫、足关节炎、胎位不正等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

足少阴肾经穴

肾经有涌泉、然谷、太溪、大钟、水泉、照海、复溜、交信、筑宾、阴谷、横骨、大赫、气穴、四满、中注、育俞、商曲、石关、阴都、腹通谷、幽门、步廊、神封、灵墟、神藏、或中、俞府等 27 穴。取常用穴如下。

1. 涌泉 Yǒngquán

〔定位〕在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底 2/3 趾趾缝纹头与足跟连线的前 1/3 与后 2/3 交点上；一法当对第 2 趾骨间隙的中点凹陷处（见图 52）。

〔主治〕瘧病、头痛、晕厥、舌肌麻痹、喉炎、支气管炎、急性扁桃体炎、心动过速、眩晕、高血压病等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

2. 然谷 Rángǔ

〔定位〕在足内侧缘，足舟骨粗隆下方，赤白肉际（见图 53）。

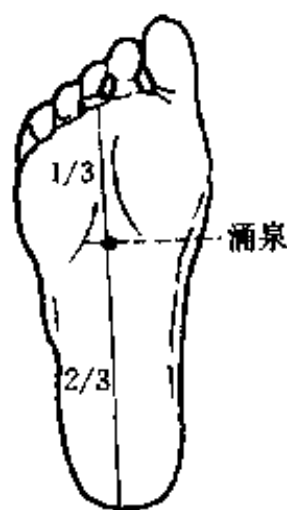


图 52 涌泉穴

〔主治〕心肌炎、扁桃腺炎、流涎、呕吐、盗汗、膀胱炎、尿道炎、睾丸炎、精液缺乏、遗尿、



图 53 肾经足部穴

糖尿病、月经不调、功能性子宫出血、阴门瘙痒、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

3. 太溪 Tàixī 原穴

〔定位〕在足内踝尖与跟腱之间的凹陷处（见图 53）。

〔主治〕支气管喘息、神经官能症、膈肌痉挛、喉炎、口腔炎、呕吐、便秘、痛经、乳房炎、肾盂肾炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

4. 大钟 Dàzhōng 络穴

〔定位〕在足跟内侧，内踝后下方，当跟腱附着部的内侧前方凹陷处（见图 53）。

〔主治〕室上性心动过速、神经官能症、口腔炎、呕吐、食道痉挛、便秘、痛经等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

5. 照海 Zhàohǎi

〔定位〕在足内侧面，内踝尖下方凹陷处（见

图 53)。

〔主治〕喉炎、四肢倦怠、神经官能症、扁桃体炎、阴茎异常勃起、月经不调、失眠等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

6. 复溜 Fùliú

〔定位〕在小腿前内侧面的下部，太溪穴直上 2 寸，跟腱的前方（见图 54）。

〔主治〕汗出不止、盗汗、食道痉挛、月经不调、阴痒、腹泻、便秘、下肢麻痹、牙痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 交信 Jiāoxìn

〔定位〕在小腿前内侧面的下部，当太溪直上 2 寸，复溜前 0.5 寸，胫骨内侧缘的后方（见图 54）。

〔主治〕肾盂肾炎、便秘、肠炎、月经不调、功能性子宫出血、坐骨神经痛、偏瘫、腹膜炎、睾丸炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

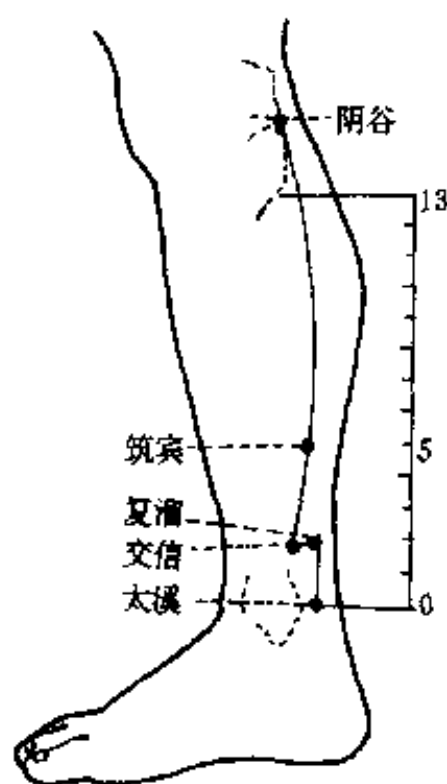


图 54 肾经小腿部穴

8. 筑宾 Zhùbīn

〔定位〕在小腿前内侧面的中部，当太溪与阴谷的连线上，太溪上5寸，腓肠肌肌腹的内下方（见图54）。

〔主治〕神经官能症、肾炎、膀胱炎、腓肠肌痉挛、舌炎等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

9. 阴谷 Yīngǔ 合穴

〔定位〕在膝部内侧，腘横纹内侧端，屈膝时，当半腱肌肌腱与半膜肌肌腱之间，在肝经曲泉穴之后方，二穴相隔一肌腱（见图54）。

〔主治〕股内侧部疼痛、膝关节炎、遗精、阳痿、阴茎痛、阴道炎、外阴炎、阴门瘙痒、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—5壮）。

10. 大赫 Dàhè

〔定位〕在下腹部，当脐中下4寸（任脉中极穴）旁开0.5寸处（见图55）。

〔主治〕阳痿、阴茎痛、精液缺乏、遗精、早泄、盆腔炎、附件炎、阴道炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

11. 气穴 Qìxué

〔定位〕在下腹部，当脐中下3寸（任脉关元穴），旁开0.5寸（见图55）。

〔主治〕遗精、早泄、阳痿、阴茎痛、肾炎、膀胱括约肌麻痹、月经不调等。

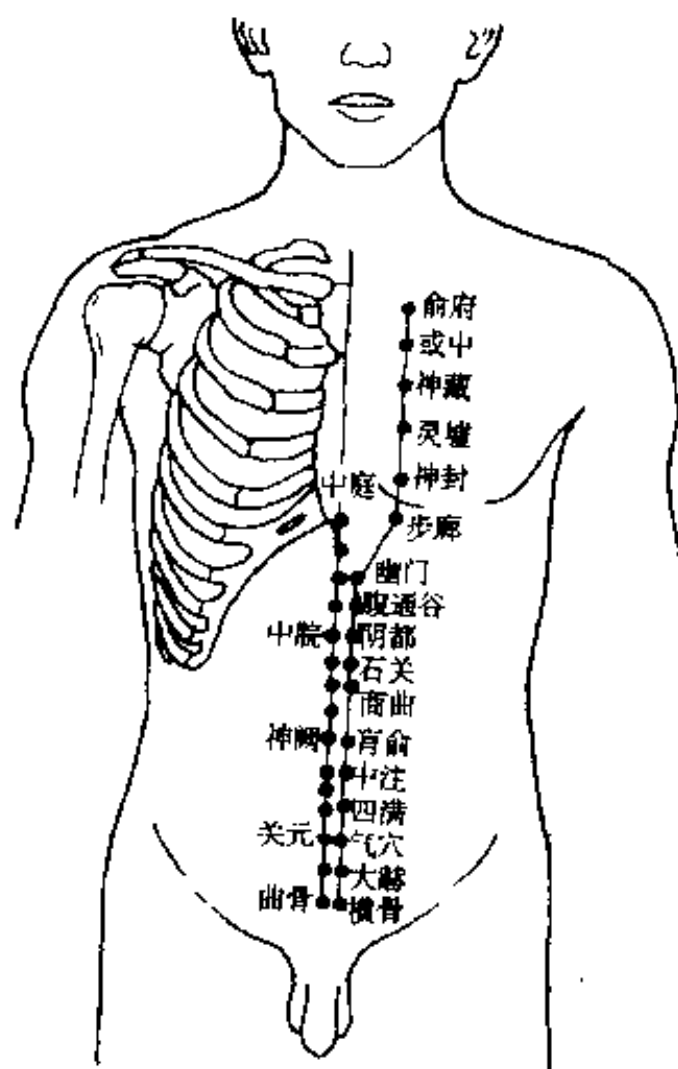


图 55 肾经胸腹部穴

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮。）

12. 四满 Sīmǎn

〔定位〕在下腹部，当脐中下 2 寸（任脉石门穴）旁开 0.5 寸（见图 55）。

〔主治〕肠炎、遗精、阳痿、月经不调、痛经、膀胱括约肌麻痹等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

13. 中注 Zhōngzhù

〔定位〕在下腹部，当脐中下1寸（任脉阴交穴）旁开0.5寸（见图55）。

〔主治〕便秘、肠炎、角膜炎、月经不调、附件炎、睾丸炎。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

14. 育俞 Huāngshù

〔定位〕在中腹部，当脐中（任脉神阙穴旁外侧0.5寸（见图55）。

〔主治〕胃神经官能症、习惯性便秘、肠炎、病毒性肝炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

15. 商曲 Shāngqū

〔定位〕在上腹部，当脐中上2寸（任脉下皖穴），旁开0.5寸（见图55）。

〔主治〕胃神经官能症、胃炎、胃与十二指肠溃疡、食欲减退、病毒性肝炎、角膜炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

16. 石关 shíguān

〔定位〕在上腹部，当脐中上3寸（任脉建里穴），旁开0.5寸（见图55）。

〔主治〕胃神经官能症、流涎、便秘、肠炎、膈肌痉挛、痛经等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

17. 阴都 Yīndù

〔定位〕在上腹部，当脐中上4寸（任脉中脘

穴)旁开0.5寸(见图55)。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、肠炎、病毒性肝炎、消化不良等。

〔灸法〕灸10—30分钟(或灸3—9壮)。

18. 腹通谷 Fùtōnggǔ

〔定位〕在上腹部、当脐中上5寸(任脉上脘穴)旁开0.5寸(如图55)。

〔主治〕支气管喘息、面瘫、胃与十二指肠溃疡、呕吐、消化不良、慢性胃炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟(或灸3—9壮)。

19. 幽门 Yōumén

〔定位〕在上腹部，当脐中上6寸(任脉巨阙穴)旁开0.5寸(见图55)。

〔主治〕消化不良、吞酸、流涎、呕吐、肋间神经痛、病毒性肝炎、支气管炎、痢疾、健忘、妇人乳汁不通、乳房炎等。

〔灸法〕灸10—30分钟(或灸3—9壮)。

20. 神封 Shénfēng

〔定位〕在胸部，当第4肋间隙，前正中线(任脉膻中穴)旁开2寸(见图55)。

〔主治〕肋间神经痛、胸闷、支气管炎、鼻炎、嗅觉减退、呕吐、食欲不振、乳房炎等。

〔灸法〕灸5—20分钟(或灸3—5壮)。

21. 神藏 Shéncāng

〔定位〕在胸部，当第2肋间隙，前正中线旁开2寸(见图55)。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、肋间神经痛、胸闷、膈肌痉挛、呕吐、食欲减退等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

22. 臑中 Yùzhōng

〔定位〕在胸部，当第 1 肋间隙，前正中线旁开 2 寸（见图 55）。

〔主治〕支气管喘息、支气管炎、肋间神经痛、胸闷、膈肌痉挛、呕吐、食欲不振、盗汗等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

23. 俞府 Shūfǔ

〔定位〕在胸上部，锁骨下方，当锁骨与第 1 肋之间的凹陷处，前正中线旁开 2 寸（见图 55）。

〔主治〕支气管哮喘、支气管炎、肋间神经痛、胸闷、膈肌痉挛、呕吐、流涎、食欲不振等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

手厥阴心包经穴

心包经有天池、天泉、曲泽、郄门、间使、内关、大陵、劳宫、中冲共 9 穴。取常用穴如下。

1. 天池 Tiānchí

〔定位〕在胸部，当第 4 肋间隙，乳头外 1 寸，前正中线旁开 5 寸（见图 56）。

〔主治〕淋巴结结核、乳汁分泌不足、乳房炎、肋间神经痛、高血压病等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

2. 曲泽 Qūzé 合穴

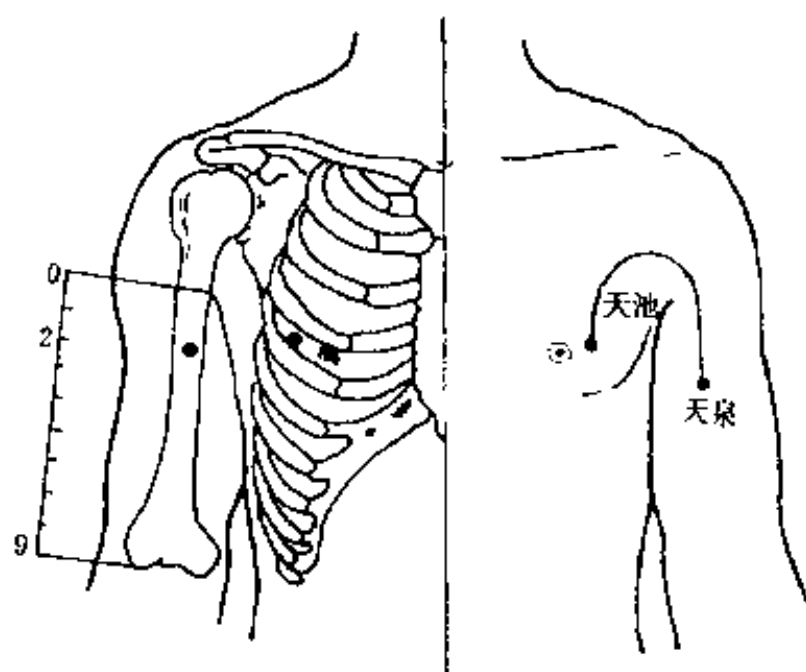


图 56 心包经胸臂部穴

〔定位〕在肘部，当时掌侧横纹中点处，相当于肱二头肌腱的尺侧缘，可摸到肱动脉搏动处（见图 57）。

〔主治〕胸闷、胃痛、呕吐、腹泻、荨麻疹、关节炎、舞蹈病等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

3. 郄门 Xīmén

〔定位〕在前臂掌面的中部，当曲泽与大陵的连线上，腕上 5 寸处，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（见图 57）。

〔主治〕心绞痛、冠心病、心脏神经官能症、膈肌痉挛、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

4. 间使 Jiānshǐ

〔定位〕在前臂掌面的下段，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（见图57）。

〔主治〕神经官能症、月经不调、荨麻疹、冠心病、喉炎等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

5. 内关 Nèiguān 络穴

〔定位〕在前臂掌面的下段，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，约与外关相对（见图57）。

〔主治〕冠心病、无脉症、神经衰弱、月经不调、支气管炎、慢性胃炎、胃神经官能症、膈肌痉挛、遗精、肋间神经痛、呕吐等。

〔灸法〕灸5—20分钟（或3—7壮）。

6. 大陵 Dàlíng 原穴

〔定位〕在腕部，当腕掌侧横纹之中点处，即当桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间的凹陷处（见图

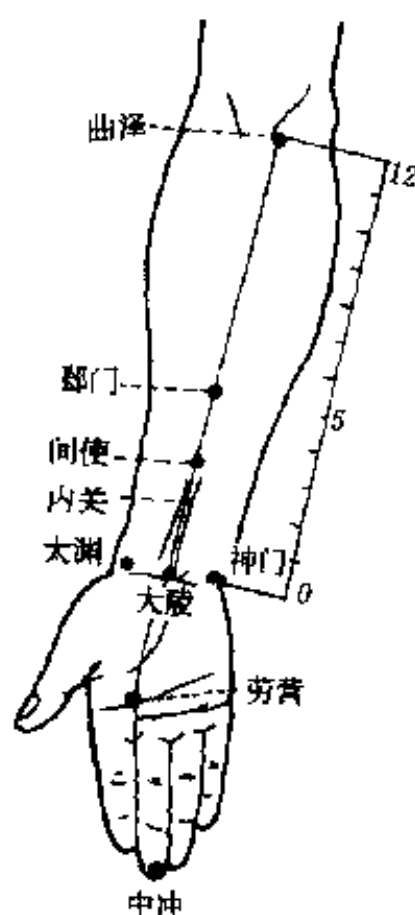


图57 心包经前臂、手部穴

57)。

〔主治〕神经衰弱、头痛、扁桃体炎、乳房炎、肋间神经痛、腕关节炎等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 劳宫 Láogōng

〔定位〕在掌中央，当第 2、3 掌骨间隙之中点处，握拳屈指时中指尖处（见图 57）。

〔主治〕咽炎、胃痛、食欲不振、神经衰弱、肋间神经痛、鹅掌风等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

手少阳三焦经穴

三焦经有关冲、液门、中渚、阳池、外关、支沟、会宗、三阳络、四渎、天井、清冷渊、消泺、臑会、肩髃、天髃、天牖、翳风、瘰脉、颅息、角孙、耳门、耳和髃、丝竹空等 23 穴。取常用穴如下。

1. 关冲 Guānchōng

〔定位〕在手无名指末节尺侧，距指甲角 0.1 寸（见图 58）。

〔主治〕恶心、头痛、食欲不振、喉炎、腮腺炎等。

〔灸法〕灸 3—5 分钟（或灸 1—3 壮）。

2. 液门 Yèmén

〔定位〕在手背，当第 4、5 指间，指蹼缘后方赤白肉际处（见图 58）。

〔主治〕低血压、耳鸣、齿龈炎、牙痛、喉炎、指掌关节炎、神经衰弱等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

3. 中渚

Zhōngzhǔ

〔定位〕在手背部，当第 4、5 掌骨间隙，液门上 1 寸（见图 58）。

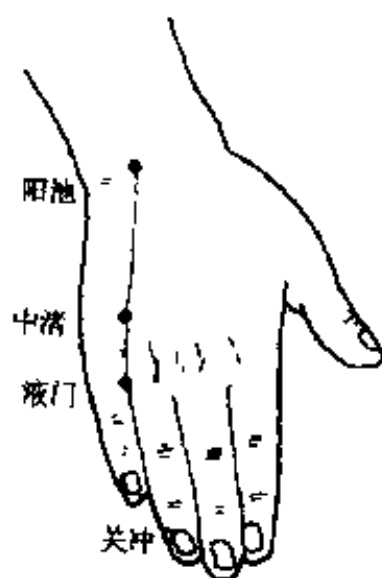


图 58 三焦经手部穴

〔主治〕眩晕、头痛、喉炎、臂丛神经痛、指掌关节炎、腕关节炎等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

4. 阳池 Yángchí 原穴

〔定位〕在腕背侧面，当腕背侧横纹中点，即指伸肌腱的尺侧缘凹陷处（见图 58）。

〔主治〕牙痛、臂丛神经痛、腕关节炎、腕关节挫伤等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 外关 Wàiguān 络穴

〔定位〕在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上 2 寸处，尺骨与桡骨之间（见图 59）。

〔主治〕臂丛神经痛、上肢关节炎、牙痛、腮腺炎、支气管炎、失眠、感冒、高血压病、头痛、

肋间神经痛等。

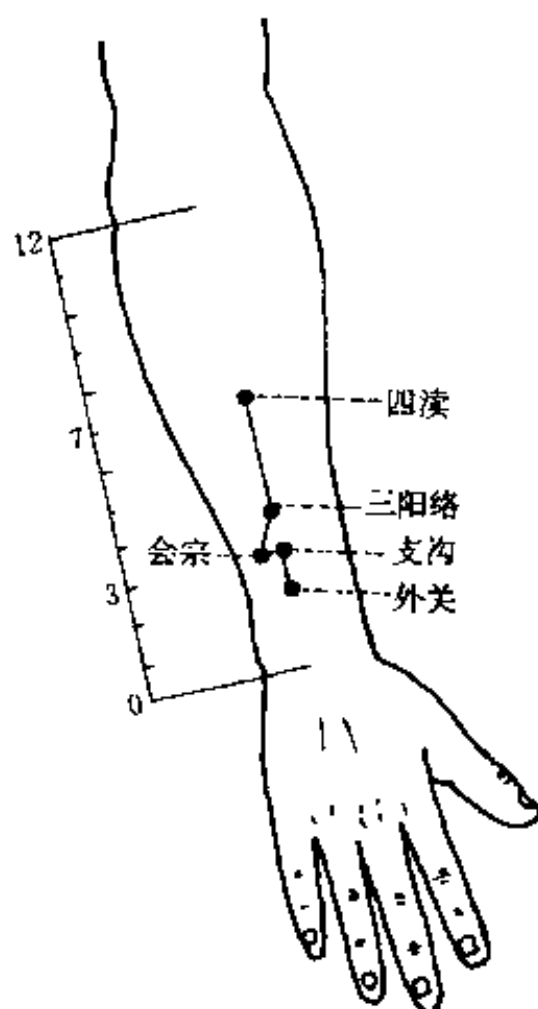


图 59 三焦经前臂部穴

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

6. 支沟 Zhīgōu

〔定位〕在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，阳池穴上 3 寸处，尺骨与桡骨之间（见图 59）。

〔主治〕心绞痛、冠心病、肋间神经痛、神经官能症、呕吐、习惯性便秘、低血压等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

7. 天井 Tiānjīng 合穴

〔定位〕在臂外侧，当时尖（尺骨鹰嘴）上1寸之陷处（见图60）。

〔主治〕支气管炎、喉炎、偏头痛、抑郁症、眼睑缘炎、颈椎病、扁扁桃体炎、食欲不振等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—7壮）。

8. 臑会 Nàohuì

〔定位〕在臂外侧面的上部，平齐腋后纹头，三角肌的后缘（见图60）。

〔主治〕偏瘫、肩关节周围炎、肘关节炎、单纯性甲状腺肿等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

9. 肩髃 Jiānyú

〔定位〕在肩髃后方，当臂外展时，于肩峰后下方凹陷处（见图60）。

〔主治〕偏瘫、肩关节周围炎、臂丛神经痛、肋间神经痛、荨麻疹等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

10. 翳风 Yǐfēng

〔定位〕在面部，耳廓的后下方，当耳垂根后

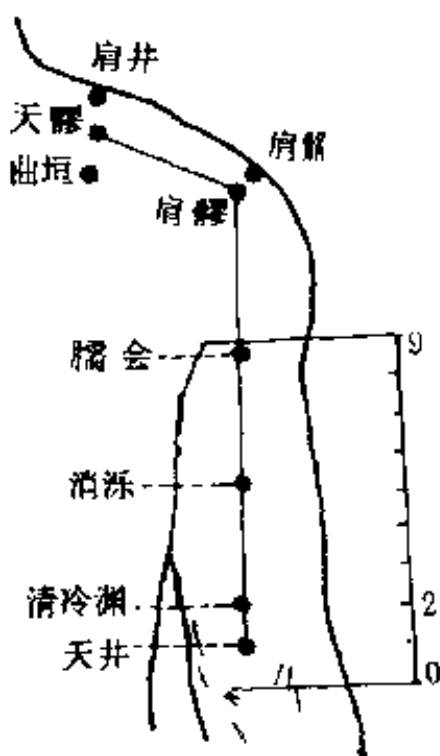


图60 三焦经臂部穴

方的凹陷处（见图 61）。

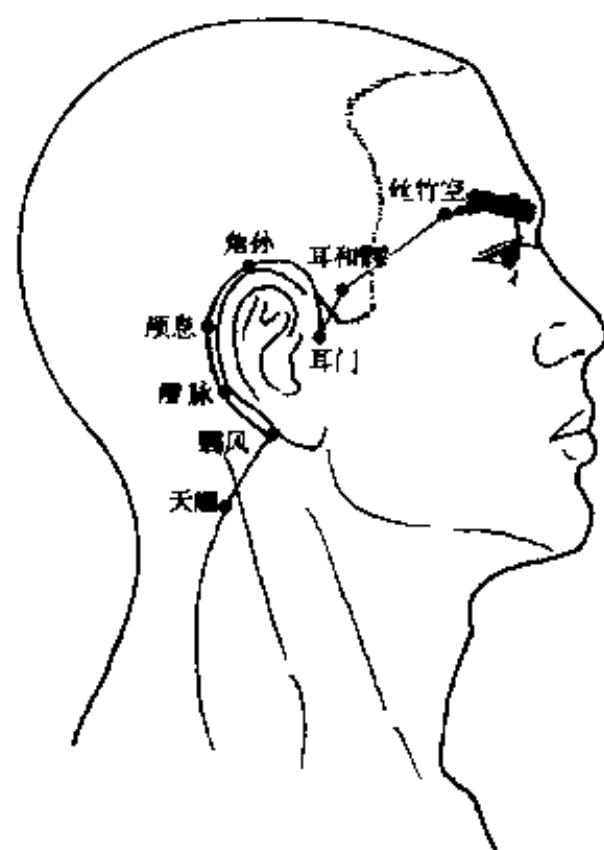


图 61 三焦经头、面、颈部穴

〔主治〕腮腺炎、耳鸣、面瘫、牙痛、单纯性甲状腺肿、颈淋巴结结核等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

11. 角孙 Jiǎosūn

〔定位〕在头侧部，当耳尖直上入发际处（见图 61）。

〔主治〕视神经炎、齿龈炎、牙痛、口腔炎、下颌关节炎、呕吐、单纯性甲状腺肿等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

足少阳胆经穴

胆经有瞳子髎、听会、上关、颌厌、悬颅、悬厘、曲鬓、率谷、天冲、浮白、头窍阴、完骨、本神、阳白、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空、风池、肩井、渊腋、辄筋、日月、京门、带脉、五枢、维道、居髎、环跳、风市、中渎、膝阳关、阳陵泉、阳交、外丘、光明、阳辅、悬钟、丘墟、足临泣、地五会、侠溪、足窍阴等 44 穴。取常用穴如下。

1. 瞳子髎 Tóngzǐliáo

〔定位〕在面部，目外眦旁，当眶外侧缘处（见图 62）。

〔主治〕角膜炎、视神经萎缩、视网膜炎、假性近视眼、夜盲症、齿龈痛、面瘫、偏头痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

2. 听会 Tīnghuì

〔定位〕在耳前方，当耳屏间切迹前方与下颌骨髁突的后缘、张口有凹陷处（见图 62）。

〔主治〕耳鸣、耳内疼痛、下颌关节炎、面瘫、牙痛、腮腺炎等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

3. 上关 shàngguān

〔定位〕在耳前、下关直上，当颧弓上缘微上方之凹陷处，一法约当目外与耳屏之间的中点（见

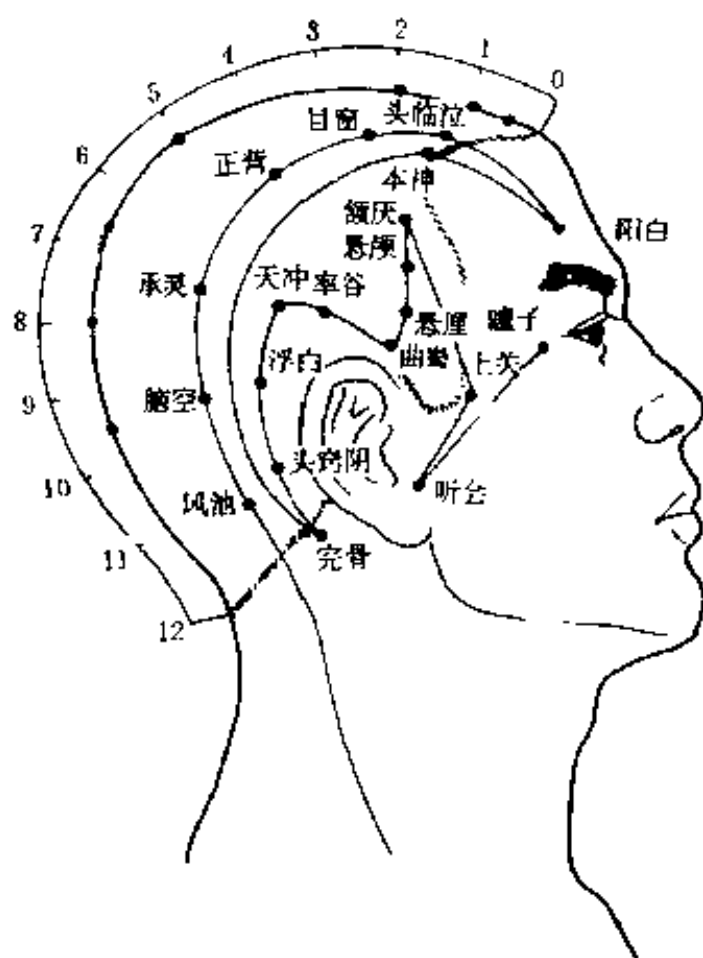


图 62 胆经头面部穴正面观

图 62)。

〔主治〕面瘫、视神经萎缩、耳鸣、上牙痛、偏头痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

4. 率谷 shuàigǔ

〔定位〕在头的颞部，当耳尖直上入发际 1.5 寸处，角孙直上方；一法当耳尖与顶结节之间的中点处（见图 62）。

〔主治〕偏头痛、食欲不振、呕吐、烦闷、结膜炎、假性近视、面瘫等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 完骨 wángǔ

〔定位〕在头后部，当颞骨乳突尖后下方凹陷处（见图 62）。

〔主治〕后头痛、耳后痛、面瘫、落枕、颈椎病、喉炎、失眠、失语等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

6. 阳白 yángbái

〔定位〕在额部，瞳孔直上，眉上 1 寸处（见图 62）。

〔主治〕夜盲、结膜炎、眼睑颤动、假性近视、面瘫、前头痛、呕吐等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 脑空 Nǎokōng

〔定位〕在后头部，当枕外隆凸上缘（脑户穴）外侧，头正中线旁开 2.25 寸（见图 62）。

〔主治〕支气管喘息、后头痛、感冒、肩颈部痉挛、癫痫、室上性心动过速等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。

8. 风池 Fēngchí

〔定位〕在项部，枕骨之下，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处，风府穴的外侧 1.5 寸（见图 62）。

〔主治〕感冒、后头痛、偏头痛、高血压病、鼻炎、耳鸣、牙痛、颈椎病、落枕、荨麻疹、神经衰弱、偏瘫、单纯性甲状腺肿、视神经萎缩、精神

病和神经系统病的常用穴。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

9. 肩井 Jiānjǐng

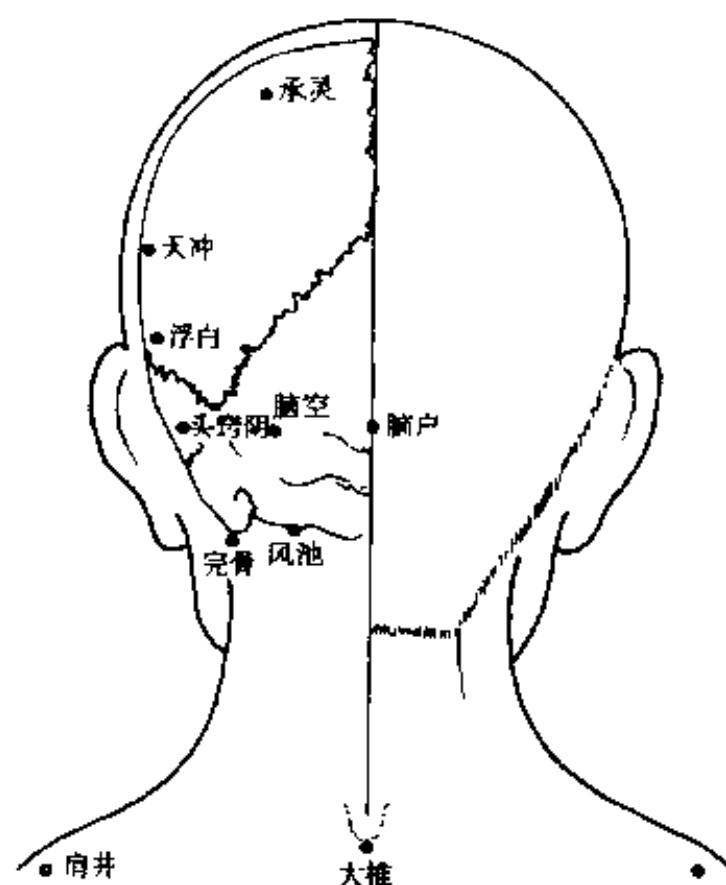


图 63 胆经头部穴背面观

〔定位〕在肩部，当大椎穴与肩峰端连线的中点处（见图 63）。

〔主治〕肩背疼痛、颈淋巴结结核、落枕、颈椎病、偏瘫、神经衰弱、脑供血不足、功能性子宫出血、眩晕、乳房炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

10. 日月 Rìyuè 胆之募穴

〔定位〕在胸部，乳头直下，第 7 肋间隙，前

正中线旁开4寸（见图64）。

〔主治〕胃炎、病毒性肝炎、胆囊炎、膈肌痉挛、肋间神经痛、乳房炎等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

11. 京 门

Jīngmén 肾之募穴

〔定位〕在侧腰部，当第12肋骨游离端的下方（见图64）。

〔主治〕肾盂肾炎、膀胱炎、遗精、阳痿、月经不调、腰痛、肠炎、消化不良、髋关节炎、支气管喘息等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

12. 带脉 Dàimài

〔定位〕在侧腹部，章门下1.8寸，当第11肋骨游离下方垂线与脐水平线的交点上（见图64）。

〔主治〕腰痛、痢疾、月经不调、附件炎、盆腔炎、阴道炎等。

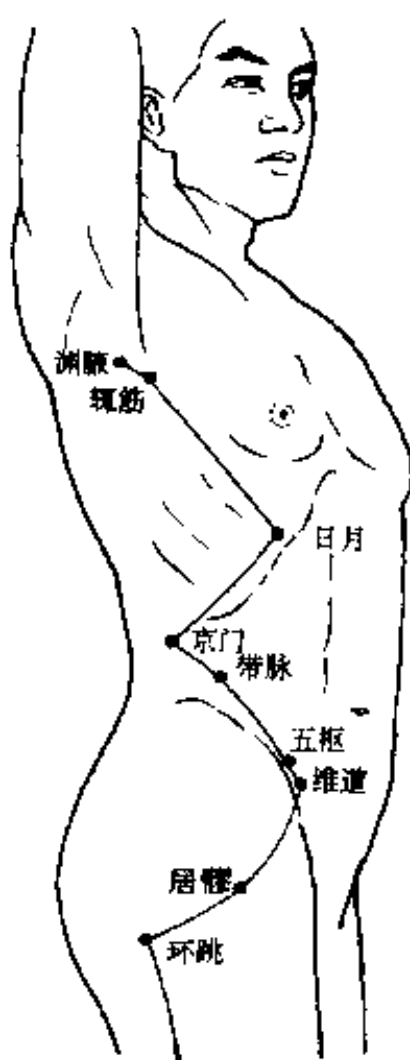


图64 胆经胸腹部穴

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

13. 居髌 Jūliáo

〔定位〕在髌部，当髌前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处（见图 64）。

〔主治〕下肢瘫痪、腰痛、髌关节炎、睾丸炎、膀胱炎、月经不调、白带过多等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

14. 环跳 Huántiào

〔定位〕在臀外侧下部，当股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外 1/3 与中 1/3 的交界处（见图 64）。

〔主治〕偏瘫、腰痛、荨麻疹、坐骨神经痛、髌关节炎等。

〔灸法〕灸 10—50 分钟（或灸 5—15 壮）。

15. 风市 Fēngshì

〔定位〕在大腿外侧部的中线上，当腓横纹上 7 寸，或垂手中指尖所到之处（见图 65）。

〔主治〕下肢瘫痪、膝软无力、坐骨神经痛、荨麻疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 5—9 壮）。

16. 膝阳关 Xīyángguān

〔定位〕在膝部的外侧，当阳陵泉上 3 寸，股骨外上髁上方的凹陷处（见图 65）。

〔主治〕膝关节炎、偏瘫、坐骨神经痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

17. 阳陵泉 Yánglíngquán 合穴

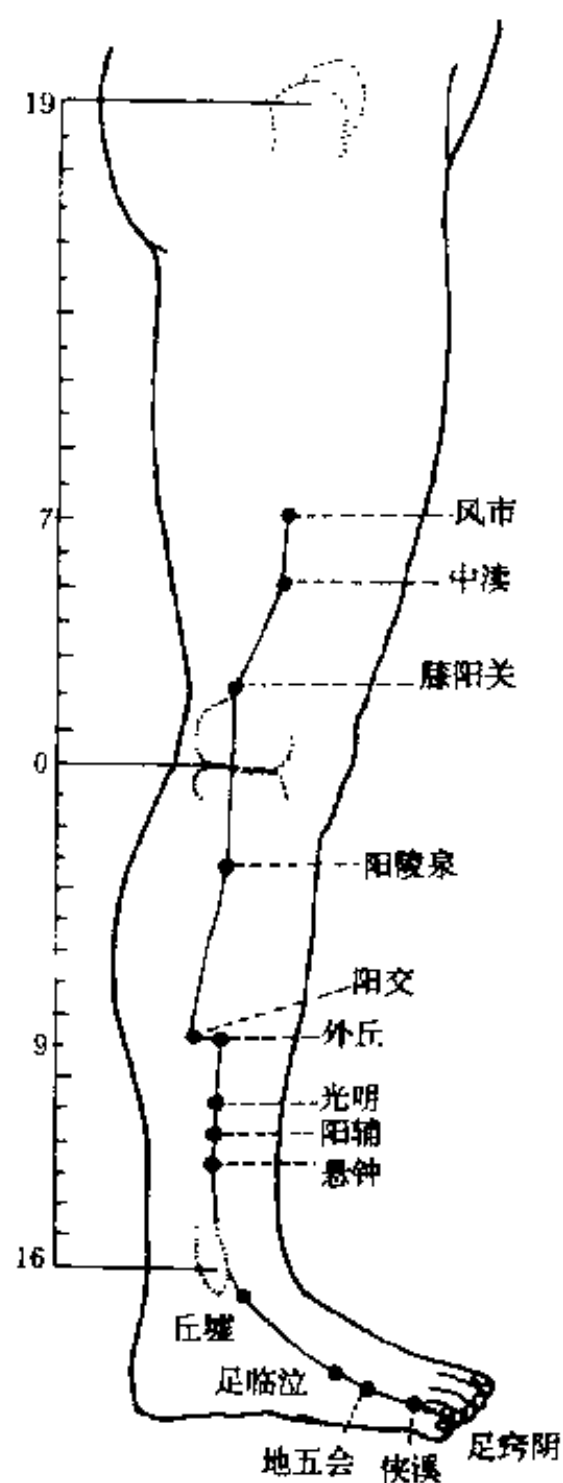


图 65 胆经下肢部穴

〔定位〕 在小腿前外面的上部，当腓骨下头前

下方的凹陷处（见图 65）。

〔主治〕偏瘫、肋间神经痛、神经衰弱、落枕、膝关节炎、坐骨神经痛、颜面浮肿、高血压病、胆囊炎、病毒性肝炎、便秘、舞蹈病等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

18. 阳交 Yángjiāo

〔定位〕在小腿外侧面的中部，当外踝尖上 7 寸，腓骨后缘稍后方之凹陷处（见图 65）。

〔主治〕胸闷、喉炎、膝关节炎、腓肠肌痉挛、坐骨神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

19. 光明 Guāngmíng 络穴

〔定位〕外踝尖上 5 寸，腓骨前缘（见图 65）。

〔主治〕下肢瘫痪、目疾、腓肠肌痉挛、偏头痛、神经官能症等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

20. 阳辅 Yángfǔ

〔定位〕外踝尖上 4 寸，腓骨前缘（见图 65）。

〔主治〕下肢瘫痪、末梢神经炎、喉炎、坐骨神经痛、胸胁痛、颈和腋淋巴结结核等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

21. 悬钟 Xuánzhōng（又名绝骨 Juégǔ）髓会

〔定位〕外踝尖上 3 寸，腓骨前缘（见图 65）。

〔主治〕偏瘫、胃痛、消化不良、腰痛、下肢酸痛、喉炎、颈椎病、落枕、小儿舞蹈病、视神经萎缩。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

22. 丘墟 Qiūxū 原穴

〔定位〕外踝前下方，当趾长肌腱外侧凹陷中（见图 65）。

〔主治〕胸胁闷痛、髋关节痛、下肢酸痛、偏瘫、坐骨神经痛、腓肠肌痉挛、踝关节炎等。

〔灸法〕灸 5—15 分钟（或灸 3—5 壮）。

23. 足临泣 Zúlíngqù

〔定位〕第 4 跖骨间隙后端，小趾伸肌腱的外侧凹陷处（见图 65）。

〔主治〕胸中闷痛、颈和腋淋巴结结核、头晕、后头痛、偏头痛、月经不调等。

〔灸法〕灸 5—15 分钟（或灸 3—5 壮）。

24. 侠溪 Jiáxī

〔定位〕第 4、5 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处（见图 65）。

〔主治〕足背肿痛、足心发热、胸胁疼痛、耳鸣、高血压病、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

25. 足窍阴 Zúqiàoyīn

〔定位〕第 4 趾外侧，距甲角 0.1 寸（见图 65）。

〔主治〕头痛、心烦、肋间神经痛、膈肌痉挛、嗜眠、失眠、手足心热、喉炎、语謇、高血压病、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 2—3 壮）。

足厥阴肝经穴

肝经有大敦、行间、太冲、中封、蠡沟、中都、膝关、曲泉、阴包、足五里、阴廉、急脉、章门、期门等14穴。取常用穴如下。

1. 大敦 Dàdūn

〔定位〕在足大趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（见图66）。

〔主治〕胃痛、嗜眠、腰痛、便秘、遗尿、睾丸炎、阴茎痛、糖尿病、月经过多、功能性子宫出血等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

2. 行间 Xíngjiān

〔定位〕在足背侧，当第1、2趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处（见图66）。

〔主治〕脑供血不足、膈肌痉挛、心脏神经官能症、消化不良、便秘、遗尿、阴茎痛、糖尿病、月经过多、牙痛、牙龈炎、失眠、盗汗、肋间神经痛、青光眼等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

3. 太冲 Tàichōng 原穴

〔定位〕在足背部，当第1、2跖骨间，行间穴上2寸取之（见图66）。

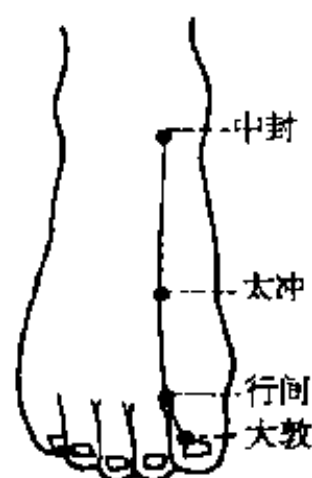


图66 肝经足部穴

〔主治〕头痛、头晕、肋间神经痛、腰痛、胃痛、痛经、月经过多、阴茎痛、失眠、高血压病、心绞痛、神经官能症、青光眼、乳房炎等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

4. 蠡沟 Lígōu 络穴

〔定位〕在小腿内侧，当足内踝尖上 5 寸，胫骨内侧面的中央（见图 67）。

〔主治〕膀胱炎、睾丸炎、性功能亢进、心脏神经官能症、梅核气、子宫内膜炎、月经不调、阴门瘙痒等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 中都 Zhōngdu

〔定位〕在小腿内侧，当足内踝尖上 7 寸，胫骨内侧面的中央（见图 67）。

〔主治〕膝关节炎、喉炎、痢疾、功能性子宫出血、产后恶露不止等。

〔灸法〕灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

6. 膝关 Xīguān

〔定位〕在小腿内侧的上部，当胫骨内上髁的

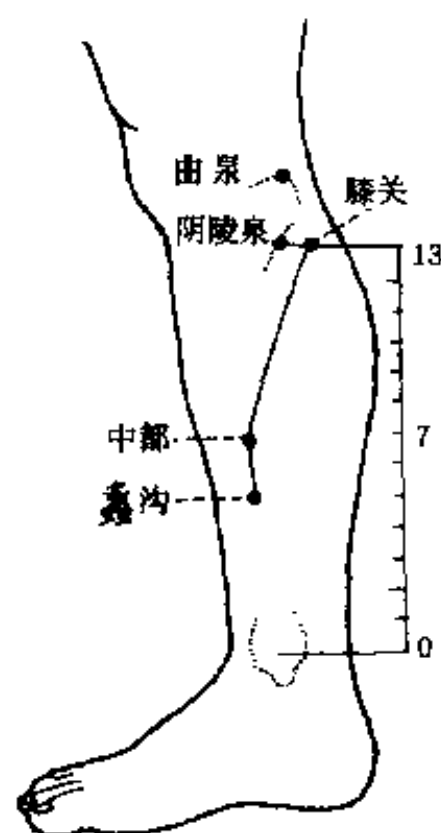


图 67 肝经内腿部穴

后下方，阴陵泉后 1 寸（见图 67）。

〔主治〕 膝关节炎、咽炎、喉炎。

〔灸法〕 灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 曲泉 Qūquán 合穴

〔定位〕 在膝部内侧，当腘横纹之内侧端（膝关节屈成 90 度时），即胫骨内侧髁之后方与半膜肌，半腱肌止端的前缘凹陷处（见图 67）。

〔主治〕 阴茎痛、遗精、膀胱炎、痢疾、外阴瘙痒、阴道炎、痛经、月经不调等。

〔灸法〕 灸 5—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

8. 章门 Zhāngmén 脾之募穴、脏会

〔定位〕 在腹侧部，上直腋中线，在第 11 肋游离端稍下方处（见图 68）。

〔主治〕 胃炎、胃与十二指肠溃疡、胃神经官能症、消化不良、食欲不振、肋间神经痛、支气管喘息、膈肌痉挛、腰痛、病毒性肝炎、肠炎、膀胱炎、便秘等。

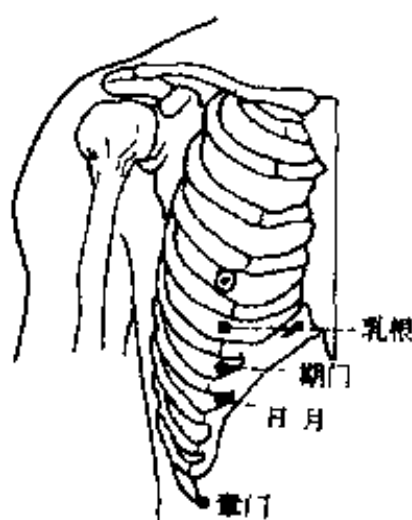


图 68 章门穴、期门穴

〔灸法〕 灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

9. 期门 Qīmén 肝之募穴

〔定位〕在胸部，当乳头直下方，第6肋间隙，前正中线旁开4寸（见图68）。

〔主治〕支气管哮喘、支气管炎、膈肌痉挛、胃痛、呕吐、吞酸、食欲不振、病毒性肝炎、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

奇 穴

奇穴有千余，今选灸法中常用腧穴如下。

1. 四神聪 Sishéncōng

〔定位〕在头顶部，百会穴之前、后、左、右各1寸处，共4穴（见图69）。

〔主治〕头痛、脑供血不足、脑血管意外引起的肢体瘫痪等。

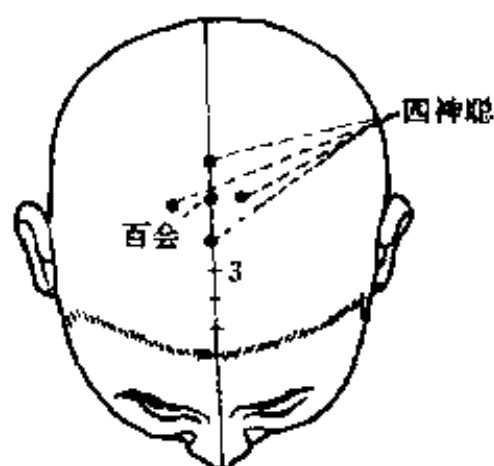


图69 四神聪穴

〔灸法〕灸5—20分钟（或灸3—7壮）。

2. 印堂 Yīntáng

〔定位〕在面部，当两眉之间中点处，正对鼻尖（见图 70）。

〔主治〕头痛、高血压病、鼻炎、鼻窦炎、鼻塞、失眠等。

〔灸法〕灸 5—10 分钟（或灸 3—5 壮）。



图 70 印堂穴

3. 太阳 Tàiyáng

〔定位〕在颞部，当眉梢与目外眦之间，向后 1 寸的凹陷处（见图 71）。

〔主治〕头痛、偏头痛、头晕、牙痛、神经衰弱、结膜炎、角膜炎、虹膜睫状体炎、视神经萎缩、视网膜出血、面瘫等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。



图 71 太阳穴、翳明穴

4. 翳明 Yīmíng

〔定位〕在项部，当翳风穴后 1 寸（见图 71）。

〔主治〕视神经萎缩、白内障早期、青少年假性近视、夜盲、头痛、高血压病、耳鸣、失眠等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

5. 安眠 Anmián

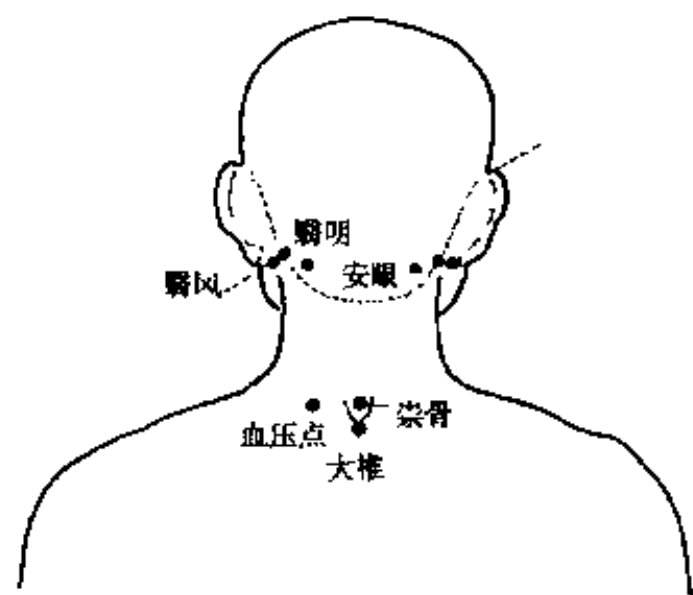


图 72 安眠穴、颈百劳穴、崇骨穴

〔定位〕在风池与翳明穴连线之中点（见图 72）。

〔主治〕失眠、头痛、眩晕、心脏神经官能症、高血压、神经衰弱。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

6. 颈百劳 Jǐngbǎiláo

〔定位〕在项部，当大椎穴直上 2 寸，后正中线旁开 1 寸（见图 72）。

〔主治〕颈椎病、落枕、颈淋巴结结核等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

7. 崇骨 Chónggǔ

〔定位〕在第 6、7 颈椎棘突之间（见图 72）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、感冒、颈椎病等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

8. 血压点 Xuèyādiǎn

〔定位〕在第6、7颈椎之间（崇骨穴）旁开2寸（见图72）。

〔主治〕高血压病、低血压、颈椎病等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

9. 定喘 Dìngchuǎn

〔定位〕在背上部，第7颈椎棘突下（大椎穴）旁开0.5寸（见图73）。

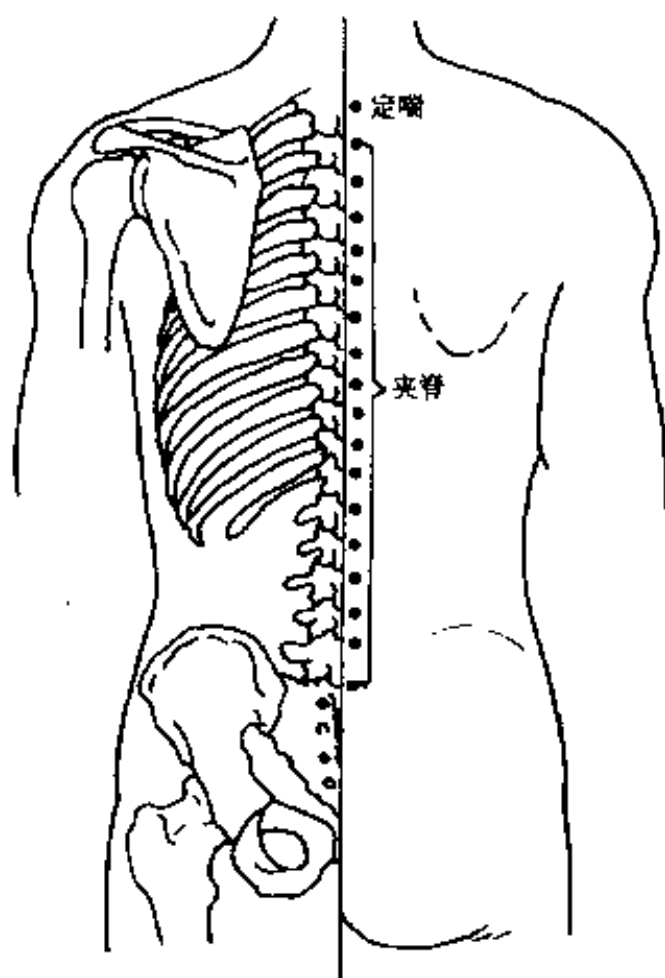


图73 定喘穴、夹脊穴

〔主治〕落枕、支气管喘息、支气管炎、荨麻疹等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

10. 夹脊 Jiǎjǐ

〔定位〕在背部、腰部，当第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两旁，各去背正中线 0.5 寸。一侧 17 穴，左右两侧共 34 穴。为便于临床应用，可按椎骨棘突定名，平等 1 胸椎棘突的为夹脊 1，以下类推（见图 73）。

〔主治〕支气管炎、支气管喘息、胸痛、肋间神经痛、腰背痛、肺结核、下肢麻痹等。上胸部穴治心肺、上肢病症；下胸部治胃肠病症；腰部穴治腰腹及下肢病症。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

11. 巨阙俞 Jùquèshù

〔定位〕第 4、5 胸椎棘突之间（见图 74）。

〔主治〕心绞痛、失眠、支气管炎、支气管喘息、背痛、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

12. 胰俞 Yíshù 又名胃脘下俞 wèiwǎnxiàshù

〔定位〕在背部，当第 8 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸（见图 74）。

〔主治〕胃炎、胃痛、呕吐、胰腺炎、糖尿病、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

13. 下极俞 Xiàjǐshù

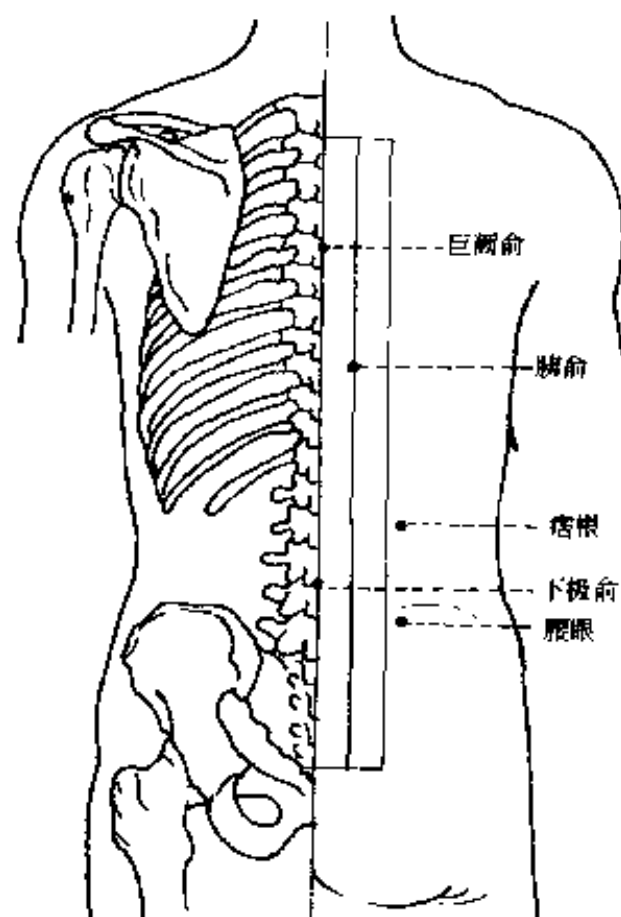


图 74 背部经外穴

〔定位〕在腰部，当后正中线上，第3腰椎棘突下（见图74）。

〔主治〕腰痛、肾炎、肾绞痛、阳痿、遗精等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

14. 腰眼 Yāo yǎn

〔定位〕在腰部，当第4腰椎棘突下（腰阳关穴）旁开约3.5寸凹陷中（见图74）。

〔主治〕腰肌劳损、腰部软组织挫伤、肾下垂、月经不调、痛经等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 5—7 壮）。

15. 提胃穴 Tíwèixué

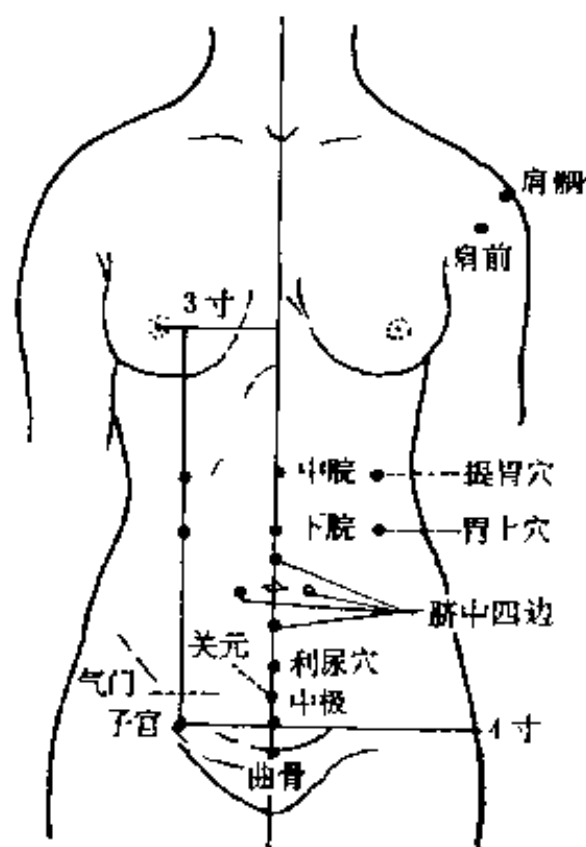


图 75 肩、腹部常用奇穴

〔定位〕中脘穴旁引水平线与肋弓之交点（见图 75）。

〔主治〕胃下垂、胃痛、消化不良等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

16. 胃上 Wèishàng

〔定位〕在脐上 2 寸（下脘穴）旁开 4 寸（见图 75）。

〔主治〕胃下垂、胃痛等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

17. 脐中四边 Qízhōngsìbiān

〔定位〕神阙穴上、下、左、右各1寸（见图75）。

〔主治〕胃痛、肠炎、消化不良等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

18. 三角灸 Sānjiǎojiǔ

〔定位〕以患者两口角的长度为一边，作一等边三角形，如△样，顶角置于患者脐心，底边呈水平，于两底角处取穴。

〔主治〕绕脐腹痛、腹泻、腹胀等。

〔灸法〕各灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

19. 利尿穴 Lìniàoxué

〔定位〕在脐下2.5寸，即脐中与耻骨联合上缘中点之中点取穴（见图75）。

〔主治〕膀胱炎、膀胱括约肌麻痹、肠炎、痢疾、胃下垂等。

〔灸法〕灸10—20分钟（或灸3—7壮）。

20. 气门 Qímén

〔定位〕在关元穴旁开3寸（见图75）。

〔主治〕膀胱炎、功能性子宫出血、产后恶露不止等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

21. 子宫 Zīgōng

〔定位〕在腹下部，当脐中下4寸（中极穴）旁开3寸处（见图75）。

〔主治〕月经不调、痛经、不孕症、附件炎、

盆腔炎、膀胱炎、睾丸炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

22. 肩前 Jiānqián

〔定位〕腋前皱襞尽端与肩髃穴连线中点（见图 75）。

〔主治〕肩关节周围炎、偏瘫等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

23. 肘尖 Zhǒujiān

〔定位〕屈肘 90 度角，于尺骨鹰嘴突起之尖端（见图 76）。

〔主治〕颈淋巴结结核、疔病、肘关节炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（3—7 壮）。



肘尖

24. 落枕穴

Làozhěnxué 又名外劳宫
Wàiláogōng

图 76 肘尖穴

〔定位〕在手背第 2、3 掌骨间，指掌关节后 0.5 寸取之（见图 77）。

〔主治〕落枕、颈椎病、指掌关节炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

25. 戒烟穴 Jièyānxué

〔定位〕在列缺穴与阳溪穴之间（见图 78）。

〔主治〕戒烟、缩窄性腱鞘炎等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

26. 中魁

zhōngkuí

〔定位〕 在中指背侧近侧指关节的中点处（见图 79）。

〔主治〕 恶心、呕吐、膈肌痉挛、牙痛等。

〔灸法〕 灸 5—10 分钟（或灸 1—3 壮）。

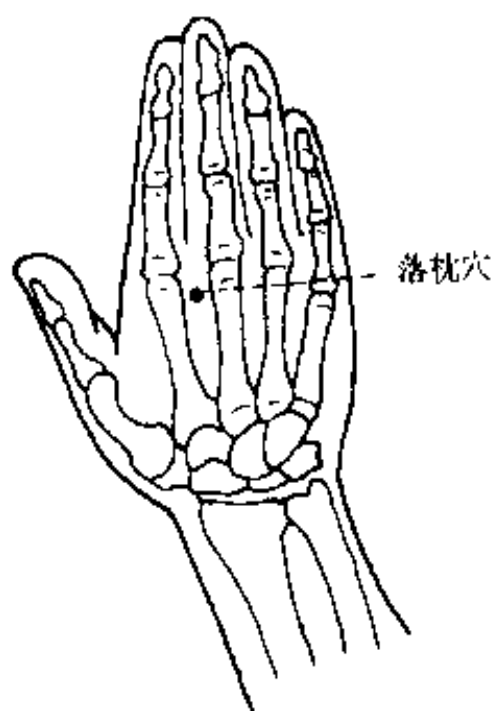


图 77 落枕穴

27. 八邪

Bāxié

〔定位〕 在手背侧，微握拳，第 1—5 指间，指蹼缘后方白肉际处，左右两侧共 8 穴（见图 79）。

〔主治〕 咽痛、牙痛、手指麻木、指掌关节炎、落枕等。

〔灸法〕 灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

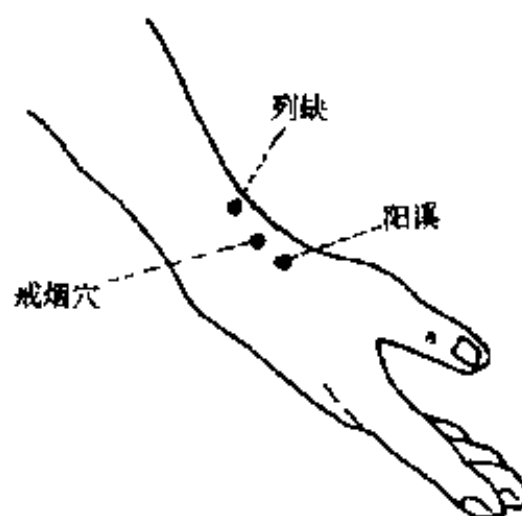


图 78 戒烟穴

28. 鹤顶 Hèdǐng

〔定位〕在膝部前面，髌底的中点上方凹陷处（见图 80）。

〔主治〕膝关节炎、下肢无力、瘫痪等。

〔灸法〕灸 10—20 分钟（或灸 3—7 壮）。

29. 内膝眼

Nèixīyǎn

〔定位〕在膝部前内面，当股骨的内侧髁，胫骨内侧髁与髌韧带内侧缘间所构成的凹陷处，横平犊鼻穴（见图 80）。

〔主治〕膝关节炎等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

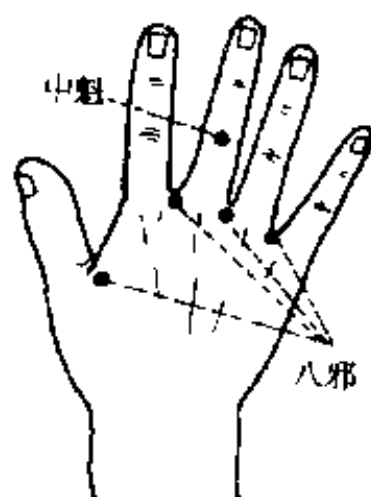


图 79 手背部经外穴

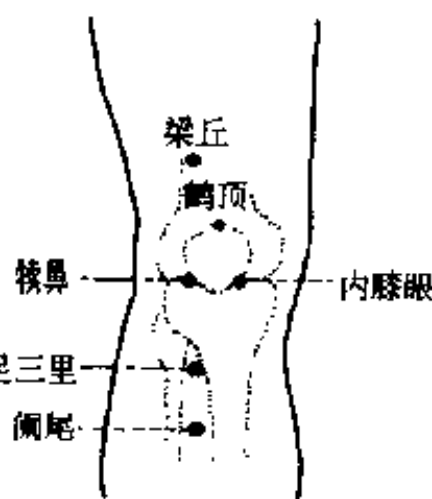


图 80 下肢经外穴

30. 阑尾穴 Lánwěixué

〔定位〕于足三里与上巨虚两穴之间压痛最明显处取穴。一般约在足三里下 1.5—2 寸处（见图 80）。

〔主治〕急、慢性阑尾炎、胃痛、消化不良等。

〔灸法〕灸 10—30 分钟（或灸 3—9 壮）。

31. 胆囊穴

Dǎnnángxué

〔定位〕在阳陵泉穴直下1寸左右的压痛点处（见图81）。

〔主治〕急、慢性胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、胆绞痛、肋间神经痛等。

〔灸法〕灸10—30分钟（或灸3—9壮）。

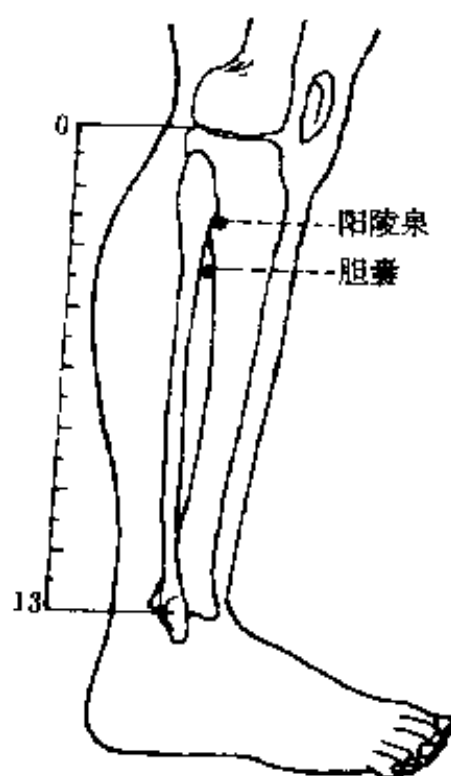


图81 胆囊穴

32. 八风

Bāfēng

〔定位〕在足背侧，第1—5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处，一侧4穴，左右两侧共8穴（见图82）。

〔主治〕足背肿痛、趾痛、头痛、牙痛、月经不调等。

〔灸法〕灸5—10分钟（或灸3—5壮）。

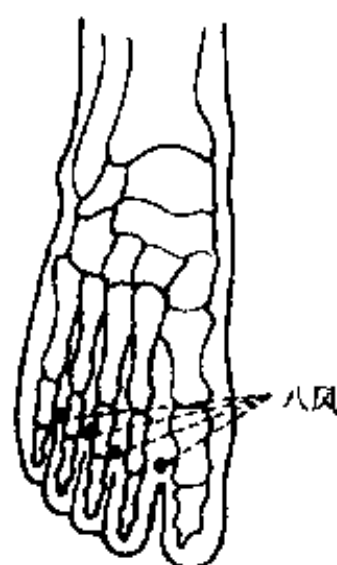


图82 八风穴

中医学对“预防”极为重视，早在《内经》中就强调了“治未病”的观点。所谓“治未病”，包括“未病先防”和“既病防变”。所以，预防保健灸法，也是养生学中一个组成部分。

预防感冒灸法

古代医学家认为“感冒乃万病之基”，这有一定的道理，患了感冒，一方面说明机体的正气不足，患感冒后，致使机体抗病能力下降，在此基础上又易患其他疾病，特别是“流行性感冒”，对机体的危害更大，所以预防感冒是很重要的。

中医认为“正气存内，邪不可干”、“邪气所凑，其气必虚”。感冒是由于机体正气不足，特别是肺卫气不足，风寒或风热之邪乘虚犯肺所致。

灸法处方：尺泽、足三里、风门、肺俞、中府、膻中。

每隔2—3日灸治1次，10次为1疗程，可休息5—7日，每季度灸1—2疗程。感冒或流行性感冒流行期间可每日灸治1次。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸，风门、肺俞若能用蒜泥灸，则效果更好。

说明：取肺经合穴——尺泽、配肺俞

和肺之募穴——中府，以补肺气、卫气，肺卫气足、感冒可防。灸风门，可防风寒或风热之邪侵入人体。膻中是八会穴之一——气会，灸之能补气，足三里为强壮保健之穴。身体健壮，感冒可防。

补肾健身灸法

中医认为肾为“先天之本”，肾藏精气，肾的精气，是产生“肾阴”与“肾阳”的物质基础，肾阴是人体阴液的根本，肾阳是人体阳气的根本。肾阴和肾阳对全身脏腑、器官起到滋润、温煦的作用。所以补肾对于健身养生是极其重要的。

灸法处方：太溪、关元俞、肾俞、京门、关元。

每隔2—3日灸1次，10次为1疗程，疗程之间可休息5—7日，每季度灸1—2疗程。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若肾俞、关元俞用瘢痕灸，则效果更佳。

说明：取肾经原穴——太溪配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾之精气；灸关元俞和关元，能大补“元气”，元气根于肾，所以亦起到补肾的作用。

健脾和胃灸法

中医认为脾胃为“后天之本”，其功能是营养物质的消化、吸收和转化人体所需要的气、血、津、液等。所以，脾胃又是“气血生化之源”。脾胃功能正常，气血生化有源，故气血旺盛，不仅能

不断的充实“先天之本”，且身体健壮，延年益寿。

灸法：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、脾俞、胃俞。

2. 足三里、章门、中脘。

每隔1—2日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息7—10日。每季度灸1—2个疗程。诸穴均可采取温和灸或雀啄灸或隔姜灸，若脾俞和胃俞能用瘢痕灸，则效果更佳。

说明：取脾经之要穴——三阴交、配脾俞和脾之募穴——章门，起健脾作用；取胃经之合穴——足三里，配胃俞和胃之募穴——中脘，起和胃作用。脾胃功能正常，气血生化有源，身体必然健壮。

健脑灸法

李时珍在《本草纲目》中说：“脑为元神之府”。这说明脑是精神活动的中心，现代医学认为：脑为人体的“中枢”，特别是大脑皮层，是人体的“最高司令部”。人的视觉、听觉、嗅觉、感觉、思维、记忆等，都是脑的功能，是生命要害之所在。因此，健脑是非常重要的。

灸法：处方列缺、百会、风府、风池、太阳。

每隔2—3日灸1次，10次为1疗程，疗程之间休3—5日，每季度灸1—2个疗程，诸穴均可采取温和灸或雀啄灸或隔姜灸。

说明：古人的《四总穴歌》教诲“头项寻列

缺”，所以，取列缺，其余诸穴均属局部取穴，能增进脑部血流量，提高大脑皮层的功能，感觉灵敏、思维敏捷、记忆佳良。

养心灸法

中医学认为：“心为君主之官，神明出焉。”心又主血脉，心脏的功能正常，血脉充盈，心神气血调和，精力充沛，思维敏捷，不会出现失眠健忘等症状，才能养生保健，益寿延年。近代医学对“养心”也很重视，亦是预防心血管疾病的重要措施。

灸法：处方通里、内关、心俞、厥阴俞、巨阙、膻中。

每隔2—3日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息3—5日。每季度灸1—2个疗程。50岁以上者，可隔日灸治1次，10次为1疗程、疗程间可休息2—3日，每季度灸2—5个疗程。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。心俞、厥阴俞若能用隔蒜灸或瘢痕灸，则效果更佳。

说明：取心经络穴——通里、配心俞和心之募穴——巨阙，再取心包经络穴——内关、配厥阴俞（又名心包俞）和心包之募穴——膻中，共同起到养心安神之作用，亦能预防心血管疾病的发生。

眼睛保健灸法

眼睛的保健亦很重要，特别是青少年，更应注意，以防近视的发生，中医理论认为：“肝开窍于

目”，肝的经脉和它相联系，眼睛所以产生视觉功能，是来源于肝经阴血的濡养，若肝经的阴血不足就会产生两目干涩，视物模糊，甚至夜盲。

灸法：处方光明、肝俞、期门、翳明、太阳、阳白、四白。

每2—3日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息5—7日，每季度1—2个疗程。诸穴均可采取温和灸或隔姜灸。太阳、阳白、四白等穴，灸时要注意，切莫形成“瘢痕”。

说明：光明是胆经之络穴，与肝经相连络，是防治眼病的要穴，配肝俞和肝之募穴——期门，以养肝明目；翳明是防治眼病的奇穴；太阳、阳白、四白均属局部取穴，改善眼区的血液循环，保护眼睛，以养视力。

青壮年保健灸法

青壮年是学习、工作较紧张的时期，如何保持气血旺盛、思维敏捷、精力充沛、肌肉丰满、筋骨坚实、行动灵活、延缓衰老是极其重要的。

中医认为脾为气血生化之源，故为“后天之本”，但还需“肾阳”的温煦；肾为“先天之本”，所藏精需要脾运化水谷精微的不断补充。因此，脾与肾在生理上的相互资助、相互促进，在人体生命中占有重要地位。

灸法：处方三阴交、足三里、关元、脾俞、肾俞。

每隔 2—3 日灸 1 次，10 次为 1 疗程，疗程期间休息 3—5 日，每季度灸 1—2 个疗程。诸穴均可取温和灸或隔姜灸，足三里、脾俞、肾俞若采用瘢痕灸，则效果更佳。

说明：三阴交不仅是脾经要穴，且肾经也相交于此，配脾俞、肾俞以健脾补肾。气血生化有源，不断补充先天之精。足三里是保健穴。古人云：“身体若要安，三里常不干。”意思是足三里穴常施瘢痕灸，身体才能安康；灸关元以补元气。

中老年的保健灸法

中老年人，应滋补肝肾。中医认为“肝肾同源”，说明关系之密切。肝藏血，肾藏精，精血互生。所以，也可以说“精血同源”。病理上常见肾阴不足导致肝阴不足而出现高血压和动脉硬化病的临床表现。

灸法：处方三阴交、足三里、关元、肝俞、肾俞。

每隔 1—2 日灸 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间休息 2—3 日，每季度灸 2—3 个疗程。诸穴均可用温和灸或隔姜灸。若足三里、肝俞、肾俞采用瘢痕灸，则效果更好。

说明：三阴交穴乃是脾经、肝经、肾经相交会之处，不仅能健脾、配肝俞、肾俞，以滋补肝肾；足三里乃是保健要穴，故取之；关元穴补元气，必取之。

戒烟灸法

吸烟对人体百害而无一利，很多恶性肿瘤如肺癌、喉癌、鼻咽癌、膀胱癌和子宫颈癌等均与吸烟有关。吸烟与心脑血管疾病也有密切关系。另外吸烟是慢性支气管炎并发肺气肿、肺心病的一个最常见的病因。全世界每年因吸烟患病而致死的人数逾300万，远远超过交通事故、艾滋病的死亡人数。专家们提出：“吸烟是20世纪的‘鼠疫’，吸烟是人类的新瘟疫。”所以世界卫生组织提出了“2000年没有吸烟者”的号召，因此反吸烟运动和戒烟运动是何等重要啊！

戒烟，首先是吸烟者应有戒烟的愿望和决心，认识到吸烟的严重危害。有的吸烟者认为吸烟能“清醒”脑筋，提高脑力劳动效率；有的还说“饭后一支烟，赛过活神仙”，这些认识都是不科学的，也可以说是愚昧的。有的青少年错误地认为：“烟卷一夹，格外潇洒。”更应引起家长和老师们的注意。没有戒烟的愿望和决心，戒烟是困难的。

受戒者有了戒烟的愿望和决心，灸法能抑制烟瘾。另外能消除或减轻戒烟后出现“戒断现象”，例如头痛、嗜睡、注意力不集中、焦虑、烦躁不安等。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 列缺、戒烟穴、肺俞、心俞。
2. 通里、戒烟穴、中府、巨阙。

每日灸1—2次，10次为1疗程。疗程间可休息1日。戒烟穴，在犯烟瘾时，随时灸之。诸穴均采用温和灸或隔姜灸。若肺俞、心俞采用隔蒜灸或癰痕灸，则效果更佳。

说明：鼻喉、气管、支气管和肺，中医认为均属于“肺经”，烟刺激了“肺经”，又在肺泡吸收尼古丁，所以取肺经络穴——列缺、配肺俞和肺之募穴——中府，以增加受戒者感到“烟味不香”，甚至感到“异味”；“戒断现象”多属“心经”病的症状，故取心经络穴——通里、配心俞和心之募穴——巨阙，以减少或消除“戒断现象”。戒烟穴是戒烟很有效的奇穴，故两组处方均有之。

随症选穴：头痛加风池、百会；焦虑、烦躁不安加内关；注意力不集中加四神聪；嗜睡眠加劳宫、涌泉穴。

戒酒灸法

适当饮酒对身体有益，而过量饮酒对身体有害。特别是酗酒，更影响安定。长期过量饮酒会导致各种疾病。长期饮酒对中枢神经系统有较强的刺激作用，使注意力不集中、记忆力减退，尤其汽车司机因饮酒而发生交通肇事太多。重者出现乏力、昏睡，甚至呼吸中枢麻痹而死亡。酒精可直接刺激胃粘膜，一次大量饮酒可引起急性胃炎、胃及十二指肠溃疡，饮酒可引起血管扩张，使心跳加快，增加心肌耗氧量，易引起心绞痛、心肌梗塞或心律失

常等；饮酒可直接损害肝细胞，导致脂肪肝或肝硬化；饮酒容易引起脑出血。有资料统计，长期过量饮酒使人寿命缩短 10—20 年。因此，切忌过量饮酒，患有心脏病、脑血管病、胃肠病、肝病、呼吸系统疾病的人，尽量少饮酒或戒酒。

受戒者必须有戒酒的愿望和决心，才能收到效果。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 通里、巨阙、中脘、地仓。
2. 丰隆、心俞、胃俞、承浆。

每日饮酒 1 次者灸治 1 次，饮 2 次者灸 2 次，每日饮 3 次者灸 3 次。灸 10 日为 1 疗程，疗程间休息 1—3 日，在饮酒前 0.5—1 时开始灸治效果好。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。若心俞和胃俞采用隔蒜灸则效果更好。

说明：酒瘾属“心瘾”，故取心经络穴——通里、配心俞和心之募穴——巨阙，以抑酒瘾；胃腑受纳和吸收酒精，取胃经络穴——丰隆、配胃俞和胃之募穴——中脘，以减少胃腑对酒精的受纳和吸收；取地仓、承浆灸之，以致对酒的口感不佳。

随症选穴：饮酒致手颤者加曲池、合谷；记忆力下降者加四神聪。

减肥灸法

肥胖症是指人体的热量以脂肪形式积聚过多而造成体重超重的疾病。在 50 岁以上的人群中多见。

引起肥胖症的原因很多，概括起来有三个方面：一是外源性肥胖，由过量饮食引起，又称“营养性肥胖”。二是内源性肥胖，多由内分泌紊乱造成。如垂体性肥胖、肾上腺皮质机能亢进性肥胖、甲状腺机能减退性肥胖、性腺机能不足性肥胖、多腺性肥胖等；肥胖的临床表现一般可分为单纯性肥胖和继发性肥胖两类，前者脂肪分布较均匀，男性表现为多血型肥胖，即体质发育好，肌肉强壮，血色素正常或略高，唇耳常充血，颈粗厚，腹膨隆；女性多表现为贫血型肥胖，即脂肪组织松弛，肌肉组织虚弱，脉搏细小，贫血貌，体力弱，易于心慌气喘，食欲差，常伴有蛋白质缺乏，缺铁性贫血等营养不良症候。正常体重（公斤）= 身高（厘米）- 100。超过正常体重 20% 以上者，称为肥胖症。肥胖病人较正常体质者抵抗力低，常并发多种疾病，如动脉硬化、高血压病、心血管疾病、胆石症、糖尿病、肝硬化、关节退行性变等。

随着社会的进步和预防、保健医学的发展，人们对肥胖影响形体美及危害人体健康的认识日益加深，多种多样的减肥方法也应运而生，灸法减肥也是比较有效的。

中医学认为肥胖与恣食甘肥有密切关系；肺、脾、肾三脏的功能失调是本病的内在因素。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、肾俞、脾俞、肺俞。
2. 尺泽、京门、章门、中府。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休3—5日。诸穴均用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若肾俞、脾俞、肺俞用隔蒜灸或瘢痕灸，则效果更好。

在灸治期间和体重恢复到正常以后，应多食蔬菜而少吃脂肪、糖等高热量饮食；多运动或参加体力劳动，特别是不能在饭后马上睡眠。

说明：中医学认为肥胖是由于体内水湿过多所致，“肺为水之上源”，“肺通调水道”；“脾运化水湿”；“肾为水之下源”，“肾主水”。三阴交为脾、肝、肾三经交合之穴，取之配脾俞和脾之募穴——章门，健脾以运化水湿；三阴交配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾利水；取肺经合穴——尺泽、配肺俞和肺之募穴——中府，以通调水道。

随症选穴：有贫血者加血海、膈俞；食欲不振者加中脘、梁门；心悸加内关。

支气管炎

支气管炎是临床常见病、多发病。本病是因为支气管粘膜受到细菌或病毒的感染，或受到某种理化因素、过敏、气候变化的刺激引起炎症。临床以咳嗽、咯痰或喘促为主。本病有急性与慢性之分。急性支气管炎，未得到及时恰当地治疗，可转变为慢性支气管炎。慢性支气管炎若得不到及时地治疗，可并发肺气肿、肺心病，影响患者的生活、学习和工作，还将缩短患者的生命。

本病中医认为是由于风寒或风热或燥邪犯肺，致肺气不宣而出现咳嗽、咯痰、喘促等。

治疗：处方分两组，交替用之。

1. 列缺、风门、肺俞、膈俞。
2. 尺泽、中府、膻中、天突。

急性支气管炎，可每日灸治2次，待痊愈为止。慢性支气管炎，每日灸治1次，10次为1疗程。疗程之间可休息2—3日。症状较重者亦可每日灸治2次或疗程之间不休息。全部腧穴可用温和灸或隔姜灸。若风门、肺俞、膈俞能隔蒜灸或癰疽灸，则疗效更佳，特别是对慢性支气管炎。

慢性支气管炎冬季发作或症状加重者，三伏天灸治3个疗程；夏季复发或症状加重者，冬季“入九”灸治3个疗程，疗效更佳。

说明：列缺为肺经络穴，尺泽为肺经合穴，配肺俞与肺之募穴中府，能宣肺止咳；风门有祛散风寒、风热之功效；膻中为八会穴之一——气会，有宽胸利膈、降逆化痰之功效；天突能止咳化痰；膈俞为八会穴之一——血会，据现代医学研究有增强人体抗炎作用。

随症选穴：若有头痛加风池、百会；肢体酸痛加手足三里；多汗而热不退加复溜、合谷；痰多加丰隆。

支气管喘息

支气管喘息是临床较常见的、发作性的呼吸道过敏性疾病。其发生与接触粉尘等致敏性物质有关，也可因气候骤变，情志因素，或某些炎性刺激而诱发。发作前常有鼻、咽、喉部发痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆症状。随即迅速出现呼吸急促、喉间哮鸣，甚则张口抬肩，病人多被迫取坐位或跪伏位。严重者可见额汗淋漓、唇舌紫绀或虚脱。病人痛苦异常。但本病发作有时间性，多在夜间发作或加重。发作持续时间长短不一。一般数十分钟或数小时可缓解，也有持续数小时或数日者。缓解后症状暂时消失，近于常人。

祖国医学认为本病是由于痰伏胸膈，遇感引

触，痰气交阻，壅塞气道所致。因气道狭窄通畅不利、痰随气升，故见气息喘促、痰鸣如吼。其发病与肺、脾、肾三脏功能失调有关。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、定喘、肺俞、膈俞、肾俞。
2. 尺泽、中府、膻中、气海、京门。

每日灸治1次，症状较重者，每日可灸治2—3次，10次为1疗程，疗程之间可休息1—3日。症状较重者，疗程之间可不休息。

冬季复发或症状加重者，三伏天灸3个疗程；夏季复发或症状重者，冬季“入九”后灸3个疗程。疗效较佳。

全部腧穴可用温和灸或隔姜灸。肺俞、膈俞、肾俞等穴，若用隔蒜灸或瘢痕灸，疗效更佳。

说明：尺泽为肺经合穴，配肺俞和肺之募穴——中府，能宣发肺气，气道通畅而平喘；膻中为八会穴之一——气会，善宽胸理气而平喘；太溪配气海、肾俞和肾之募穴——京门，可补肾纳气而止喘；定喘穴为平喘而有效的经外奇穴，故灸之。现代医学观察，喘息时，体内肾上腺素、肾上腺皮质激素相对减少，膈俞具有调节内分泌作用，灸该穴能调节内分泌而止喘。

随症选穴：鼻塞加上星、印堂；喉痒加天突；痰多加丰隆。

冠心病

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称。是中、老年最常见的一种心血管疾病。本病是因冠状动脉粥样硬化后，使管腔狭窄或阻塞影响冠脉血液循环，导致心肌缺血缺氧而引起的心脏病变。临床以突然阵发性的胸闷窒息或疼痛为主要表现。有的可波及大部分的心前区，并放射至左肩左上肢，多沿前臂内侧直达小指与无名指。发作时伴面色苍白、心悸不宁、短气等。疼痛剧烈时可见肢冷汗出、或引起心源性休克及心衰等后果。疼痛常在饮食过饱、寒冷刺激、吸烟、劳累和情绪激动时突发。一般疼痛历时1—5分钟，很少超过15分钟，疼痛发作时偶可伴有濒死的恐惧感觉。休息和用硝酸甘油等血管扩张药后可缓解。其发病与年龄、烟酒嗜好、精神、血液及遗传等因素有关。

中医认为本病属“胸痹”、“心痛”范畴。是由于寒凝气滞、血瘀、痰阻等痹遏心阳、阻滞心脉；或心脾肝肾亏损，心脉失养所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 大陵、太冲、巨阙、膻中。
2. 神门、太溪、心俞、厥阴俞。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休3—5日。有心绞痛者每日可灸2—3次。

诸穴可用温和灸或隔姜灸。若心俞、厥阴俞、巨阙、膻中等穴隔蒜灸或瘢痕灸，疗效更佳。

说明：大陵为心包经的原穴，神门为心经原穴，配合两经的俞穴和募穴膻中、巨阙，以振心阳，活血化瘀，瘀化则气血通，通则不痛。太溪为肾经原穴，灸之补肾阳以助心阳；太冲为肝经原穴，灸之补肝血，以助心脉。

随症选穴：心绞痛发作时可拿按内关，尤其左侧内关。胸闷者加灸内关。气短者加气海；失眠者加安眠。

高血压病

高血压病是临床常见病、多发病。中老年人发病率较高。该病不仅影响患者的学习、工作和生活，后期可致心、脑、肾等重要脏器发生病变，可危及患者的生命。

该病是高级神经中枢调节血压之功能紊乱所致的疾病。临床常见有头痛、头晕、心悸、失眠、眼花等表现。血压等于或超过21.3/12.7千帕（160/95毫米汞柱）可诊断为本病。

但应与肾炎、内分泌疾病所引起的症状性高血压相鉴别。

本病中医认为是由于心肾亏虚、肝阳上亢所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、肾俞、肝俞、心俞、风府、风池。
2. 太冲、京门、期门、巨阙、百会、率谷。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可

休息 2—5 日。症状较重者可每日灸 2 次。每灸 2—3 个疗程，可测血压以观察疗效。血压恢复正常后，也需再灸治 1—2 个疗程，以巩固疗效。若症状较重者或舒张压在 13.3 千帕（100 毫米汞柱）以上者，每日可灸 2 次。

诸穴可用温和灸或隔姜灸。若心俞、肝俞、肾俞等穴用隔蒜灸或癰痕灸，则疗效更佳。

说明：太溪为肾经原穴，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾阴；太冲为肝经原穴，配肝俞和肝之募穴——期门以平肝潜阳；心俞配心之募穴——巨阙以补心血；风府、风池、百会、率谷以治头晕头痛并有降压作用。

随症选穴：失眠加神门、安眠；耳鸣加听会、翳风。

低血压病

低血压是指血压等于或低于 12/8 千帕（90/60 毫米汞柱）。患者以头晕目眩为主要表现的疾病。多发于老年人或体质较弱之人。女性多见。本病系大脑皮层血管运动中枢的一种神经官能症表现。为神经血管张力不足所致。临床上可分为症状低血压和体位性低血压。由于血压过低，轻者见头昏乏力，较重者便有头晕目眩、神疲嗜睡、心悸胸闷、心前区不适、气短懒言等表现，血压更低时可出现猝然昏厥。老年低血压常易合并脑及内脏器官血栓形成，如脑血栓形成、心肌梗塞等。所以本病对于

中老年人可影响健康，甚至危及生命。对于青年女性，也影响学习、工作和生活。但也有不少原发性低血压患者无明显症状，仅血压低于 12/8 千帕。随着年龄的增长，亦不可忽视。

中医认为本病属“眩晕”范畴，多由于先天禀赋不足，或后天失养导致心阳不振，心肾阳虚、脾胃虚弱、气血生化无源等。以致气血衰少，阳弱推动无力，气血不能通达脑髓和四末而引起。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、神门、肾俞、胃俞、脾俞、膈俞、心俞。

2. 足三里、大陵、京门、中脘、章门、气海、巨阙。

每日灸治 1 次，10 次为 1 疗程，疗程之间可休息 1—3 日。症状较重或舒张压等于或低于 8 千帕（60 毫米汞柱）者，每日可灸治 2 次。根据症状好转情况，测血压，若血压已恢复正常再灸 1—2 个疗程，以巩固疗效。若血压没有恢复正常，应继续灸治。

诸穴可采用温和灸或隔姜灸。若肾俞、脾俞、膈俞、心俞用隔蒜灸或癰痕灸则疗效更佳。

说明：太溪为肾经原穴，配肾俞和肾之募穴——京门，补肾阳以助心阳；神门为心经原穴，大陵为心包经原穴，配心俞和心之募穴——巨阙，以补心阳；足三里配胃俞和胃之募穴——中脘，脾俞和脾之募穴——章门，以健脾和胃，使气血生化有

源；膻俞为血会配气海，以补气血。经现代医学实验研究，膻俞穴确能治疗缺铁性贫血。

随症选穴：头晕加风池、百会；心悸胸闷加内关、膻中；昏厥加上星、印堂。

心脏神经官能症

心脏神经官能症又称心血管神经官能症。是因神经功能失调引起的心血管系统功能紊乱的一种病症。发病年龄多在20—40岁之间，以女性居多。主要临床表现有心悸、胸闷、心前区痛、疲乏无力，眩晕、焦虑、失眠、精神不振及善叹息样呼吸等。多在受惊恐、情绪波动、过劳或久病后出现症状或使症状加重。查体：一般多无与症状相应的阳性体征。其发病有时作时止，时轻时重的特点。

本病属祖国医学的“心悸”、“胸痹”、“郁证”、“脏躁”等范畴，证有虚实之分。虚证多由气血不足，心失所养而致。实症则由痰火扰心，使心神不宁；或心血瘀阻、心脉不通而造成。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 通里、内关、心俞、厥阴俞。
2. 神门、大陵、巨阙、膻中。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休息2—3日。症状较重者可每日灸治2次，并注意随症选穴的应用。待症状全部消失后，再灸治1—2个疗程，以巩固疗效。

全部腧穴可采用温和灸或隔姜灸。若心俞、厥

阴俞、巨阙、膻中等穴用隔蒜灸则疗效更佳。

说明：神门、通里为心经原、络穴，大陵、内关为心包经原穴、络穴，配心俞和心之募穴——巨阙，厥阴俞和心包之募穴——膻中，以补心血，心有所养则心悸而止。

随症选穴：失眠加安眠、百会；眩晕加风府、风池；疲倦乏力加手足三里；精神不振加神道、神堂。

高血脂症

高血脂症又称高脂蛋白血症。是指血浆脂质中一种或多种成分（如胆固醇、甘油三脂等）的浓度超过正常高限而言。症状表现较复杂或无症状。临床可分为原发性和继发性两种。原发性原因尚不清，大多有家族史和遗传史，继发性与动脉粥样硬化、冠心病、高血压、肥胖病、糖尿病、脑血管病等有密切关系。由于本病易造成微循环瘀滞，故其危害和防治均当引起人们的重视。

本病虽症状复杂或无症状表现，但通过实验室检验则可确诊。

本病属中医的“痰浊”、“肥胖”等范畴。其发病是因过食肥甘、脾胃运化功能失常，湿浊内生，留于脉络，着而不去所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 公孙、中脘、章门、中府、水分。
2. 列缺、胃俞、脾俞、膈俞、肺俞。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程之间休息3—5日，再进行下一疗程。当治疗4—5疗程后，进行实验室检验胆固醇、甘油三脂等，若恢复正常，可再进行1疗程的治疗，以巩固疗效。若未恢复正常，可再进行4—5个疗程的灸治。

诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。若胃俞、脾俞、膈俞、肺俞、水分等穴采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更佳。

说明：公孙为脾经之络穴，配脾俞和脾之募穴——章门，胃俞和胃之募穴——中脘，以健脾和胃，运化水湿，祛痰降浊；列缺为肺经之络穴，配肺俞和肺之募穴——中府，以利肺气。肺“通调水道”以利水湿；水分为利水要穴；血脂高也为血分患病，故取血会——膈俞。

雷诺氏病

雷诺氏病又叫“肢端动脉痉挛症”。是由血管神经功能紊乱而引起的肢端小动脉痉挛性疾病。本病好发于青壮年女性，少数呈家族性发病，常因情绪激动或受寒冷而诱发。典型的发作为突然发生肢端皮肤苍白，再转为紫绀，以手指指端为主，呈对称性或波及整个手指甚至手掌。同时伴肢端冰凉、怕冷、麻木、针刺样疼痛和酸胀不适，上肢尺、桡动脉搏动减弱。有阵发特点，经数分钟或数小时后可缓解，缓解时局部出现潮红，肢端有搏动和知觉异常感。

祖国医学认为本病是由于气虚血瘀、阳虚寒凝，寒客经脉或情志刺激等导致气机阻滞，经脉气血流行不利，阳气郁遏，不能达于四末所引起，属“血痹”范畴。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 合谷、太渊、曲池、心俞、厥阴俞。
2. 神门、内关、小海、巨阙、膻中。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休息3—7日。若肢端突然皮肤苍白，肢端冰凉，可立即灸曲池、小海、内关、太渊、神门、合谷。此时灸治，疗效较高。

诸穴均可采用温和灸或隔姜灸，若心俞、厥阴俞、巨阙、膻中采用瘢痕灸、疗效更佳。太渊穴灸治时，必须施温和灸，不能施瘢痕灸，恐伤及该穴皮下的桡动脉血管。

说明：太渊为八会穴之一——脉会，经脉气血流行不利当取之；神门为心经原穴，内关为心包经络穴，配心俞和心之募穴——巨阙、厥阴俞配心包经募穴——膻中，以助心气促气血运行；膻中又为八会穴之一——气会，灸之则气行，“气行则血行”，气血能达四末，“血痹”则愈。曲池与小海属局部取穴，以达到疏通经络和镇痛的目的。

随症选穴：情绪易激动者加太冲，肝俞；手指麻木，疼痛甚者加八风。

胃肠神经官能症

胃肠神经官能症，是一种较常见的以胃或肠的运动与分泌功能紊乱为主要特征的慢性疾病。是由高级神经功能紊乱所导致。本病多发于青壮年及脑力劳动者，女性发病高于男性，有起病缓慢，呈持续性或反复性发作的特点。多由精神因素所导致。胃神经官能症多表现为反复上腹部剧痛或嗳气，心窝部灼热感、吞酸、食后呕吐、上腹饱胀或不适，食欲不振及咽部异物感等；而肠神经官能症则表现为情绪性的或食后腹痛、腹泻、腹胀、肠鸣或便秘等，前者较后者常见。二者均可伴有焦虑、失眠、眩晕、心悸、精神涣散或烦躁不安等精神症状。

本病属祖国医学的“胃脘痛”、“腹痛”、“泄泻”、“郁证”范畴，多因情志不遂，郁怒伤肝，肝郁气滞，横逆犯胃，致使肝胃不和或肝脾不调，遂发生本病。

治疗：处方分两组，交替取之。

1. 足三里、中脘、梁门、期门。
2. 太冲、胃俞、肝俞、膈俞。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休息2—5日。若上腹剧痛，可随时灸之，以第1组处方为主。

诸穴均可采用温和灸或隔姜灸，若中脘、胃俞隔蒜灸或瘢痕灸，疗效更佳。

说明：足三里为胃之合穴，配梁门胃俞和胃之

募穴——中脘，和胃止痛；太冲为肝之原穴，配肝俞和肝之募穴期门，以疏肝理气，和胃降逆。膈俞能宽中和胃。

随症选穴：暖气加内关；焦虑失眠加神门、安眠；眩晕加风池、百会；心悸加巨阙、心俞；便秘加支沟；咽部异物感加天突。

治疗肠神经官能症处方分两组，交替灸之。

1. 上巨虚、中脘、天枢、关元、章门。
2. 三阴交、胃俞、大肠俞、小肠俞、脾俞。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程之间可休息2—5日。若腹痛、腹泻较重时随时可灸，亦可每日灸治2—3次。

诸穴均可采用温和灸或隔姜灸，若大肠俞、天枢等穴能隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更佳。

说明：上巨虚为大肠经之下合穴，配胃俞和胃之募穴——中脘、大肠俞和大肠经之募穴——天枢、小肠俞和小肠经之募穴——关元，以调节胃肠机能，止痛止泻；三阴交为脾经要穴，配脾俞和脾之募穴——章门，健脾和胃，以止腹痛腹泻。

随症选穴：同胃神经官能症的随症选穴。

胃及十二指肠溃疡

胃及十二指肠溃疡是一种临床发病率较高的疾病。其形成和发展与胃液中胃酸和胃蛋白酶等消化分泌亢进有密切关系。所以又称消化性溃疡。80年代，我国医学家发现本病与幽门螺旋杆菌感染有

关。该病可发生于任何年龄，但以青壮年居多，男性患者远多于女性。上腹部有规律的反复发作的疼痛是本病最常见的症状。其发作与进食量过多、食物粗糙不易消化，酸咸辛辣等刺激性食物以及精神刺激等有关。多伴有嗝气、吞酸、恶心、呕吐、上腹胀闷，心窝部灼热感，食少乏力，甚至呕血、便血等症状。经钡餐透视可确诊。

本病在祖国医学中属“胃脘痛”等范畴。多由情志失调，气郁化火，横逆犯胃或饮食不节，损伤脾胃；或脾胃素虚，脏器虚寒等原因使脾胃气机失调、胃失和降而发生疼痛及其他症状。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 足三里、中脘、梁门、章门。
2. 三阴交、胃俞、膈俞、脾俞。

每日灸治 1 次，10 次为 1 疗程，疗程之间可休息 2—3 日。症状较重者可每日灸治 2 次。若膈俞、脾俞、胃俞施瘢痕灸，疗效更佳。

说明：足三里是胃经合穴，配梁门、胃俞和胃之募穴——中脘，以和胃止痛；三阴交为脾经要穴，配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾和胃；膈俞可宽中和胃。据现代医学研究，膈俞有明显的抗炎作用，以消灭幽门螺旋杆菌，溃疡可愈合。

随症选穴：心窝部灼热感加太溪；遇精神刺激症状加重者加太冲、肝俞；黑便者加血海。

慢性胃炎

慢性胃炎是指不同原因引起的各种胃粘膜慢性炎性病变。是临床较常见的消化系统疾病。其发病与免疫功能低下、幽门螺旋杆菌的感染或幽门括约肌舒缩功能紊乱等因素有关。也可由急性胃炎反复发作而导致。临床可分为浅表性与萎缩性两型。但以浅表性胃炎多见。浅表性胃炎可转变成萎缩性胃炎，或两型并存。本病以上腹部灼痛、胀痛或隐痛，腹部饱胀感，食欲不振、气短乏力、暖气等为临床主要表现。一般病程较长，症状可间歇出现或长期持续存在，通过胃镜检查可确诊。由于胃粘膜萎缩及肠上皮化生等病理改变可以发生癌变，故应引起重视。本病的发病率随年龄的增长而增长。

中医认为本病属“胃脘痛”、“痞满”、“虚劳”范畴。多因饮食不节、情志失调、久病体弱等导致脾、胃、肝等脏腑功能失调，胃失和降所致。

治疗：处方分两组，长期交替灸之。

1. 足三里、中脘、梁门、幽门、章门。
2. 三阴交、胃俞、膈俞、膏肓俞、脾俞。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程之间可休息3—5日。症状较重者，每日可灸治2次。若膏肓俞、膈俞、脾俞、胃俞施瘢痕灸，则疗效更佳。待症状全部消失后，可再作胃镜检查。

说明：足三里是胃经之合穴，三阴交为脾经之要穴，配胃俞和胃之募穴——中脘，脾俞和脾之募

穴——章门，以健脾和胃、止胃脘痛；梁门、幽门二穴，均属局部取穴，有调整幽门括约肌的舒缩功能；膈俞穴有调节免疫机制而增强抗炎作用；膏肓俞穴有主治羸瘦虚损之功效。

随症选穴：气短乏力加膻中、气海；上腹部灼痛加上脘；腹部饱胀感加天枢、大横；暖气加内关、天突。

胃下垂

胃下垂是指在站立位时，胃的位置低于正常，甚至垂入盆腔而言。临床可见心窝部隐痛，腹胀并有下坠感，食后更甚，立位较重，卧位时减轻或消失，还可见消化不良、食欲不振、暖气、消瘦乏力、便秘或腹泻等一系列消化道症状。胃下垂的发生有先天性与后天性之分，前者多见于先天性无力型（瘦长体形）体质，多与其他脏器同时下垂。后者则多由消耗性疾病、妇女生育过多等原因导致腹壁张力弛缓、腹压下降，胃体失去支撑而致。本病多发于青壮年，女性多见。X线钡餐透视对本病可以确诊：胃小弯低于髂嵴联线或胃大弯低于髂嵴联线大于6厘米者。

中医学认为本病是因长期饮食失调、七情内伤、劳倦过度及久病等导致脾胃虚弱，中气下陷、升降无力，而使脏器下坠。

治疗：处方分两组，交替灸之。而提胃穴每次均灸之。每次灸后令患者卧床2小时左右。

1. 足三里、中脘、章门、提胃穴。

2. 三阴交、胃俞、脾俞、提胃穴。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息2—3日。经过2—3个疗程的灸治，若症状消失可进行钡餐透视检查，若痊愈，再进行1疗程的灸治，以巩固疗效；尚未痊愈，可继续灸治2—3个疗程再进行钡餐透视检查，以证明痊愈否。

说明：足三里为胃经之合穴，三阴交为脾经之要穴，配胃俞和胃之募穴——中脘，脾俞和脾之募穴——章门，补脾胃之气，以升提下陷之胃；提胃穴是治疗胃下垂有效的经外奇穴故取之。

随症选穴：食欲不振加梁门；暖气加天突；便秘加支沟；腹泻加天枢；疲乏无力加关元。

慢性结肠炎

慢性结肠炎多指慢性非特异性溃疡性结肠炎。是直肠、乙状结肠粘膜的表浅性非特异性炎症。其发生与遗传因素、免疫异常、精神因素及非特异性感染有关。临床主要表现为腹痛腹泻、泻后痛减、粘液血便、里急后重，伴有发热（多为低中度发热）、贫血、消瘦等。本病的病变部位主要在直肠和乙状结肠，严重者可累及整个结肠。有起病缓慢、病程较长，反复发作的特点。是一种对人体健康危害较大的慢性消化系统疾病。本病通过内镜检查和便培养可确诊。

本病与中医学中的“久泻”、“久痢”、“休息

痢”等病证相近。多为外邪侵入或饮食不节、情志失调、体虚过劳等导致脏腑功能失调。如脾胃虚弱、肝脾不和及肾阳不足等均可导致脾胃功能失常、脾虚湿胜而发生本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 上巨虚、天枢、京门、中脘、章门。
2. 太溪、阴陵泉、大肠俞、肾俞、胃俞、脾俞。

每日灸治 1 次，10 次为 1 疗程，疗程之间休息 2—3 日。大约经过 4—5 个疗程的灸治，方能收效，8—10 个疗程，有可能被治愈。对背部俞穴若能采用瘢痕灸，则疗效会更好。

说明：结肠相当于中医所说的大肠。上巨虚为大肠经下合穴，阴陵泉为脾经合穴，配大肠俞和大肠之募穴——天枢、脾俞和脾之募穴——章门，胃俞和胃之募穴——中脘，以增强脾、胃、大肠等脏腑之功能，致“久泻”获愈；取肾经原穴太溪，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾阳，肾阳足，以助脾阳，脾阳足，则胃肠功能亦强。

随症选穴：便血、贫血加血海、膈俞；里急后重加长强；发热加大椎、曲池。

习惯性便秘

习惯性便秘又称原发性持续性便秘。是指排便间隔时间延长，2 日或 3 日以上 1 次，甚者 5 日至 7 日 1 次，粪质干燥坚硬，排便坚涩不畅，并有不

适感而言。本病可发生于任何年龄，尤以中年以上经产妇女多见。除排便费力外常伴有食欲不振，暖气、口苦、眩晕、倦怠、心悸、失眠等全身症状，并可引起肛裂或诱发痔疮。本病多由精神神经紊乱，肠蠕动减弱，排便动力缺乏，肠粘膜应激力减弱，排便反射减弱或消失等原因，使粪便在肠腔内滞留过久，水分被过量吸收，进而导致粪质干燥，排出困难。

本病在中医学中亦称“便秘”。病位在大肠。多为素体阳盛，或过食辛热厚味以致胃肠积热，津液耗伤、肠道失润；或情志失和，气机郁滞，或劳倦饮食内伤及病后产后年老体弱之人气血两亏等使大肠传导功能失常，糟粕停滞过久所致。

治疗：处方分为两组，交替灸之。

1. 支沟、上巨虚、天枢、中脘、关元。
2. 支沟、足三里、大肠俞、胃俞、小肠俞。

每日灸治1次，5次为1疗程，疗程之间休1—2日。在治疗期间和痊愈后，应常食芹菜、韭菜、豆芽菜、大白菜等含纤维素丰富的蔬菜，以刺激肠管蠕动，以减少粪便在肠内的滞留和大肠对水分的过多吸收。

说明：支沟乃明代医学家——张介宾总结治疗便秘的经验穴，后人用之亦有效，故两组处方均取之；上巨虚为大肠经之下合穴，配大肠俞和大肠之募穴——天枢，可调节大肠传导功能增强大肠蠕动；足三里乃胃经之合穴，配胃俞和胃之募穴——

中脘、小肠俞和小肠募穴——关元，其增加胃肠的蠕动功能。

随症选穴：食欲不振加梁门；暖气加天突；眩晕加风池；口苦加阳陵泉；倦怠加气海；心悸加内关；失眠加安眠穴。

肾盂肾炎

肾盂肾炎是由各种致病菌上行感染直接引起的肾脏肾盂部位的炎症。是一种较常见的尿路感染疾病。好发于女性，尤以育龄妇女为多见。其临床表现以腰痛、发热、尿急、尿频、尿痛等为主。有急性和慢性之分。急性肾盂肾炎起病急骤，伴高热、寒战、头痛、恶心、食欲不振等，查体可有上输尿管点或肋腰点压痛及肾区叩痛。如及时彻底治疗可痊愈。慢性肾盂肾炎多从急性迁延而来，常伴有乏力，低热，夜尿多等症状，泌尿系统症状不显著，查体可有肾区叩击痛。诊断与疗效判定应检验尿蛋白和沉渣。

本病属祖国医学“淋证”范畴。多因肾气亏虚或外阴不洁，秽浊之邪上犯膀胱酿成湿热；或过食肥甘、湿热内生下注膀胱；或心火下移小肠热迫膀胱；或郁怒伤肝、肝失疏泄、酿生湿热下注膀胱，使膀胱气化失司引起本病。

治疗处方：分两组，交替灸之。

1. 太溪、中极、水道、京门。
2. 委中、膀胱俞、肾俞、膈俞。

每日灸治 1 次，10 次为 1 疗程，疗程之间可休息 1—2 日，症状较重或急性肾盂肾炎，每日可灸治 2 次，疗程之间可不休息。

诸穴可用温和灸。若慢性肾盂肾炎，膈俞、肾俞、膀胱俞隔蒜灸或瘢痕灸则疗效更佳。

急性肾盂肾炎的治疗应配合抗菌药物。并嘱患者尽量多饮水。尿化验结果恢复正常后可停药，单施灸术 1—2 个疗程，以巩固治疗效果。

慢性肾盂肾炎的治疗，应坚持长时间治疗，最少也需 10 个疗程或更长时间。

说明：太溪为肾经原穴，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气；委中乃膀胱经合穴，配膀胱俞和膀胱之募穴——中极，以清膀胱之湿热；膈俞有抗炎作用；水道是治疗膀胱炎症之要穴。

随症选穴：发热加大椎、曲池；头痛加风池、太阳；恶心加内关、上脘；食欲不振加中脘、梁门。

单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿，是指主要以缺碘等原因所造成的代偿性甲状腺肿大的一种疾病。可分为地方性（见群体发病）和散发性两种，尤好发于女性。本病初起时甲状腺呈弥漫性肿大，质软，无自觉症状。久之则肿大明显，触之较硬，或有大小不等的结节，病情严重者可有声嘶、呼吸或吞咽困难等压迫症状。病程呈慢性过程，一般无甲状腺功能异常

表现。

本病属祖国医学中的“瘰病”范畴，是由于情志内伤，饮食及水土失宜，以致气滞、痰凝、血瘀壅结于颈前所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 阴陵泉、脾俞、膈俞、肺俞。
2. 尺泽、丰隆、章门、膻中、中府。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息3—5日，诸穴可用温和灸或隔姜灸，若肺俞、膈俞、脾俞采用隔蒜灸或癰痕灸，疗效更佳。一般需要坚持10个疗程以上的治疗。轻者可获痊愈，重者疗效明显，坚持灸治，亦可获痊愈，免受手术之苦。

说明：脾为生痰之器，取脾经合穴阴陵泉，配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾化痰；尺泽为肺经合穴，配肺俞和肺之募穴——中府，以宣肺化痰；膻中为气会，灸膻中以行气，气行则血行，而活血化瘀；丰隆为祛痰化痰要穴，以解“痰凝”；膈俞为血会，灸之以活血化瘀。据现代医学研究，膈俞穴有调节内分泌的作用，单纯性甲状腺肿属内分泌腺疾病。

随症选穴：若肿物较大，在其尖端每日灸5—10分钟（或灸2—3壮），切忌癰痕灸。声音嘶哑加廉泉；呼吸困难加天突。

甲状腺机能减退症

甲状腺机能减退症或称“甲减”、“甲状腺低功”。是由于多种原因致使甲状腺素分泌不足而引起的一种全身性疾病。是临床常见病多发病。中老年发病率较高，男女比例约为1:4—6。本病有先天性与后天性之分，先天性禀赋于父母，后天为营养不良、外伤、理化因素及其他病所导致。起病较缓，初起见倦怠乏力，畏寒少汗，头昏健忘，食少便秘等，久之则全身皮肤苍白或微黄而浮肿，面容虚肿，表情淡漠，反应迟钝，嗜睡懒言，耳鸣耳聋，心悸眩晕，腹胀厌食，男性阳痿、女性月经紊乱等。通过实验室检验摄¹³¹碘曲线低平或T₃、T₄的降低可确诊为本病。

本病属中医学的“水肿”与“虚劳”范畴，主要为先天肾阳不足，后天脾阳亏损，先天之本与后天之本俱虚，元气亏乏，气血不足，导致脏腑功能失调而发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、肾俞、脾俞、膈俞、水突。
2. 三阴交、关元、京门、章门、水突。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程之间休息3—7日，诸穴可用温和灸或隔姜灸。肾俞、脾俞、膈俞可隔蒜灸，若形成瘢痕，则疗效更佳。而水突穴则采取温和灸法，切忌形成瘢痕。

说明：太溪为肾经原穴，配肾俞和肾之募穴

——京门，以补肾阳，补充先天之本；三阴交为脾经要穴，配脾俞和脾之募穴——章门，以补脾阳，补充后天之本；关元穴处，为元气所在，灸之可大补元气。水突穴之皮下，为甲状腺所在，每日灸之，可促甲状腺素分泌增多。

随症选穴：嗜睡懒言加神门、百会；耳鸣加听会、翳风；心悸加内关；眩晕加风池；腹胀厌食加中脘、梁门。

甲状腺机能亢进

甲状腺机能亢进症，简称“甲亢”。是临床较常见的内分泌旺盛性疾病。是因自身免疫反应等因素致使甲状腺泡细胞分泌过多的相应激素而引起的。本病多见于20—45岁的中青年女性，男女患病比例约为1:4—6。临床以情绪易激动，心悸多汗、易饥多食、消瘦、手颤、甲状腺肿大，眼球突出为特征。本病起病缓慢，多数伴发于甲状腺肿，少数诱发于强烈的精神刺激。

甲亢亦属祖国医学中“瘰病”范畴，情志失调，饮食失宜，或卒感外邪等均可引起气郁痰结，气滞血瘀及肝郁化火伤阴等病理变化而导致本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 阴陵泉、脾俞、膈俞、肺俞。
2. 尺泽、丰隆、章门、膻中、中府。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息3—5日。灸法见单纯性甲状腺肿。

说明：脾为生痰之器，取脾经合穴阴陵泉，配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾化痰；尺泽为肺经合穴，配肺俞和肺之募穴——中府，宣肺化痰；膻中为气会，灸膻中以行气，气行则血行；丰隆为祛痰化痰要穴，以解“痰结”；膈俞为血会，灸之以活血化瘀。

随症选穴：心悸加心俞、巨阙；多汗加复溜；易饮多食加胃俞、中脘；消瘦加足三里；手颤加曲池；眼球突出加肝俞。（但肿大的甲状腺处禁灸）

糖尿病

糖尿病是一种常见的内分泌代谢紊乱性疾病，其病因的新学说认为：患者的自身免疫机制过强，侵犯了胰岛细胞，造成胰岛素分泌减少。该病的特征为血糖过高、糖尿、葡萄糖耐量减低。临床早期多无症状，病情发展后有典型的“三多一少”症状，即多饮、多食、多尿、消瘦，并伴有疲乏无力等。糖尿病患者常并发化脓性感染、肺结核、心血管病变、肾脏病、神经系统病变、眼病，严重时可发生酮症酸中毒、昏迷以致危及生命，是对人类健康危害较严重的一种疾病。本病可通过检验空腹血糖而确诊。

本病属中医学中的“消渴”范畴。一般把多饮症较突出者称为上消（属肺）；多食症较突出者称为中消（属胃）；多尿症较突出者称为下消（属肾）。是由饮食不节、情志失调，劳欲过度等使肺、

胃、肾功能受损，最终导致阴虚燥热发为本病。

治疗：处方分3组，根据病情用之。

1. 尺泽、中府、肺俞、膈俞、胰俞。
2. 足三里、胃俞、中脘、膈俞、胰俞。
3. 阴谷、肾俞、京门、膈俞、胰俞。

以烦渴多饮者采用第一组处方；以多食症状明显者采用第2组处方；以多尿症状明显者采用第3组处方；若具有“三多”症状，就3组处方交替用之，每日灸1次，10次为1疗程，疗程之间可休3—5日。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。膈俞、胰俞宜隔蒜灸。并形成瘢痕，则疗效更佳。每治疗9—10个疗程，可进行空腹血糖化验，以观察疗效。

糖尿病愈早治疗效果愈好。若有并发症，则应配合其他疗法。若有酮症酸中毒，则需住院治疗。

说明：中医认为“上消属肺”，所以取肺经合穴——尺泽，配肺俞和肺之募穴——中府；“中消属胃”，所以取胃经合穴——足三里，配胃俞和胃之募穴——中脘；“下消属肾”，所以取肾经合穴——阴谷、肾俞和肾之募穴——京门；现代医学认为糖尿病是内分泌代谢紊乱所致，而膈俞穴能调节内分泌，且又能调节免疫，而保护胰岛细胞；胰俞又主治胰腺疾病，而使胰岛细胞分泌功能加强以降低血糖。

随症选穴：若并发肺结核，除应用抗结核药物外，可加灸膏肓穴；若并发心血管疾病，可加心

翳、巨阙；并发眼底病变，可加光明、翳明。

面神经炎

面神经炎又称面瘫或颜面神经麻痹。是由面神经管及面神经的非化脓性炎症所致的一种急性周围性面瘫。可发生于任何年龄，但以青年为多见，男性比女性发病率高。本病无明显的季节性，起病急躁，患者自感患侧颜面板滞麻木，漱口流口水，食丸嵌在齿颊之间，有的患者耳后乳突处疼痛。患侧皮肤温度低于健侧，患侧额纹消失或变浅，蹙额试验阳性，眼睑闭合不全，鼻唇沟消失或变浅，人中沟歪向健侧，口角下垂。怒腮试验阳性，露齿试验阳性。因为症状明显不易被误诊。患病后若能及时治疗，一般均可痊愈。

本病的中医学名称较多，有“口眼歪斜”、“口僻”、“歪嘴风”、“吊线风”等。一般归属于“中风病”中的风中络脉。多由于正气不足，脉络空虚，卫外不固，风邪乘虚入中面部络脉，使面部气血阻痹，络脉失养，以致肌肉纵缓不收所致。

治疗：处方对侧合谷，患侧翳风，颊车，地仓、下关、颧髎、太阳、阳白。

每日灸治1—2次，10次为1疗程。疗程之间，可休息1日或不休息。采取温和灸或隔姜灸，切忌形成瘢痕。

灸治愈早效果愈好，不宜待1周病情稳定后才开始治疗。

说明：古代医家云：“面口合谷收”，所以治疗该病必需取合谷。因手阳明大肠经循行到面部则“左至右，右至左”而交叉，所以取对侧合谷。取患侧翳风、颊车等诸穴，均属局部取穴，以温通络脉，祛散风邪；并能提高患侧皮肤温度，以利于面瘫的康复。

随症选穴：若耳后乳突处痛加完骨。

肋间神经痛

肋间神经痛是指一根或数根肋间神经分布区域发生经常性疼痛，且有由呼吸、咳嗽等因素激发，或见发作性加剧等特点。是神经内科常见病之一，本病疼痛剧烈，多呈烧灼样疼痛，痛区往往呈带状多向肩背部放射。患者常因疼痛而寝食不宁、烦躁焦虑。检查可有相应皮肤区感觉过敏和相应肋骨边缘压痛。临床上原发性肋间神经痛较少见。继发者多与邻近脏器和组织的炎症，脊柱与肋骨的损伤，或异物压迫等有关。另外，髓外肿瘤和带状疱疹也是本病发生的原因。

中医学的“胁痛”包括了本病在内，因肝胆之脉循行于肋，故发病主要责于肝胆。凡肝气郁结、肝胆湿热，肝阴不足致其脉气血运行不畅，或胁络受伤瘀血停着，或气滞血瘀，胁络痹阻等，均可导致本病的发生。

治疗：处方太冲、丘墟、外关、肝俞、胆俞、期门、日月、阿是穴。

每日灸治 1—2 次，10 次为 1 疗程。疗程之间可休息 1—2 日，若病情较重可不休息。

肝俞、胆俞可隔蒜灸，若瘢痕灸，疗效则佳，其他诸穴可用温和灸或隔姜灸。

若是继发性肋间神经痛，必需对原发病进行治疗。

说明：太冲为肝经原穴，配肝俞和肝之募穴——期门，以疏通肝经经脉；丘墟为胆经原穴，配胆俞和胆之募穴——日月，以疏通胆经经脉。《六总穴歌》曰：“胁肋外关取”。故取外关，以治肋肋痛；阿是穴是疏通局部的经络，“通则不痛”。

随症选穴：发热加大椎、曲池；烦躁焦虑加内关；失眠加安眠穴。

多发性神经炎

多发性神经炎是以四肢软瘫为主要特征的神经系统疾病，又称末梢神经炎或周围性神经炎。多由感染、中毒、代谢障碍等原因所引起。发病以儿童和青壮年居多。本病的主要临床表现：早期有肢体远端对称性的麻木、烧灼或疼痛等感觉异常，继而则出现典型的手套及袜套样感觉减退或消失。以痛觉减退较明显。肢体远端呈弛缓性瘫痪，肌肉萎缩，腕、足呈下垂状。患处皮肤光滑、发凉、多汗或无汗、腱反射消失等。

中医学的“痿证”包括了本病在内。病因分内伤和外感两方面。内伤由脾胃虚弱，精微不输或肝

肾亏损，髓枯筋痿所致。外感则湿邪为患，湿热或寒湿之邪侵淫筋脉，气血运行不利，筋脉失于濡养发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 曲池、外关、合谷、膈俞、脾俞、胃俞。
2. 足三里、阳陵泉、阴陵泉、绝骨、太冲、太溪、章门、中脘。

患病初期：每日灸2次，10次为1疗程。疗程之间可休息1日或不休息。灸治3—4疗程后，可改每日灸治1次。可用温和灸法或隔姜灸；膈俞、脾俞、胃俞可隔蒜灸或瘢痕灸，疗效较佳。

说明：《内经》曰：“治痿者独取阳明”。根据古人的教导，故取手阳明经的曲池、合谷，足阳明经的足三里、解溪；取脾经合穴——阴陵泉、配脾俞和脾之募穴——章门，又取胃经合穴——足三里，配胃俞和胃之募穴——中脘，以健后天之本，增加水谷精微之运化。脾又主肌肉四肢，健脾能医肌肉之萎缩。取血会——膈俞以化血瘀；取肝经原穴——太冲，以补肝阴；取肾经原穴——太溪；以补肾阴；取髓会——绝骨、筋会——阳陵泉，以壮筋骨。

随症选穴：发热者加大椎，疼痛甚者可配合针刺疗法。

血管神经性头痛

血管神经性头痛指血管性头痛和神经性头痛，

是临床上最常见的自觉症状之一。见于多种以头痛为主症的急慢性疾病中。可包括有偏头痛、神经官能性头痛、颈椎病性头痛、枕神经痛、高血压性头痛、外伤性头痛等。上述头痛都具有病程较长，反复发作等特点，所以人们多将血管神经性头痛归为一类。而伴随症状则因不同性质的疾病而异。本病可发于任何年龄，疼痛可呈间歇性或持续性发作，疼痛性质有跳痛、胀痛、刺痛等。感受外邪，情志失调，过劳、久病等都是本病的诱发因素。

头痛在中医学中有“头风”、“脑风”、“首风”等名称。凡风、寒、湿、热等邪上犯脑络；情志不遂、肝郁化火、上扰清空；外伤、久病、气滞血瘀等，均可致脑部脉络痹阻不通，“不通则痛”，故发生头痛。

治疗：处方分4组，按病情取之。

1. 合谷、内庭、太阳、上星、头维、印堂等（治前头痛）。

2. 昆仑、后溪、天柱、风府、风池、玉枕等（治后头痛）。

3. 外关、绝骨、风池、率谷、头维、太阳等（治偏头痛）。

4. 太冲、百会、四神聪等（治巅顶痛）。

疼痛发作期，可每日灸2—3次，10次为1疗程，疗程间可不休息；待疼痛缓解，每日灸治1次，疗程间可休息1日；疼痛停止后，可隔日灸1次，继续2—3个疗程，以巩固疗效或以徒根治。

重灸远端腧穴，灸治时间宜长，头部腧穴宜温和灸或隔姜灸，灸治时间宜短。

说明：中医经络学说认为：前头痛属阳明头痛，后头痛属太阳头痛；偏头痛属少阳头痛；巅顶痛属厥阴头痛。所以前头痛需取手阳明经的合谷穴和足阳明经的内庭穴；偏头痛需取手少阳三焦经的外关穴和足少阳经的绝骨穴；巅顶痛取足厥阴经的太冲穴。其4处方中的头部腧穴，均可疏通脑部经络，“通则不痛”。

随症选穴：失眠者加安眠穴；心悸者加内关；血压高者加血压点。

神经衰弱

神经衰弱是神经官能症中最常见的病症之一。是因大脑皮质兴奋和抑制平衡失调而引起的一种神经机能性疾病。本病的临床表现复杂多样，几乎涉及所有的器官系统。患者往往感觉全身从头到脚都不舒服。如头晕、头痛、失眠、健忘、神疲肢倦、情绪易激动、善虑多疑、食少腹胀、手足不温、性功能减退、遗精等。体格检查和实验室检查均为阴性结果，其发病与精神因素关系最为密切。

本病的表现症状较多，一般包括在中医学的“心悸”、“不寐”、“郁证”、“虚劳”、“遗精”等病证中。多由于情志不舒，肝气郁结；思虑过度，劳伤心脾，神失所养；房事不节，肾精亏损等导致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太白、神门、巨阙、期门、章门。

2. 太冲、心俞、肝俞、脾俞。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息3—5日。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。若心俞、肝俞、脾俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更佳。

在治疗期间，劝患者去除真正的“病因”，保持心情舒畅，有利于早日康复。

说明：取脾经原穴——太白，配脾俞和脾之募穴——章门，再取心经原穴——神门，配心俞和心之募穴——巨阙，以补劳伤之心脾；取肝经原穴——太冲，配肝俞和肝之募穴——期门，以舒肝理气。

随症选穴：头晕头痛加风池、百会；失眠加安眠穴；健忘加四神聪；善虑多疑加内关；食少腹胀加中脘、梁门；性机能减退或遗精加太溪、肾俞、关元。

脑血管病后遗症

脑血管病，是脑部动脉病变引起局灶性血液循环障碍，导致急性或亚急性脑损害，从而表现出的神经系统疾病。临床又称脑血管意外。本病以突然发生的昏迷、肢体偏瘫、失语，为主要症状，部分患者可留有较严重的后遗症。脑血管病可分为出血性和缺血性两大类。前者包括脑出血和蛛网膜下腔出血；后者包括脑血栓形成和脑栓塞。患者发病前

多有高血压或低血压、动脉硬化等病史。是中老年常见的急性病之一。尤其是脑出血，病情凶险，病死率高，故本病是对人体生命健康危害较严重的一种疾病。应当引起人们的高度重视。另外，家族史、吸烟和饮酒过度，饮食偏嗜等，也是导致本病的危险因素。

脑血管病属中医学的“中风”范畴。又有“卒中”、“偏风”等名称。其发生，主要因素在于患者平素气血亏虚，心、肝、肾三脏功能失调，加之饮食不节，情志刺激、劳累纵欲等诱因，使脏腑阴阳失调，气血逆乱，阴亏于下，肝阳暴涨，阳化动风，挟痰挟火，横窜经络，蒙蔽清窍而形成了阴阳互不维系的危急证候。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 患侧肩髃、曲池、合谷、髀关、足三里、解溪。

2. 患侧风池、肩井、肩髃、天井、外关、环跳、风市、绝骨、丘墟。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休息1—2日。全部腧穴均可采用温和灸或隔姜灸。

在灸治期间，需配合患肢的功能锻炼，以利于患肢的康复。若能配合推拿和针刺，则疗效更佳。

说明：两组腧穴，绝大部分属患肢局部取穴。灸之，疏通经脉，气血运行通畅，有利于肢体运动的康复。风池、风市两穴，是祛风之要穴，故取穴。偏瘫一段时间出现废用性肌肉萎缩，所以又要

按痿证处理，故第1组处方是遵循《内经》教诲：“治痿独取阳明”，而取的阳明经穴。

随症选穴：口歪者加患侧颊车、地仓；舌强语謇或失语者加哑门、廉泉；血压高者加太冲、血压点。

阳 痿

阳痿是指成年男子阴茎不能勃起，或勃而不坚，影响正常性生活的一种性功能减退症。有功能性与器质性之分。功能性阳痿的患者占临床患者的90%左右，发病多与精神因素有关，并多有房事太过，或青年期有手淫史。临床表现除阴茎痿软不振或勃起难于完成性生活外，常伴有精神不振，失眠健忘，腰酸腿软，畏寒肢冷，头晕耳鸣等。器质性阳痿则多由性器官发育不全、外伤或其他疾病及药物所引起。以阴茎始终处于痿软状态，不能勃起为特征。

阳痿在中医学中曾有“阴痿”之称，或称“阴器不用”。凡房事过度，久犯手淫，使命门火衰；或惊恐伤肾，肾气虚弱；或思虑忧郁、劳伤心脾、气血两虚；或湿热下注，宗筋弛纵，均可导致阳痿。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、命门、肾俞、脾俞、心俞。
2. 太白、神门、关元、京门、章门、巨阙。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程间可休

息3—5日。诸穴均采取温和灸或隔姜灸。

在治疗期间，要树立治愈的信心。并要在3—5疗程内，禁房事为宜。

说明：取肾经原穴——太溪，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气；取脾经原穴——太白，配脾俞和脾之募穴——章门，再取心经原穴——神门，配心俞和心之募穴——巨阙，以医治劳伤之心脾；灸命门以益命门之火；灸关元以大补元气，元气足，命门火旺，阳痿可愈。

随症选穴：失眠加安眠穴；健忘加四神聪；膝软加足三里；头晕加风池、百会；耳鸣加翳风、听会。

遗 精

男子不因性生活而排泄精液，多在睡眠中发生，每周超过1次以上者称为遗精。是一种精液排泄异常的病证。一般于睡中有梦而遗者称“梦遗”；无梦而遗甚至清醒时，如劳累、欲念即精液流出者称“滑精”。前者较轻，后者较重。遗精频繁者多伴有头晕、耳鸣、腰膝酸软、神疲乏力等症。可见于神经衰弱和多种生殖泌尿系炎性疾病中。

中医学认为本病的发生是肾虚不固或邪扰精室所致。凡情志失调，心肾不交，君相火动精室被扰；或思虑过度，劳伤心脾，气不摄精；或湿热下注、热扰精室；或久病肾元虚惫，精关不固等，均可造成遗精。

治疗：参阅“阳痿”的治疗，仍以心肾、脾经穴为主，处方去命门加志室。

若志室、肾俞、脾俞、心俞隔蒜灸或瘢痕灸则疗效更佳。

治疗前，嘱未婚者戒手淫，已婚者在3—5疗程内禁房事，以提高和巩固疗效。

说明：根据中医理论，遗精主要是心肾脾三脏之病变，故取三经穴再配以俞募，以益心脾，交通心肾。志室又名精宫，取之以固精关。

随症选穴：亦同“阳痿”之随症选穴，若有神经衰弱之临床表现，可先治神经衰弱，并加志室穴；若泌尿生殖系统炎性疾病，先按“肾盂肾炎”治疗和按“前列腺炎”治疗，均加志室穴。

早 泄

早泄是指性交时间极短即排精，甚至性交前即泄精的病症。但必须在每次性交或大多数性交过程中常发生早泄，方可诊断为本病。早泄是一种较常见的男性性机能障碍的表现。因多见于神经衰弱患者，说明其发病与大脑皮层和脊髓性神经中枢功能紊乱有密切关系。此外，前列腺和泌尿器官炎症，也是造成早泄的原因。多数患者除早泄外，可伴有头晕、耳鸣、神疲乏力、腰酸膝软、记忆力减退等。

中医学认为本病的发生是因精液的封藏固摄失控造成的。多因思虑过度，劳伤心脾，虚则气陷；

或心有所欲，相火妄动；或惊恐，纵欲伤肾，肾气不固；或湿热下注，疏泄异常等，都可导致封藏失控，精关不固而发生早泄。

治疗：同“遗精”之治疗。因早泄之症主要是心、脾、肾三脏之病变致精关不固。

随症选穴：亦同“遗精”治疗的随症选穴。

前列腺炎

前列腺炎是以会阴坠胀疼痛、尿液常有前列腺液溢出为主要临床表现的疾病。是男性泌尿系统的常见病。以中青年男性为多见，有急性和慢性之分。前者往往继发于体内其他泌尿生殖系统的感染，以尿急、尿频、尿痛等膀胱刺激症状和终末血尿，会阴部、腰骶部及睾丸坠胀疼痛为主。后者为反复发作的慢性过程，以排尿延迟、尿后淋漓不尽、排尿或大便时尿道有白色精液溢出，且伴头晕、乏力、性欲减退、遗精、早泄、阳痿、不育等症为主。直肠指检可有前列腺肿大或结节，且有压痛。

本病大致归属中医学的“精浊”、“膏淋”等范畴，多由过食辛辣肥甘，损伤脾胃，酿生湿热，流注下焦；或房事不节，肾气亏虚，导致膀胱气化不利，波及精室而发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、膀胱俞、肾俞、脾俞、膈俞。
2. 三阴交、飞扬、中极、京门、章门。

急性前列腺炎，每日灸治2次，10次为1疗程。疗程间可休息1日或不休息。诸穴均用温和灸或隔姜灸，同时配合抗炎药物治疗。有尿频、尿急、尿痛等症状者要多饮水。

慢性前列腺炎，每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息3—5日。诸穴均可用温和灸或隔姜灸。若膈俞、脾俞、肾俞、膀胱俞用隔蒜灸或瘢痕灸则疗效更佳。

说明：取肾经原穴——太溪、配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气；取脾之要穴——三阴交（且有肾经相会于此），配脾俞和脾之募穴——章门，以利湿清热；取膀胱经络穴——飞扬，配膀胱俞和膀胱之募穴——中极，以利膀胱之气化。膈俞有抗炎作用，故取之。

随症选穴：参阅治疗“阳痿”之“随症选穴”。

前列腺肥大

前列腺肥大是以排尿困难和尿潴留为主要临床表现的一种常见的老年男性病。是由前列腺的良性增生梗阻尿道所造成。本病初起时表现为尿频，尤见夜尿次数增多，渐有排尿困难，余沥不尽；病情严重的可有尿频、尿细如线，甚至出现急性尿潴留或尿失禁。病人较痛苦。本病的病因目前尚不十分清楚，多认为与性激素平衡失调或体内其他内分泌失调有关。

前列腺肥大属中医学的“癃闭”范畴，多因老

年肾元亏虚；或下焦湿热等原因导致精室肿大，膀胱气化失司而发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、膀胱俞、肾俞、膈俞。
2. 飞扬、中极、京门、关元。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间可休息3—5日。诸穴均可采取温和灸或隔姜灸。若膀胱俞、肾俞、膈俞采用隔蒜灸或瘢痕灸则疗效更佳。

该病若早期发现，灸法治疗不仅能延缓病情发展，且能治愈。

说明：取肾经原穴——太溪，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气。取膀胱经络穴——飞扬，配膀胱俞和膀胱之募穴——中极，以利膀胱之气化和排尿。取膈俞以调节内分泌。取关元以补元气。

随症选穴：排尿困难或尿失禁加水道。

腓肠肌痉挛

腓肠肌痉挛，俗称“腿肚抽筋”，是临床较常见的伤筋病症。多为一侧小腿后外侧发生挛缩性疼痛为主要表现。常在夜间睡眠中伸展下肢时发生，或在剧烈运动时（如游泳、跑步等）发生。易反复发作，劳累和气候寒凉也是导致发作的诱因。发作较轻者经局部活动和柔按后可在数分钟内缓解，重者不易缓解，疼痛难忍，需经治疗方能解除。

本病的中医学名称为“转筋”。多由劳累过度，

耗伤气血，筋脉失养；或感受寒邪，寒凝筋脉，均可导致筋脉挛缩发生疼痛。

治疗：处方患侧委中、合阳、承筋、承山、足三里、阳陵泉、光明。

每日晚上灸治1次，或早晚各灸1次。10次为1疗程。诸穴均用温和灸或隔姜灸。青壮年1疗程可愈，老年人有2—3个疗程亦可愈。若配合推拿，则疗效更明显。

说明：本组处方均属局部取穴，以疏经活络，祛散寒邪，筋脉得养，痉挛则止。

随症选穴：若疲劳加灸双侧足三里、三阴交；若有压痛点明显者，可阿是穴灸之。

腰扭伤

腰扭伤又称损伤腰痛，是指腰部肌肉或软组织的损伤引起的以腰部的一侧或两侧疼痛，各方活动均受限为主的伤筋证候。发病率较高，多见于青壮年。本病的发生多为突然遭受间接或直接暴力所致。如过度负重时姿势不正；抬举重物时用力不当；剧烈运动时猛力转身；突然弯腰或扑闪等均可造成腰部肌纤维扭伤或断裂，骨节错缝，滑膜嵌顿发生腰痛。多数受伤者当时可有腰部闪断或撕脱感，伤腰部即出现剧烈疼痛、疼痛呈持续性，俯仰屈伸转侧困难，活动明显受限。患者常两手掌腰或保持一定强迫体位以减轻疼痛。查体时腰肌和臀肌痉挛，或可触及条索状硬物，局部压痛明显，脊柱

生理弧度改变。

本病多归属中医学的“腰部伤筋”、“腰痛”范畴，“腰为肾之府”，多为肾虚，腰府不健，复因劳力不当或跌扑闪挫使腰部筋脉受损，经气运行不畅，气海瘀滞于局部而发生腰痛。

治疗：处方委中、肾俞、气海俞、阿是穴。

每日灸1—3次，10次为1疗程。多在1个疗程内治愈。诸穴均采取温和灸或隔姜灸。若能配合推拿则疗效更快。并嘱患者，愈后再持重物或剧烈运动前，应做准备活动。

说明：古人在《四总穴歌》中指出：“腰背委中留”，故腰部疾病要取委中穴；腰扭伤者多为肾虚，腰府不健，故取肾俞，以补肾健腰。再则，肾俞和气海俞亦属局部取穴，疏通患处经络，以活血化瘀；阿是穴也是必取的，往往压痛最明显处也是气血瘀滞最甚处，灸之，则气血运行通畅，疼痛则止。

随症选穴：体弱肾虚者，常灸太溪、肾俞、京门、关元等穴。

风湿性关节炎

风湿性关节炎是以发于关节部位为主的结缔组织非细菌性炎症。是一种较常见的与A族乙型溶血性链球菌感染有关的免疫性疾病。以全身关节呈游走性红、肿、热、痛为主要临床表现。发病前多有扁桃体炎、咽炎等病史，或涉水淋雨及久居湿地

史。病变主要侵及四肢大关节，且多呈对称性，除走窜疼痛外，多伴重着、酸楚、麻木及关节屈伸不利，部分患者可有不同程度的发热、汗出或鼻衄，或皮肤出现环形红斑、结节性红斑等，一般于数日或数周后消退。但可反复出现。本病在儿童及青年中发病率最高，且常可使心脏受累，是对人体健康危害较重的一种疾病。

本病分“活动期”和“非活动期”。以发热、关节红肿，皮肤出现环形红斑或结节性红斑，血沉快，抗“O”高，心脏受累者等为活动期。不具备上述改变，只有关节痛者为非活动期。

风湿性关节炎在中医学中属于“痹证”范畴，主要因素体虚弱，正气不足，卫外不固；或涉水冒雨，久处潮湿；或气候骤变，冷热交错等，以致风寒湿热之邪乘虚侵袭人体，流注关节经络，使局部气血痹阻发为本病。其中以风气偏盛者为行痹；寒气偏盛者为痛痹；湿气偏盛者为着痹；素体阳盛，感邪后化热者为热痹。

治疗：处方风门、膈俞、脾俞。以下为患处取穴。肩关节：肩髃、肩髃、膈俞、肩前。肘关节：曲池、尺泽、小海、天井。腕关节：外关、阳池、腕骨、大陵。髋关节：环跳、居髃、承扶、髀关。膝关节：膝眼、梁丘、血海、阴陵泉、阳陵泉。踝关节：解溪、丘墟、照海、申脉、昆仑。

活动期：每日灸治1—2次，10次为1疗程，疗程间可休息1—2日。诸穴均可取温和灸或雀啄

灸或隔姜灸。若风门、膈俞、脾俞施瘢痕灸，则疗效更好。该期需卧床休息，再配合抗风湿药物治疗，康复较快，更不会遗留下风湿性心脏病（二尖瓣狭窄或关闭不全等）。

非活动期：每日或隔日灸治1次，10次为1疗程。疗程间休息3—5日。诸穴均可采取温和灸或雀啄灸或隔姜灸，以疼痛的关节周围腧穴为主，不必采用瘢痕灸。该期的治疗若配合推拿，拔火罐，则疗效更能提高。

说明：风门为祛散风寒之邪的要穴，故取之；膈俞为八会穴之一——血会，具有活血功效，“血活风自灭”，另外，据现代医学研究，该穴有调节免疫机制的功能，而本病又是免疫性疾病；脾俞有健脾渗湿之功，故以祛湿邪；其余诸穴均属局部取穴，疏通患处经络，气血痹阻得除。

随症选穴：发热加大椎、曲池；游走性关节痛加风市。

落 枕

落枕是以一侧颈项强直疼痛，活动受限为主要表现的一种病症。多见于20岁以上的成年人。呈急性发病，冬春两季多发。本病发生的原因多为睡眠时姿势不良，枕物过高或过低或过硬使颈部肌肉处于过度紧张状态，发生静力性损伤，也可因颈背部遭受风寒侵袭所导致。一般无外伤史。典型的临床表现是睡眠后突感一侧颈部疼痛、酸胀、转侧俯

仰受限，活动可使疼痛加剧，或痛向上肢和背部放射。严重者可使头部歪向患侧。查体：颈部肌肉痉挛压痛，肌紧张处触之如条索状或块状。患处喜热敷。一般症状较轻者三五日自愈，重者须经治疗方可恢复正常。若见反复发作，多与颈椎病有关。

本病的中医学名称有“失枕”、“项筋急”等，属颈部伤筋之候。多因睡卧不当、头颈过度偏转或外感风寒之邪均可导致颈部经络气血运行不畅，经气痹阻发生疼痛。

治疗：处方：患侧落枕穴、风门、天柱、肩中俞、肩井、天宗、阿是。

每日灸1—3次，10次为1疗程，大多数患者在1个疗程内治愈。如果配合推拿或拔火罐，则疗效更好。若经过1个疗程的治疗，未愈或症状不减轻重，要进一步检查，以排除“颈椎病”。

说明：落枕穴是治疗落枕的奇穴，效果佳；灸风门以祛散风寒之邪；天柱、肩中俞、肩井、天宗、阿是穴等，均属局部取穴，疏通经络，调和气血，祛散风寒。

随症选穴：若肩痛加肩髃，肩髃；若臂痛加曲池、外关。

颈椎病

颈椎病是因颈部活动频繁，积年劳损，导致颈椎骨质增生，颈项韧带钙化，颈椎间盘萎缩退化等改变，使颈部血管神经脊髓受到压迫或刺激所表现

的一组症候群，故又称颈椎综合征。临床较常见。本病多见于40岁以上中老年患者，多为长期从事低头工作所造成。少数因外伤而诱发。病呈慢性过程，主要临床表现是患者渐感一侧肩、臂、手的麻木或疼痛，颈部后仰或咳嗽等可使疼痛加重，劳累或睡卧姿势不良亦可使疼痛加重。部分患者有头晕、耳鸣、耳痛和握力减弱及肌肉萎缩而无颈部疼痛，严重者甚至出现下肢沉重，活动不灵，步态失稳和痉挛性瘫痪。检查时，病变颈椎棘突或患侧肩胛骨内上角常有压痛，或摸到条索状硬结，颈部僵硬，活动受限。临床多根据病变性质，损害部位和症状表现的不同，分为神经根型、椎动脉型、脊髓型、交感型等，以神经根型为多见。

颈椎病证候表现复杂，故可包括在中医学的“痹证”、“痿证”、“眩晕”、“项强”、“颈肩痛”等多种病证中。多因长期低头劳作、颈部慢性劳损；或颈部外伤，瘀血停积；或中年以后肝肾阴虚，筋骨懈惰；或风寒湿邪侵袭颈部等，均可造成局部气血运行不畅或痰瘀交阻，以致酿成本病。

治疗：处方大杼、大椎、崇骨、患侧天柱、百劳、阿是穴。

每日灸1次，症状较重时每日灸2次，10次为1疗程，疗程间可休息1—2日。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若配合颈椎牵引或推拿疗法，则疗效更佳。以上是神经根型的治疗。椎动脉型和交感型可取双侧膈穴。脊髓型应该手术治

疗。

说明：大杼为八会穴之一——骨会，灸之以治骨质增生，其余诸穴均属局部取穴，灸之以消除局部软组织水肿，减轻对神经根或椎动脉的压迫。

随症选穴：臂麻或臂痛加肩髃、曲池、外关；头晕加风府、风池、百会；耳鸣加听会、翳风。

肩关节周围炎

肩关节周围炎是肩关节囊和周围软组织退行性变所引起的一种炎性反应。以肩部疼痛，夜间为甚，肩关节功能活动障碍为主要特征。好发年龄在50岁左右，故又称“五十肩”。女性发病率高于男性，右肩多于左肩，体力劳动者多发，病变呈慢性过程。多因睡眠时肩部受凉而引起，少数因外伤而诱发。早期多为单侧或偶见双侧肩部酸痛，或窜痛至背部，得温痛减，遇寒痛增。逐渐疼痛加剧，肩关节活动严重受限。后期病变组织产生粘连，疼痛虽有减轻，但功能障碍加重，出现典型的“扛肩”现象，严重影响患者的工作和正常生活。本病病程较长，少则数月，多则可达1—2年。

据近几年的研究，认为本病与颈椎的骨质增生（颈椎病）有关。所以本病应称“颈肩综合征”。

本病的中医学名称较多，有“漏肩风”、“肩凝证”，“冻结肩”等。多因五旬之人，肾气不足，气血渐亏，血不荣筋，加之长期劳损或外伤筋骨，又因睡卧露肩受凉，寒凝筋膜，使局部气血痹阻而引

起本病。

治疗：处方大杼、大椎、崇骨、患侧天柱、肩前、肩髃、肩髃、臑俞、阿是穴。

每日灸治1—2次，10次为1疗程，疗程之间可休1—2日。若症状较重，疗程间亦可不休息。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。本病若配合推拿和颈椎牵引，疗效更佳。在治疗期间，要嘱患者注意肩关节的功能锻炼。

说明：因本病与颈椎病有关，故取大杼、大椎、崇骨、天柱等穴，灸之以治疗颈椎病。其余诸穴均属局部取穴，疏通肩关节局部之经络，气血通畅，炎症消退，粘连松解，肩关节才能活动自如。

随症选穴：若臂痛加曲池、外关；失眠加神门、安眠穴。

肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎亦称肱骨外髁骨膜炎，多由长期劳累或前臂旋转用力不当，使伸腕肌起点反复受到牵拉刺激，引起部分撕裂和慢性炎症所导致。属劳损为主的病变。因多见于砖瓦工、网球运动员等从事特殊职业的人，故俗称“网球肘”。本病的症状特点是肘外侧疼痛，疼痛呈持续渐进性发展，用力握拳和前臂旋转（如作拧衣服、扫地、端壶倒水等动作）时，疼痛加重，患者常因疼痛而致前臂无力，握力减弱，甚至持物落地。休息时疼痛明显减轻或消失，查体肘外侧压痛，尤以肱骨外上髁处压

痛明显。

本病在中医伤科学中属“肘部伤筋”范畴，凡外力损伤或长期劳损，均可导致肘部筋膜受损，使局部经络气血运行不畅，气滞血瘀发生疼痛。

治疗：处方患侧曲池、手三里、天井、尺泽、阿是穴。

每日灸1—2次，10次为1疗程，疗程间休息2—3日。疼痛较重时，可不休息。诸穴均用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。治疗期间，配合自我推拿，则效果更佳。

说明：本组处方均属局部取穴，疏通患处经络，气血通畅，疼痛消除。

随症选穴：前臂无力加外关；握力减弱加合谷。

慢性阑尾炎

慢性阑尾炎是急性阑尾炎经非手术治疗后病势消退或自行痊愈后，炎症未能完全消失，转变而来的。且常可促使急性炎症的多次复发。青壮年发病率较高，男性多于女性。其主要临床表现是反复发作的右下腹疼痛，一般为轻度疼痛或持续性隐痛，急性发作时可有持续性胀痛或阵发性加剧。常伴有上腹部不适，腹胀、吞酸、便秘或腹泻等。体格检查可有右下腹局限性压痛。剧烈运动、远行劳累、过久负重或饮食不慎等都是诱发本病或使之加重的原因。

慢性阑尾炎在中医学中可归属于“肠痈”或“腹痛”范畴。多因饮食不节、蛔虫积聚、感染邪毒等使肠道湿热内阻、气机痞塞、瘀血停聚、败血浊气壅遏于阑门而成。

治疗：处方阑尾穴、膈俞、大肠俞、天枢、大横、阿是穴。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息2—3日。若急性发作，疼痛加剧时，每日可灸2—4次，不分疗程。待疼痛和右下腹局限性压痛消失及化验白细胞正常后，再灸2—3个疗程，以巩固疗效。全部腧穴可用温和灸或隔姜灸，若膈俞和大肠俞用瘢痕灸，则疗效更佳。

本疗法适应于失去外科手术机会者和手术禁忌者，因为普外科专家认为，本病若适应于手术者，还是手术根治为好。

说明：阑尾穴是治疗阑尾炎的奇穴，故取之；膈俞穴据现代医学研究，具有抗炎作用；阑尾炎属大肠病变，故取大肠俞和大肠之募穴——天枢；大横有通里以泻肠道湿热之作用；阿是穴具有止痛功效。

随症选穴：腹胀者加梁门、气海；吞酸加上脘；便秘加支沟；腹泻加上巨虚。

血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎是发于肢体末端的一种动脉的节段性，周期性加剧的炎症病变。多见于下肢的

一侧。患者大多为 25—50 岁的男性。且可有受冷冻、潮湿、长期吸烟、外伤、劳累、感染、中毒等病史。典型的症状表现是初起患肢末端冷痛，足部和小腿酸麻胀痛，行走时加重，休息则减轻，呈间歇性跛行，足背动脉搏动减弱，小腿可伴有浅静脉炎。继则患肢疼痛呈持续性，尤以夜间为重，肢端皮温明显降低，卧位时将患肢抬高，皮肤可呈苍白色；下垂时皮肤则呈暗红或青紫色。患肢皮肤干燥、汗毛脱落、趾甲变形增厚、肌肉萎缩、足背动脉和胫后动脉搏动逐渐消失。晚期患肢发生干性坏死，患者往往因疼痛剧烈抱膝而坐，彻夜不眠。如溃烂处并发感染时出现湿性坏死，肢端红肿热痛，并可出现发热等全身症状。本病在北方地区较多见。

血栓闭塞性脉管炎在中医学中属“脱疽”范畴，多因先天不足，正气虚弱，复感寒湿之邪导致脉络瘀阻，气血不畅，甚至痹阻不通而发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 委中、承山、阴陵泉、膈俞、肾俞。
2. 足三里、三阴交、太渊、冲阳、八风、关元。

以上诸穴除太渊、膈俞、肾俞、关元外，其余均是患侧取穴。

每日灸 1—2 次，10 次为 1 疗程。疗程间可休息 1—2 日，疼痛甚时亦可不休息，并且可随时灸患侧腧穴。诸穴均可取温和灸或雀啄灸或隔姜灸。

膈俞、肾俞、关元若瘢痕灸，则疗效更好。但太渊、冲阳两穴灸时切莫引起烧伤，一旦形成“水泡”，要妥善处理，防止感染、化脓，因为腧穴下面有桡动脉和足背动脉血管通过。并劝患者戒烟。

该病的治疗，越早越好。若配合抗血栓药物治疗，疗效更好。一旦出现足趾皮肤呈青紫色，已不是灸法的适应症了。

说明：取肾俞和关元，以扶正气；膈俞为八会之一——血会，具有活血化瘀之功效。据现代医学研究，膈俞具有抗炎作用；太渊为八会穴之一——脉会，“脉管炎”必取之；其余诸穴均属局部取穴，以疏通经络，气血流畅。

随症选穴：失眠加内关、安眠穴；发热加大椎、曲池。

痛 经

痛经是一种自觉症状，是妇女在经期中或行经前后呈周期性的发生小腹疼痛或其他不适，以致影响生活和劳动为特征的一种月经病。又称行经腹痛。是青年妇女常见病之一，尤多见于未婚女子。临床有原发性和继发性之分。原发性又为功能性，是指月经初潮即有小腹痛。其发生与精神因素、内分泌失调、子宫位置不正或子宫发育不良有关。继发性者月经初潮时无症状，以后由其他因素影响而逐渐发病。多与盆腔内生殖器官的炎症或其他病变（如子宫内膜异位、肿瘤等）有关。痛经的主要临

床表现是经期中或行经前后小腹胀痛或刺痛，往上痛及腰骶部，可伴有恶心、呕吐或其他不适。痛剧时可导致昏厥、疼痛可持续几小时或几天，呈周期性发作。

中医学认为发生痛经的主要原因是气血运行不畅，冲任受阻所致。凡情志失调、肝郁气滞、血行受阻；或肝郁日久化热，血热互结，血行不畅；或六淫为害，客于胞宫；或素体虚弱，大病久病之后气血两虚，血海不足胞脉失养等，均可导致经血滞于胞宫，血行不畅而发生本病。即所谓“不通则痛”。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、关元俞、肾俞、肝俞。
2. 足三里、阴交、关元、京门、期门。

每日灸1次，10日为1个疗程，疗程间休息1—2日。疼痛甚时，每日灸2—3次，可不分疗程。在月经来潮前7—10日开始灸治，疗效好。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。原发性痛经患者2—4个疗程可治愈。继发性痛经患者、需增加疗程。最好能在肝俞、肾俞、关元俞施瘢痕灸。

在治疗期间，应避免过劳、受凉和过食生冷等。

说明：三阴交主治肝、肾、脾三经疾病，配肝俞和肝之募穴，以舒肝理气；配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾精；取关元和关元俞，以补元气；痛经患者多为小腹痛，古人云：“肚腹三里

求”，故取之。阴交为任脉和冲脉之交会穴，灸之以通冲任，气血通畅，则“通则不痛”。

随症选穴：腹痛甚者加归来；恶心呕吐者加内关，上脘；体弱者加血海。

月经不调

月经不调是指以月经的期、量、质发生异常为主的月经病。是妇科常见病之一。月经不调的临床表现复杂不一，一般以月经周期提前7日以上，甚至半月余一行，连续两次以上者称月经先期。月经延后7日以上而至，甚至40—50日一行，连续两个周期以上者称为月经后期。月经周期或前或后，均逾7日以上，并连续两个周期以上者，称月经先后无定期。月经周期基本正常，但行经时间超过7日，甚至淋漓半月方净者为经期延长。月经周期基本正常，经量明显增多在50毫升以上，或时间超过7日者称月经过多。月经周期正常，经量很少不足30毫升，经期不足2日，甚或点滴即净者称月经过少。

中医学认为本病多由感受外邪，或内伤七情，或房劳多产等损伤冲任二脉所致。体弱气虚不固或热扰冲任，血海不宁，可致月经先期。营血虚少或阳虚寒凝，冲任不畅，可致月经后期。阴虚内热或气虚血热使冲任不固，或瘀血内阻，血不归经等可致经期延长，或月经过多。精血不足，血海不盈或痰瘀阻滞，血行不畅可致月经过少。

治疗：处方分两组，交替灸之。并请注意“随症选穴”的应用。

1. 三阴交、肾俞。

2. 血海、阴交。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间休息2—3日。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。肾俞、阴交若能用瘢痕灸，疗效更佳。

说明：三阴交和血海均为调经要穴，故取之。中医认为：妇女月经受肾经、冲脉、任脉所调节，而阴交是任脉和冲脉所会之穴，故取肾俞、阴交以调节肾经和冲任二脉。

随症选穴：月经先期加太冲、曲池；月经后期加膈俞、脾俞；月经先后不定期加太溪、关元；经期延长者加照海、中极；月经过多者加交信、气海；月经过少者加地机、脾俞。

白带增多症

白带是妇女阴道内流出的一种白色透明分泌物，如涕如唾，属正常生理现象。如果白带量多，且发生了色、质、气味的异常改变，则视为白带增多症。本病的临床表现是带下量多，绵绵不绝；或量虽不多，但色黄或赤，或青绿如浊涕，质稠浊或清稀如水，气味可腥秽或恶臭。常可伴有腰腹酸痛，头晕耳鸣，乳胁胀痛，或外阴灼热瘙痒等。其发生多与阴道子宫颈等炎症性疾病。长期异物刺激或身体虚弱有关。已婚妇女较为多见。

本病属中医学的“带下病”范畴，多由肝郁脾虚，湿热下注，湿邪影响冲任；或肾气不足、下元亏虚，带脉失约；或房事不洁，感染邪毒等所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、肝俞、脾俞、肾俞、带脉。
2. 足三里、期门、章门、京门、关元。

每日灸治1次，10次为1疗程。疗程间休息2—3日。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若肝俞、脾俞、肾俞采用隔蒜灸或癰疽灸，则疗效更佳。若带下色或黄或赤或青绿或有腥臭味，应该先请妇科医生诊治，特别是50岁以上的妇女，更应注意，以排除子宫恶性病变。若是阴道、子宫颈等炎症所致，配合局部抗炎治疗，则效果更佳。

说明：中医认为白带增多主要是由于肝、脾、肾三脏病变所致，故取肝、脾、肾三经的交会穴——三阴交，配肝俞和肝之募穴——期门，以舒肝理气；配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾、利湿、清热；配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气；取带脉穴，以恢复带脉的“固摄”作用，则带下病可康复；足三里、关元以补元气。

随症选穴：头晕加风池、百会；耳鸣加听会、翳风；外阴瘙痒加曲骨；若有炎症加膈俞。

盆腔炎

盆腔炎是女性盆腔生殖器官炎症的总称。包括子宫炎、输卵管、卵巢炎、盆腔结缔组织炎等。是

妇科生殖系统常见病之一。盆腔炎的发生，多由分娩、人流、输卵管通气或其他妇科手术中无菌操作不严格，使细菌从阴道上行感染或经淋巴、血行播散所致。感染常同时累及盆腔多个器官，但多有某一器官受累较重。一般开始为急性发作，主要表现为恶寒、发热、腹痛、白带增多及月经失调等。查体有腹膜刺激症状。如治疗不彻底，或患者体质较差，则可转为慢性，主要表现为下腹坠胀、钝痛、腰骶酸痛，白带增多，月经不规律，痛经或导致继发性不孕。查体子宫活动度受限，输卵管增粗或有囊性物、压痛等。慢性盆腔炎又可在某种诱因下反复急性发作。

本病的中医学归属较复杂，可散见于“腹痛”、“症瘕”、“痛经”、“带下病”等多种病证中。多因产褥期、经期房事或房事不洁等感染邪毒；或过劳、久病、正气不足时，湿热之邪乘虚入侵，毒邪侵袭胞脉所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、膈俞、肾俞、次髎。
2. 足三里、气海、京门、子宫。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息3—5日。急性盆腔炎可每日灸2—3次，不分疗程。诸穴均可用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若膈俞、肾俞能采用隔蒜灸或瘢痕灸则疗效更好。

急性盆腔炎时期，除灸治外，应请妇科医生配合抗炎药物，并应彻底治疗，以防止转为慢性盆腔

炎。

说明：中医所说的肾脏，不仅是泌尿系统，还包括生殖系统。盆腔炎属生殖系统疾病，故取肾经原穴——太溪，配肾俞和胃之募穴——京门，补肾精，扶正气，以祛湿热之毒；膈俞具有抗炎作用；次髎、子宫均是治疗妇科疾病之要穴；足三里配气海，不仅止腹痛，也有扶正气之功效。

随症选穴：发热加大椎、曲池；白带多加带脉；痛经加血海、归来。

乳腺增生病

乳腺增生病是中青年妇女的常见病、多发病。是指乳腺间质的良性增生。可分为单纯性乳腺增生和乳腺囊性增生两种。前者表现为腺管周围的纤维组织增生，或腺小叶实质增生，或腺上皮轻度增生。后者表现为腺上皮的乳头样增生，增生的上皮处腺管扩张或形成囊肿。本病多见于20—40岁的妇女。其发病与卵巢功能失调有关。临床表现是，多在乳房的外上象限有一扁平肿块，扣之有多个豆粒大小的韧硬结节，或有囊性感，肿块边界欠清，与周围组织不粘连，有触痛。乳房时有胀痛，每随喜怒而消长或随月经周期而呈发作性。患者多伴有胸胁胀闷、善郁易怒、心烦口苦、失眠多梦、神疲乏力、月经周期不准等。

本病相当于中医学所说的“乳癖”。情志内伤，肝气郁结，可影响脾肺功能，聚湿生痰，痰瘀凝结

乳络则发生本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、肺俞、膈俞、肝俞、脾俞。

2. 尺泽、中府、丰隆、期门、章门。

每日灸1次，10次为1疗程，疗程间休息2—3日。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若肺俞、膈俞、肝俞、脾俞施瘢痕灸，则疗效更佳。

说明：三阴交为脾、肝、肾经相交之处，主治三经病证，配肝俞和肝之募穴——期门，以舒肝理气；中医认为“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”，三阴交配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾化湿；取肺经合穴——尺泽、配肺俞和肺之募穴——中府，以宣肺化痰；胃经络穴——丰隆，以祛痰化痰；膈俞能调节内分泌腺的功能。

随症选穴：如果经期乳房胀痛，在月经来潮前10日加灸膺窗；心烦胸闷加内关；胁胀加外关；失眠多梦加安眠穴；月经周期不准加肾俞、关元。

更年期综合征

更年期综合征是指男女自生理机能和性机能的旺盛期后逐渐过渡到老年衰退期而出现的一组以植物神经功能失调为主的症候群。由于男女生理发育不同，或同性之间的个体生长、智力发育及生活环境的差异，更年期到来的时间和症状表现也有很大差别。由于生理上的原因，女性在更年期所表现的症状较为明显，临床多见。我国女子更年期大约在

45—55岁之间。而更年期综合征是在妇女绝经前后出现的。主要表现为月经紊乱，烘热汗出，潮热面红，情绪激动、心烦多疑、失眠健忘、性欲减退、皮肤感觉异常，倦怠乏力，纳少便溏、腰酸尿频、甚或精神异常等。持续时间或长或短，短者半年到一年，长者可延续数年。

本病在中医学中属“脏躁”、“绝经前后诸证”等范畴。主要因年界五旬，肾气渐衰、天癸将竭、精血不足、冲任亏虚；及脏腑功能渐弱等使体内阴阳失去平衡所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太溪、肾俞、肝俞、膈俞。
2. 太冲、京门、期门、阴交。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息2—3日。症状较重者可每日灸2次，10次为1疗程，疗程间可休息1日或不休息，待症状减轻后，再改为每日灸治1次。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。症状较重者，膈俞、肝俞、肾俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更佳。

说明：取肾经原穴——太溪、配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾精；肾藏精肝藏血，“肝肾同源”，精血互生，故取肝经原穴——太冲、配肝俞和肝之募穴——期门以灸之；膈俞为八会穴之一——血会，能补血，血足则精足。再者，膈俞有调节内分泌的作用。

随症选穴：烘热加涌泉；潮热面红加阴郄；失

眠加安眠；健忘加风池、百会；纳少便溏加中脘、天枢；尿频加中极。

小儿腹泻

小儿腹泻亦称小儿消化不良或婴幼儿腹泻。是儿科最常见的一组消化道综合征。多见于2岁以下婴幼儿，年龄愈小，发病率愈高。本病一年四季均可发生，但以夏秋季节最为多见，每当饮食不洁，或喂养不当，内伤乳食，或感染细菌病毒等，均可导致脾胃功能障碍发生腹泻。主要临床表现有大便次数增多，每日3—5次，或多达10次以上。粪便呈淡黄色如蛋花汤样，或色褐臭秽，带不消化乳食及少量粘液，患儿可伴恶心、呕吐、腹痛、发热、口渴等症。若患儿因吐泻较重，除有发热烦渴外，可见尿少，精神萎靡、或烦躁不安、皮肤干瘪、囟门凹陷、啼哭无泪、口唇樱红、腹胀、惊厥、脱水、酸碱平衡失调及电解质紊乱征象，诊断为中毒性消化不良，若不及时抢救，可危及生命。若单纯性消化不良，病久不愈，可导致营养不良，影响小儿生长发育。

本病的中医学名称有“泄泻”、“濡泻”、“飧泄”、“洞泻”、“慢脾风”等。小儿脾胃薄弱，无论感受外邪，内伤乳食，或脾肾虚寒等均可导致脾胃运化功能失调，使水谷不化，精微不布，清浊不分，合污而下，遂成泄泻。日久不愈，常可导致疳证。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、脾俞、胃俞。
2. 足三里、章门、中脘、天枢。

每日灸治 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间休息 1—2 日。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。小儿皮肤娇嫩，切忌烧伤皮肤。若能配合针刺疗法或捏脊疗法，则疗效更好。在治疗期间，患儿进食易消化的食物，更不能进食过饱。这一点，就是患儿被治愈后也应注意。

若有中毒性消化不良的临床表现，必须去医院进行纠正水和电解质的平衡的抢救，否则可危及患儿的生命。

说明：取脾经要穴——三阴交，配脾俞和脾之募穴——章门，再取胃经合穴——足三里、配胃俞和胃之募穴——中脘，以恢复脾胃的运化功能；天枢为大肠之募穴，是治疗腹泻的要穴，故取之。

随症选穴：呕吐加内关、上脘；发热加大椎、曲池。

小儿厌食症

小儿厌食症是指小儿长期食欲减退，甚至消失的疾病。是较常见的小儿消化功能紊乱的病症。主要临床表现是小儿较长时期的见食不贪，不欲进食，甚至拒食。常伴有面色少华，形体偏瘦，多食或迫食后恶心呕吐，但精神尚好，无腹胀，且无其他疾病。本病多见于 1—6 岁儿童，多因小儿饮食

不知节制，或家长喂养不当，如进食无定时定量，或过食生冷、甘肥厚味，或贪吃零食，或长期偏食等造成脾胃的消化功能减退，如果长期不得改善，可导致严重的营养不良和体力衰弱。

本病在中医学中亦称“纳呆”、“不欲食”、“不能食”等。小儿时期“脾常不足”如平素饮食不节，或喂养不当，或长期偏食等皆可导致脾失健运，胃不思纳，脾胃不和，导致纳呆。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 阴陵泉、脾俞、胃俞。
2. 足三里、章门、中脘。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休息2—3日。诸穴均可用温和灸或隔姜灸。小儿皮肤娇嫩，切忌烧伤皮肤。若能配合捏脊疗法，则疗效更好。

说明：取脾经合穴——阴陵泉、配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾；取胃经合穴——足三里、配胃俞和胃之募穴——中脘，以和胃。脾健运、胃腑和、消化机能好，食欲就会增加。

青光眼

青光眼是以眼球变硬，瞳孔散大不收，瞳色淡绿，视力严重减退为主要特征的眼科疾病。是较常见的致盲性眼病。其病因较复杂，临床常见的有闭角型青光眼和开角型青光眼，二者均为房水循环障碍所致。精神因素和过劳是发病的诱因。一般闭角

型青光眼发病急剧，为房角关闭，房水外流途径被骤然切断所致。好发于40岁以上的女性。主要临床表现有剧烈的头痛、眼胀欲脱、视力锐减或仅存指数视力，瞳孔散大，展缩失灵，角膜变绿，呈雾状混浊且有水肿，有睫状充血或混合充血，全身可伴见恶心呕吐，恶寒发热等。指扣眼球胀硬如石，检测眼底、眼压及视野可确定诊断。救治及时视力尚能恢复，若转入慢性，仍可因情志、劳累等导致急性发作。开角型青光眼病势相对较缓，为房水排出道变性所致。发病以20—40岁的男性略多见。起病初期多无明显不适，或仅有轻微的眼胀、头痛。以后眼球逐渐变硬，瞳色淡绿微混，可有雾视、虹视。病情严重时中心视力减退、视野高度缺损。最终也可导致盲无所见。

本病在中医学中分属于“绿风内障”和“青风内障”。凡肝胆火盛，热极生风，风火攻目；或暴怒忿郁，气郁化火上逆；或脾湿生痰，痰郁化火，痰火升扰；或劳神太过，真阴暗耗，水不涵木，风火炎上；或脾胃虚寒，饮邪上犯等，均可导致气血失和，经脉不利，目中玄府闭塞，神水瘀积，不能流通，酿成本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 光明、肝俞、胆俞、翳明、太阳。
2. 太冲、期门、日月、阳白、四白。

翳明、太阳、阳白、四白等穴，只患侧取之，余者均双侧取之。每日灸治1次，10次为1疗程，

疗程间休息 3—5 日，诸穴均采用温和灸或隔姜灸。阳白、四白灸治时，切忌烧伤眼睛。肝俞、胆俞若采用隔蒜灸或癰痕灸，则效果更好。灸法对闭角型青光眼，不仅可以防止急性发作，且可以治愈；对开角型青光眼，可以防止病情发展。

在治疗期间和治愈以后，嘱患者避免在光线不足的环境里用视力。

说明：中医认为“肝开窍于目”，“肝胆火盛，热极生风，风火反目”而发“青风内障”。故取肝经原穴——太冲，配肝俞和肝之募穴——期门，再取胆经络穴——光明、配胆俞和胆之募穴——日月，以清肝胆之火。且光明穴是治疗眼疾的要穴，灸之能致眼睛“光明”。翳明穴是治疗眼病效果较好的经外奇穴，故取之。太阳、阳白、四白等均是局部取穴，疏通眼部经络，启闭目中玄府，神水得以流通，本病才能治愈。

随症选穴：恶寒发热加大椎、曲池、合谷；恶心、呕吐加内关、上脘。

视神经萎缩

视神经萎缩是以患眼外观如常，而视力渐降，终至失明为特点的一种危重眼病。是因视神经纤维受到各种损害后发生变性和传导功能障碍而导致的退行性病变。典型的临床表现是单眼或双眼视力逐渐下降，直至不辨人物，甚至不分明暗，而外眼轮廓端好无异常。眼底检查可见视神经乳头色淡或苍

白，边界清楚或模糊，血管正常或变细；视野检查中心暗点或缺损。瞳孔直接对光反应迟钝或消失。本病的病因较复杂，可由视网膜色素变性、视网膜炎、视神经炎、青光眼日久失治演变而来。亦可由其他全身性疾病，或头、眼部外伤等引起。部分患者与遗传因素有关。

本病在中医学中属“青盲”范畴，凡肝肾两虚或禀赋不足、精血虚少、不得荣目；或情志不遂，肝气不舒、玄府郁闭；或头眼外伤、脉道瘀阻、玄府闭塞等，均可导致神光渐失，最终神光泯灭。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太冲、肝俞、肾俞、翳明、太阳。

2. 太溪、期门、京门、阳白、四白。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间休息1—3日。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。四白、阳白在灸治时，必须注意切莫烧伤患者眼睛。若肝俞、肾俞能用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效好。若能配合针刺疗法，效果更好。

本病应早期治疗，如果视力下降至不辨人物时，就很难治愈。

说明：肝肾两虚、精血虚少、目不得荣，才罹患本病，所以取肝经原穴——太冲、配肝俞和肝之募穴——期门，再取肾经原穴——太溪，配肾俞和肾之募穴——京门，以补肝肾；翳明是医治眼病疗效较好的奇穴；太阳、阳白、四白等，均为局部取穴，以疏通眼部经络、玄府通畅、神光得以恢复。

随症选穴：若有视网膜炎、视神经炎加膈俞；若有青光眼加光明、胆俞。

过敏性鼻炎

过敏性鼻炎亦称变应性鼻炎，是以突然和反复发作的鼻塞、连续性喷嚏为特征的一种鼻病。主要由鼻粘膜的过敏反应所导致。典型的临床表现是呈突发性的鼻痒、喷嚏频作、流涕清稀量多、鼻塞、下鼻甲粘膜淡白肿胀，可伴有发热恶寒，嗅觉失灵、眼痒、咽喉痒等症。本病起病急，症状消失也快，一般持续数分钟或数十分钟，间歇期无喷嚏及鼻塞。常反复发作，且病程较长，亦可并发荨麻疹、哮喘等病。过敏性鼻炎可发作于任何年龄，尤其以青年为多见。多因接触花粉、烟尘、化学气体等致敏物质而发病。气候的冷热变化也是主要诱发因素。是自身免疫机制过强的一种疾病。

本病属中医学的“鼻鼈”范畴，其发病主要与肺、肾两脏功能失调有关。鼻为肺窍，如肺气虚；或肾气虚，可使风寒之邪乘虚而入，犯及鼻窍、邪正相搏、肺气不得通调、津液停聚、鼻塞壅塞而发生本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 尺泽、中府、京门、迎香、印堂。
2. 太溪、肺俞、肾俞、膈俞、上迎香、上星。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息3—5日。病情发作时，可随时灸治，此刻灸治，

效果亦好。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。灸印堂、上迎香时，注意保护眼睛，以防烧伤。若肺俞、膈俞、肾俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更佳。

说明：肺开窍于鼻，所以取肺经合穴——尺泽、配肺俞和肺之募穴——中府，以补肺气，肺气不虚、鼻窍通畅，本病除矣；取肾经原穴——太溪、配肾俞和肾之募穴——京门，以补肾气，阻挡风寒之邪乘虚而入；膈俞穴具有调节免疫机制的功能，且有消炎作用；迎香、上迎香、印堂、上星，均属局部取穴，使鼻窍得以通畅，才能“迎香”。

随症选穴：伴有荨麻疹者加曲池、风门；伴有哮喘加定喘。

慢性咽炎

慢性咽炎是以咽部不适，咽粘膜肿胀或萎缩为特征的慢性咽病。是咽部粘膜、淋巴组织及粘液腺的慢性炎症表现。多为急性咽炎反复发作转化而来；或因鼻塞而长期张口呼吸；嗜食辛辣，吸烟或饮酒过度，环境空气干燥，粉尘及化学气体刺激等导致发病。本病病程较长，咽部不适症状时轻时重。主要表现为咽部干燥，微痛或痒，或异物感，紧胀感等。常有“吭咯”动作。可伴有咳嗽（因咽痒引起），恶心（咽部受刺激）、干呕、口渴喜饮等。症状多于早晨较轻，午后及入夜加重。此外，受凉、劳累、多言等亦可使症状加重。咽部检查粘

膜肿胀或有萎缩，或有暗红色充血多呈斑状块或树枝状。咽后壁淋巴滤泡增生。少数病人悬雍垂肥厚增大。

本病在中医学中属“虚火喉痹”或“珠帘喉痹”范畴。多因肺肾阴虚，津液不足，虚火上炎，熏蒸咽部；或感受外邪、邪滞于咽等，均可使咽部气郁不舒，酿成本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 列缺、中府、京门、天容、廉泉。
2. 太溪、肺俞、肾俞、膈俞、天容。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程之间休息2—3日。若有痛感时，可每日灸治2次。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。肺俞、膈俞、肾俞若采用隔蒜灸，则疗效更佳。

本病在治疗期间和治愈之后，吸烟者必须戒烟，饮酒者亦应戒掉。保持室内的湿度，防止粉尘和化学气体的刺激等。

说明：中医认为本病是由于“肺肾阴虚”所致，故取肺经络穴——列缺、配肺俞和肺之募穴——中府，再取肾经原穴——太溪、配肾俞和肾之募穴——京门，以补肺肾之阴虚；膈俞能提高人体的抗炎能力；天容、廉泉、天突均属局部取穴，通经活络、气血通畅、扶正祛邪，咽炎康复矣。

随症选穴：咳嗽加定喘、风门；恶心、干呕加内关，上脘。

慢性喉炎

慢性喉炎是长期声音嘶哑，喉部干燥不适为特征的慢性喉病。是喉粘膜的慢性炎症表现。多因急性喉炎治疗不当或反复发作转化而来，亦有长期发声过度，缓慢起病者。从事广播、教育、演艺等职业的人易患此病。某些具有刺激性的气体或粉尘及吸烟或饮酒过度等也常为本病的诱发因素。慢性喉炎的主要临床表现有语言声音低沉费力，讲话不能持久，甚者声音嘶哑，日久不愈，每因劳累或多讲话后症状加重，上午尤明显。多伴有喉部微痛不适，干痒喉痒，咳嗽痰少，或喉部有异物感。患者常有清嗓习惯，当“吭咯”动作后喉间自觉舒适。喉部检查，粘膜多有暗红色充血、肿胀或萎缩，声带肿胀肥厚，有小结节或息肉，声门闭合不良，喉部和声带常有痰涎附于其上。

本病属中医学的“慢喉暗”范畴，亦称久喑。多由肺脾肾虚损而致。凡素体虚弱或过劳病。肺肾阴虚，虚火上炎蒸灼于喉、声门失健；或久病脏腑失调，肺脾气虚，无以鼓动声门；或急喉暗余邪未清，结聚于喉；或发声过度，耗气伤阴，喉部脉络受损，导致气滞血瘀痰凝，夹声带肿胀或形成小结息肉，阻碍发声等，均可造成声音嘶哑而为喑。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、肺俞、脾俞、肾俞、天容。
2. 尺泽、中府、章门、京门、天突。

每日灸治1次，10次为1个疗程。疗程间休息2—3日。若有微痛时，可每日灸2次。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。若肺俞、脾俞、肾俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则效果更佳。

在治疗期间或治愈以后，吸烟者必须戒烟，饮酒者也应该戒之。特别注意不能长时间地高声演讲或高声歌唱。室内空气要湿润，避免劳累。

说明：本病中医认为由于“肺肾阴虚”和“肺脾气虚”所致，故取肺经合穴——尺泽、配肺之募穴——中府，再取脾经要穴——三阴交，肾经也相交于此，配脾俞和脾之募穴——章门，再配肾俞和肾之募穴——京门，以补“肺肾阴虚”和“肺脾气虚”；天容和天突属局部取穴，以疏通喉部脉络，以行气活血。

荨麻疹

荨麻疹是以身体突然出现局部性风疹块，忽隐忽现，剧烈瘙痒为特征的一种过敏性皮肤疾患，属患者自身免疫机制过强所致。俗语“鬼风疙瘩”。临床较常见，典型的症状表现是起病突然，初起身体皮肤作痒，搔之局部皮肤潮红，迅即出现红斑隆起，形如豆瓣，大小不等，境界清楚。皮疹发无定处，时起时落，可堆累成片。瘙痒剧烈并有灼热感，多于数小时后逐渐消退，不留痕迹。一般皮疹泛发全身，粘膜亦可受累，发于胃肠道可伴有恶心呕吐，腹痛腹泻等症状；发于呼吸道，可引起喉头

水肿，出现呼吸困难，甚至窒息。亦有伴发热、关节疼痛等症者。本病亦有急慢性之分。急性者一日内可发作数次，多于数天至两周左右停发。慢性者反复发作，时重时轻，可迁延数月或数年。

本病在中医学中属“隐疹”范畴，亦有“痞瘤”之称。多因禀赋不受，又食腥荤动风之物或饮食失节、过食辛辣，积湿生热，外发肌肤；或素体虚弱、卫表不固、感受风寒、风热之邪，郁于腠理，不得宣发；或久病伤阴动血，肌肤失养，血虚生风乃致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 列缺、风门、肺俞、脾俞、膈俞。
2. 血海、曲池、中府、章门、风市。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间可休1—3日。急性者每日灸治1—3次，可不分疗程。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若风门、肺俞、膈俞、脾俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更好。在治疗期间应少食或不食腥荤、辛辣之物。若呼吸困难者，应立即去医院抢救。

说明：中医认为本病为风邪作祟，故取风市、风门等穴。中医也认为“肺主皮毛”，本病属皮毛之病，故取肺经络穴——列缺，配肺俞和肺之募穴——中府，以固卫表；中医还认为“血虚生风”，故取脾经血海，配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾，使气血生化有源；膈俞为八会穴之一——血会，不仅有补血功效，且有调节免疫机制的作用。

随症选穴：恶心呕吐加内关、上脘；腹痛腹泻加足三里、天枢；发热加大椎、合谷；关节痛取局部腧穴灸之。

湿 疹

湿疹是一种过敏性炎性皮肤病，是患者自身免疫机制过强所致。临床较常见，具有皮损呈多形性，分布对称、瘙痒剧烈、反复不愈等特征。以头面、四肢远端、阴囊等处多见，亦可泛发全身。病变过程有急性、亚急性和慢性之分。急性湿疹起病急，自觉灼热瘙痒，有潮红、红疹、水疱、糜烂、渗出等多种皮损表现。如治疗不当或失治可发展成亚急性或慢性湿疹。皮损渗出较少，以丘疹、丘疱疹、结痂、鳞屑为主，有轻度糜烂面，颜色暗红，可见轻度浸润，瘙痒剧烈。慢性湿疹是因皮疹于某一部位经久不愈，反复发作所致。皮损局限，境界清楚，肥厚粗糙，或呈苔藓样变，颜色褐红或褐色，常伴丘疱疹、痂皮、抓痕。刺激易使之倾向湿润化。时轻时重，有阵发性瘙痒。

本病归属于中医学的“湿疮”范畴。根据疹发部位的不同分别有“旋耳疮”、“痂疮”、“四弯风”、“肾囊风”等名称。其发病常因饮食不节，过食腥发、辛辣动风之品，伤及脾胃，蕴湿生热，复感风湿、热邪，两邪相搏，充于腠理；浸淫肌肤所致，亦可由年老久病，血虚化燥生风、肌肤失养而成。

治疗：处方同荨麻疹的“治疗”。这是中医常

用的“异病同治”之法。因这两种病的病因学基本相同。

皮肤瘙痒症

皮肤瘙痒症是一种自觉瘙痒而没有原发性损害的皮肤病。本病的主要症状是身体有阵发性的瘙痒感，程度轻重不一，持续时间不等。可泛发全身，也可局限于某一部位，如肛门、会阴等处。本病初起并无皮肤损害，由于瘙痒剧烈，难以忍耐，反复搔抓，可引起各种继发性皮损，如抓痕、潮红、浮肿、血痂、色素沉着、苔癣样或湿疹样等。有时可继发感染。瘙痒而皮肤干燥的多见于老年人或久病之人。瘙痒而继发湿疹样变的多见于青壮年。本病若长期不愈，往往易引起患者精神变化，如失眠、神经衰弱等。

皮肤瘙痒症与中医的“痒风”、“隐疹”相类似，多因年老久病，血虚生风，肌肤失养；或风湿、热邪蕴于肌肤，不能疏泄所导致。

治疗：同荨麻疹的“治疗”。

银屑病

银屑病是一种常见的红斑鳞屑性皮肤病。以皮肤上起红色斑体，上覆多层白色皮屑，抓去皮屑可见薄膜及点状出血为特征。可发生于任何年龄，但以青壮年多见。本病起病缓慢。初起皮损为针尖至扁豆大小的红色丘疹，瘙痒剧烈，多呈点滴状分

布，逐渐扩大，部分融合成片，上覆银白色多层性鳞屑，境界清楚，状如云母，搔抓后鳞屑脱落，可露出淡红色半透明的光滑薄膜并伴有点状出血。静止期的皮损可呈斑块状或地图状等。皮疹好发于头皮和四肢肘膝关节伸侧，多呈对称分布，亦可泛发全身。少数病人可有指甲病变，轻者呈点状凹陷，重者甲板增厚，光泽消失。个别患者有口腔及阴部粘膜病变。皮疹发于头皮的可见束状头发。此外，还有一些特殊型鳞屑病。如继发全身弥漫性皮肤潮红，大量脱屑伴发热者为银屑病性红皮症；皮损部有脓疱渗出，附湿性鳞屑者为脓疱性银屑病；若合并关节疼痛者为银屑病性关节炎。本病病程较长，易复发，有明显季节性。一般冬重夏轻。有家族史。本病近年来大多数学者认为与免疫功能障碍有关。

银屑病旧称“牛皮癣”，属中医学中的“白疔”和“疮风”范畴。多因情志内伤，气郁化火，火热之邪深伏营血，或过食辛腥动风之品，脾胃失和，湿热内蕴，复感风热毒邪，风热血燥，蕴于肌肤，不得宣泄而致。亦可因年老久病，气血不足，血虚生风，肌肤失养而成。

治疗：处方与治疗方法同“荨麻疹”的“治疗”。但是病程较长者，需要10个疗程以上的治疗。

神经性皮炎

神经性皮炎的病因尚不清楚，一般认为是脑皮层兴奋和抑制功能失调有关。本病以皮肤粗糙肥厚，呈苔癣样变和阵发性剧烈瘙痒为特征。本病初起仅有皮肤作痒，经搔抓后出现丘疹，疹色淡红或正常，皮肤逐渐粗糙、增厚、纹理加深，形成苔癣样变，并有少量鳞屑、抓痕及血痂，甚至皮损如牛项之皮，顽硬中坚，抓之如枯木，瘙痒剧烈。本病皮损为局部性，好发于项部、眼睑、肘膝及腰背。骶髂等部位，多呈对称分布或线状排列。散播性可泛发全身。本病好发于成年人，尤多见于神经衰弱患者，一般病程较长。本病常因精神紧张、过度疲劳、日晒、多汗、饮酒而促发。

神经性皮炎在中医学中属“摄领疮”范畴，多因情志不适，肝郁化火，凝滞于肌肤，化燥生风，或饮食失节，脾蕴湿热，复感风邪，蕴阻肌肤；或年老久病，阴血亏虚，血虚生风所致。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 太冲、风门、肺俞、膈俞、肝俞。
2. 尺泽、风市、中府、风池、期门。

每日灸治1次，10次为1个疗程，疗程间可休息2—3日。症状较重者可每日灸2次，不分疗程，待好转后，再按疗程灸之。诸穴均可采用温和灸或隔姜灸。若风门、肺俞、膈俞、肝俞采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更好。

本病在治疗期间和治愈以后，更避免精神紧张、过劳、日晒等，更要戒酒。

说明：取肝经原穴——太冲，配肝俞和肝之募穴——期门，以舒肝气；因“肺主皮毛”，故取肺经合穴——尺泽，配肺俞和肺之募穴——中府，以祛客于“皮毛”之风邪；风池、风门、风市，均是祛风之要穴；膈俞为八会穴之一——血会，有补血作用。血不虚风自息。

随症选穴：若失眠加安眠穴；心烦加内关；头晕、头痛加太阳、百会。

带状疱疹

带状疱疹是以成簇水泡沿身体一侧呈带状分布，疼痛剧烈为特征的一种急性疱疹性皮肤病。是由病毒感染所引起，临床较常见。本病可发于任何年龄，但主要见于成年人。皮疹出现前，病人常先有皮肤感觉过敏、或灼热刺痛感。可伴有周身轻度不适、发热、乏力、食欲不振等症状。以后皮肤出现红斑，继则出现绿豆大小的水疱，簇集成群，常沿一定的外围神经走行分布，尤以肋部和腰部多见。水疱疱壁紧张，甚底色红，疱群之间皮肤正常。轻者水疱较少，分布形状不典型，自觉疼痛明显；重者皮损表现为血性，或有坏疽性损害，患者常有难以忍受的剧痛，发于头面者病性往往较重。皮疹多于10日后开始干燥、结痂，消退后一般不留瘢痕。坏疽样损害可遗留疤痕。部分病人疹退后

可遗留神经疼痛。

因本病疱疹多呈带状排列宛如蛇行，故在中医学中称为“蛇串疮”。因好发于腰部，故又有“缠腰火丹”之称谓。凡情志不遂，肝郁化火，或饮食失调，脾失健运，使肝脾内蕴湿热兼感邪毒，湿热毒邪熏灼肌肤脉络则发为本病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 三阴交、肺俞、肝俞、脾俞、膈俞。
2. 尺泽、中府、期门、章门、阿是穴。

每日灸治2次，不必分疗程，治愈后再灸5—7日，以防留有后遗症。阿是穴是指带状疱疹的“带状”两端。诸穴均可采取温和灸或隔姜灸。若肺俞、膈俞、肝俞、脾俞，采用隔蒜灸或瘢痕灸，则疗效更好。若疱疹破溃，应涂龙胆紫药水或消炎药膏。

说明：三阴交为肝、脾、肾三阴交会之穴，配肝俞和肝之募穴——期门，以舒肝理气；三阴交配脾俞和脾之募穴——章门，以健脾化湿、清热；“肺主皮毛”，尺泽为肺经合穴，配肺俞和肺之募穴——中府，以清利“皮毛”湿热之毒；膈俞有抗炎作用；阿是穴一方面清患处之湿热，二能防止毒邪蔓延。

随症选穴：胁痛甚时加外关；发热加大椎、曲池。

痤疮

痤疮是发生于毛囊、皮脂腺的慢性炎症，是男女青春期常见的皮肤病。以丘疹、脓疱、结节及粉刺为特征。主要表现是在患者颜面、前胸或后背等皮脂腺分布较多的部位呈现多形性皮损，初起为针尖或小米粒大小的红色丘疹，亦可演变为脓疱，以后可形成白头或黑头粉刺，可挤出如白色粹米样粉汁，严重者可形成硬节性囊肿和瘢痕，常伴皮脂溢出。患者自觉症状较轻，可伴有潮红、瘙痒、口臭、喜冷饮、便秘等。病程长短不一，多于成年后自愈。本病病因较复杂，与遗传雄性激素分泌增加，毛囊的细菌及微生物作用以及消化功能紊乱等多种因素有关，此外过食辛甘厚味，使用化妆品不当等，也可促使本病的发生和发展。

本病在中医学中有“肺风粉刺”、“面疱”、“酒刺”等名称。多为饮食不节，过食肥甘辛辣、肺胃蕴湿生热，复感风邪，郁于肌表而发病。

治疗：处方分两组，交替灸之。

1. 尺泽、膈俞、肺俞、胃俞。
2. 足三里、合谷、中府、中脘。

每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间休息3—5日。诸穴均可采用温和灸或雀啄灸或隔姜灸。若肺俞、膈俞、胃俞采用瘢痕灸，则效果更佳。

说明：取肺经合穴——尺泽，配肺俞和肺之募穴——中府，再取胃经合穴——足三里，配胃俞和胃之

募穴——中脘以清“肺胃蕴热”；膈俞能调节内分泌，以抑制雄性激素分泌过多；《四总穴歌》曰：“面口合谷收”，痤疮多生于面部，所以取合谷。

随症取穴：背部有痤疮者加委中；胸部有痤疮者加内关。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=灸法养生

作者=顾悦善 郝学君主编

页数= 2 4 7

S S 号= 1 0 2 6 5 8 1 9

出版日期= 1 9 9 6 年 0 8 月第 1 版